

Questão 1

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Risco Cirúrgico Avaliação de Risco

Mulher, 44 anos, procura avaliação pré-operatória para videocolecistectomia programada para próxima semana. Refere ser hipertensa em uso regular de antihipertensivo, apresenta peso 75 Kg, 1,65m de altura e pressão arterial 120x80mmHg. Nega qualquer outra comorbidade e apresenta exames laboratoriais normais. Qual sua classificação de acordo com a American Society of Anesthesiologists (ASA)?

- A ASA I
- B ASA II
- C ASA III
- D ASA IV

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214057](#)

Questão 2

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Jejum Préoperatório

J.J., 45 anos, em consulta pré-anestésica para uma cirurgia de colecistectomia, estabeleceu-se no protocolo multimodal de cuidado perioperatório, que no período de jejum estipulado para cirurgia seguisse rigorosamente as recomendações. Qual dessas recomendações abaixo se enquadra nessa situação desse paciente associada com seu respectivo tempo limite de ingesta antes do início do procedimento?

- A Balas e pirulitos sem leite - 02 horas.
- B Água, chá, café e maltodextrina - 02 horas.
- C Leite e derivados contendo carboidratos - 03 horas.
- D Proteínas do soro do leite com caseína e carboidratos - 02 horas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214063](#)

Questão 3

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Analgesia Perioperatória Opioides

Um paciente foi submetido a uma cirurgia abdominal de grande porte e, no pós-operatório, apresenta dor intensa. A analgesia pós-operatória adequada é essencial para controlar a dor, reduzir a ação do sistema nervoso simpático além de prevenir a cronificação desta dor. Qual das alternativas a seguir representa a melhor prática para manejo de dor pós-operatória em pacientes de risco e que pode, inclusive, contribuir para uma recuperação mais rápida e segura?

- A Utilizar apenas analgésicos comuns, como paracetamol e dipirona, evitando opioides, independentemente da intensidade da dor, para minimizar efeitos colaterais.
- B Administrar opioides de maneira contínua em altas doses, sem alternância de analgésicos, para garantir um efeito analgésico prolongado e eficiente.
- C Optar pela analgesia multimodal, que combina diferentes classes de analgésicos (como AINEs, opioides e analgésicos locais), ajustando a dose conforme a necessidade do paciente.
- D Realizar analgesia exclusivamente por via intravenosa, sem considerar outras vias de administração, para facilitar o controle da dosagem e garantir melhor biodisponibilidade.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000241799

Questão 4

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Opioides

Homem, 55 anos, diabético controlado, submetido a cirurgia ortopédica de grande monta e com grande dor pós operatória (9/10 na escala de dor). Você opta pela administração de Morfina ao doente. Qual a melhor via de administração para o caso?

- A Oral;
- B Subcutâneo;
- C Intramuscular;
- D Endovenoso

4000214061

Questão 5

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Conduta Diagnóstico

Um paciente idoso submetido a uma laparotomia exploradora apresenta, no décimo dia de pós-operatório, drenagem de líquido claro de cor salmão e sensação de queimação na ferida cirúrgica. Após retirada de um dos pontos da incisão, verifica-se parede de alça entre os bordos da aponeurose. Qual das condutas é a mais adequada para tratar essa complicação?

- A Aumentar a abertura da ferida para melhorar a drenagem e antibiótico profilático.
- B Sutura imediata da pele da incisão e monitorar a evolução da ferida.
- C Realizar exploração local no centro cirúrgico e reforço da aponeurose.
- D Curativo oclusivo estéril e aguardar fechamento por segunda intenção.

4000241804

Questão 6

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Um paciente masculino, 62 anos, hipertenso, diabético, tabagista, encontra-se no pós-operatório de cirurgia de gastrectomia total + linfadenectomia D2 + reconstrução em Y de Roux, devido a um adenocarcinoma de corpo gástrico com estadiamento clínico cT2 N0 M0. No primeiro dia de pós-operatório apresenta febre de 38,7°C associado a tosse seca e redução do murmúrio vesicular bibasais. No entanto, mantém-se normocárdico, hemodinamicamente estável, com abdome flácido e dreno de débito serohemático. Já no 2º dia de pós-operatório, cursa com distensão abdominal, ruídos hidroaéreos ausentes, eructações e náuseas, com melhora apenas no 4º dia de pósoperatório, quando passa a eliminar flatos e fezes no 6º dia pós-operatório há mudança no aspecto do conteúdo do dreno, passando a ser bilioso. Paciente persiste hemodinamicamente estável. Realiza tomografia computadorizada de abdome com contraste endovenoso e via oral não sendo evidenciado extravasamento do contraste entérico ou coleções intra-abdominais; além disso, mantém exames laboratoriais apenas com Proteína C Reativa elevada. Sobre o caso clínico acima, assinale as complicações pósoperatórias apresentadas no 1º, 2º e 6º dias, respectivamente, bem como seu tratamento.

- A Pneumonia: antibioticoterapia + corticoterapia íleo metabólico: antibioticoterapia + sonda nasogástrica + dieta zero. Fístula de coto duodenal: reabordagem cirúrgica
- B Pneumonia: antibioticoterapia; íleo adinâmico: dieta zero, hidratação venosa com aporte basal de glicose, deambular, Fístula de anastomose esôfago-jejunal: reabordagem cirúrgica
- C Atelectasia: antibioticoterapia íleo adinâmico: dieta zero, hidratação venosa com aporte basal de glicose, deambular, Fístula de ansatomose esôfago-jejunal: tratamento conservador
- D Atelectasia: melhora de analgesia, fisioterapia motora e respiratória, mobilização fora do leito Íleo adinâmico: dieta zero, hidratação venosa com aporte basal de glicose, deambular Fístula de coto duodenal: tratamento conservador

4000214064

Questão 7

2026

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Conduta e Tratamento

Homem, 58 anos, submetido a duodenopancreatectomia cefálica por adenocarcinoma de cabeça de pâncreas. No 3º dia pós-operatório, está hemodinamicamente estável. PA 120/70 mmHg, FC 90 bpm, FR 20 irpm, Temp 37,4 °C. Dreno de sucção em loja pancreática com débito de 150 mL/dia de líquido claro. Amilase no líquido de dreno: 2.000 U/L (VR sérica: 25-125 U/L). Qual a interpretação e conduta mais adequadas em relação ao dreno?

- A Considerar como fístula pancreática pós-operatória e manter dreno para drenagem e orientação, com suporte clínico e vigilância
- B Retirar o dreno, pois o débito é baixo e o líquido é claro
- C Pinçar o dreno por 24 h e, se não houver febre, retirá-lo
- D Manter o dreno indefinidamente, independentemente da evolução clínica

4000271592

Questão 8

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Definição de Síndrome Compartimental Abdominal e Hipertensão Intraabdominal

Alterações Fisiológicas da Síndrome Compartimental Abdominal Tratamento da Síndrome Compartimental Abdominal

Paciente de 62 anos, submetido a uma laparotomia exploradora por isquemia mesentérica, evolui, no segundo dia de pós-operatório, com aumento da distensão abdominal, oligúria, dificuldade ventilatória com elevação da pressão de vias aéreas e acidose metabólica progressiva. O exame físico revela abdome tenso e doloroso. A pressão intra-abdominal medida via cateter vesical é de 24 mmHg. Qual é o diagnóstico e a conduta mais indicada?

- A Síndrome compartimental abdominal; realizar descompressão cirúrgica.
- B Íleo adinâmico; manter tratamento clínico conservador.
- C Isquemia mesentérica recorrente; hidratação venosa vigorosa.
- D Sepses abdominal; iniciar antibióticos de amplo espectro.

4000241812

Questão 9

2025 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Cicatrização Anormal das Feridas Fatores Sistêmicos Fase Proliferativa

Um paciente idoso com insuficiência renal crônica apresenta uma úlcera crônica em membro inferior com secreção purulenta, edema local e sinais de inflamação. A biópsia da lesão mostra níveis elevados de MMP (metaloproteinases de matriz) e baixos níveis de seus inibidores (TIMP). Qual é o impacto dessa desregulação no processo de cicatrização da ferida?

- A Aumento da deposição de colágeno, favorecendo a cicatrização.
- B Diminuição da degradação de colágeno, causando fibrose.
- C Excesso de degradação da matriz extracelular, comprometendo a cicatrização.
- D Supressão da resposta inflamatória, favorecendo a cronicidade da lesão.

4000241811

Questão 10

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Exame Físico e História Clínica Anatomia da Região Inguinal Fisiopatologia

Paciente masculino, 59 anos, hipertenso e diabético, servente de obras, passou a notar abaulamento em região inguinal a direita, associado a dor local, sempre que realizava esforço físico durante o trabalho. Procurou unidade básica de saúde e ao exame físico foi detectado que estava com hérnia inguinal a direita. Em relação à classificação das hérnias inguinais, assinale a alternativa correta:

- A Hérnias inguinais diretas atravessam o canal inguinal pelo anel inguinal profundo, acompanhando o cordão espermático.
- B Hérnias inguinais indiretas são causadas por enfraquecimento da parede posterior do canal inguinal e ocorrem exclusivamente em adultos.
- C Hérnias inguinais indiretas ocorrem lateralmente aos vasos epigástricos inferiores e são mais comuns em adultos devido ao fechamento incompleto do processo vaginal.
- D Hérnias inguinais diretas surgem medialmente aos vasos epigástricos inferiores, devido ao enfraquecimento da musculatura da parede abdominal.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000241805

Questão 11

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Complicações das Hernioplastias

Paciente de 50 anos, sem comorbidades, recentemente se submeteu a uma cirurgia de herniorrafia inguinal direita por sedação e bloqueio local com alta no mesmo dia. No 4º dia de pós-operatório, apresentou cefaleia e dor localizada na face interna da coxa e região inguinal ipsilateral. Diante do exposto acima, qual condição abaixo explica a evolução do pós-operatório?

- A Resposta normal do corpo à cirurgia e não indica necessariamente uma infecção.
- B Reação alérgica aos medicamentos administrados durante a cirurgia.
- C Hematoma ou infecção do sítio cirúrgico
- D Infecção do trato urinário.

4000214062

Questão 12

2025 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)

Exame Físico e Complementar Hérnia Complicada Classificação de Nyhus

Uma mulher de 70 anos é admitida no hospital após uma queixa de dor abdominal na região inferior do abdômen direito. Ao exame físico, é observada uma protuberância palpável abaixo do ligamento inguinal, que aumenta com a tosse e diminui ao ser deitada. A paciente relata que a dor está presente há cerca de 24 horas e piora ao se mover, mas não há histórico de vômitos ou náuseas. A paciente não apresenta sinais de septicemia ou distensão abdominal. Qual o diagnóstico mais provável?

- A Hérnia inguinal indireta.
- B Hérnia femoral encarcerada.
- C Hérnia inguinal direta.
- D Hérnia epigástrica estrangulada.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000241798

Questão 13

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMTT Acesso Direto (R1) Privado
Hérnia Complicada Hérnias Complicadas

Homem de 67 anos, com hérnia inguinal direita conhecida, apresenta dor abdominal difusa, vômitos fecaloides e parada de eliminação de flatos há 24 horas. Exame: pressão arterial 92/58 mmHg, frequência cardíaca 120 bpm, temperatura 38,2 °C. Abdome distendido, doloroso, com defesa em hipogástrio. Hérnia inguinal direita irreduzível e muito dolorosa. Laboratório: leucócitos 18.500/mm³ (VR: 4.000-11.000), lactato 4,1 mmol/L (VR: 0,5-2,2). Qual é a conduta imediata mais apropriada?

- A Tomografia computadorizada de abdome para avaliar viabilidade de alça intestinal
- B Laparotomia de urgência para alívio da obstrução e avaliação de viabilidade intestinal
- C Redução manual sob sedação em centro cirúrgico seguido de observação clínica em leito de UTI.
- D Tratamento conservador com sonda nasogástrica, seguido de reavaliação

4000271588

Questão 14

2024 Processo Seletivo Unificado - PRMTT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)
Avaliação Inicial

Você está em uma ambulância do SAMU, e, enquanto se dirigem para a base após uma ocorrência, observam o acontecimento de um acidente automobilístico (colisão motoXcarro), em uma via com alto fluxo de automóveis, onde o motociclista após a queda encontra-se ensanguentado e com sangramento ativo visível em sua perna. Qual a primeira conduta?

- A Assegurar a segurança do local para proteger o paciente e equipe;
- B Estabilizar/Proteger coluna cervical e verificar via aérea;
- C Verificar respiração e instalar oxímetro de pulso;
- D Estancar sangramento em perna.

4000214054

Questão 15

2025 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMTT
Avaliação e Manejo Inicial das Vias Aéreas Introdução Le Fort

Um homem de 34 anos é trazido ao pronto-socorro após um acidente de moto em alta velocidade. Ele apresenta-se inconsciente, com resposta motora localizada à dor (Escala de Coma de Glasgow 8), e respira de forma ruidosa, com esforço inspiratório evidente. Ao exame físico, observa-se trauma facial com sangramento nasal e sinais de fratura maxilofacial (fratura Le Fort I), a ausculta revela sons respiratórios presentes bilateralmente. A saturação de oxigênio está em 84% com oxigênio suplementar por máscara facial. Qual é a abordagem mais apropriada para manejo das vias aéreas deste paciente, considerando o protocolo ATLS?

- A Realizar uma intubação nasotraqueal com orientação de fibroscopia para evitar trauma adicional à via aérea.
- B Iniciar uma cricotireoidostomia imediatamente, devido ao alto risco de obstrução de via aérea.
- C Realizar intubação orotraqueal com sequência rápida de intubação, com estabilização manual da coluna cervical.
- D Optar pela máscara laríngea como medida temporária até a estabilização do quadro neurológico.

4000241809

Questão 16

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Cricotireoidostomia por Punção

Um paciente sofreu um trauma facial grave em um acidente de carro e está com múltiplas fraturas dentárias, ferida contusa na língua e fratura de Le Fort 3. A equipe médica indica em caráter de urgência uma via aérea alternativa. Qual o procedimento técnico cirúrgico indicado nessa circunstância?

- A Sutura do ferimento da língua e intubação orotraqueal.
- B identificar e incisar sobre a membrana cricotireoidea
- C imobilizar a laringe e incisão na incisura tireóide superior
- D identificar e incisar sobre a membrana tireohioidea

4000214060

Questão 17

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Pneumotórax Simples

Paciente masculino, 35 anos, deu entrada no pronto socorro devido a ferimento com arma branca em região torácica anterior a direita, após confronto em um bar, apresentando taquipneia associada a desconforto respiratório. Ao exame físico, observou-se murmúrio vesicular quase abolido a direita, hipertimpanismo à percussão. Com diagnóstico clínico de pneumotórax, este paciente teve o seu hemitórax direito drenado sob selo d'água. Em relação à inserção e manejo do dreno de tórax, especialmente em pacientes com pneumotórax, assinale a alternativa correta:

- A O dreno deve ser inserido preferencialmente no quinto espaço intercostal, na linha medio-clavicular, para otimizar a drenagem de ar e líquidos.
- B Após a inserção do dreno de tórax, é importante mantê-lo permanentemente em aspiração negativa, independentemente do tipo de derrame pleural, para evitar recidiva.
- C Alguns critérios são levados em consideração para a retirada do dreno de tórax, tais como seu débito e aspecto, presença ou não de escape aéreo e avaliação da reexpansão pulmonar.
- D O dreno de tórax apenas deve ser removido assim que o seu débito estiver zerado, para evitar complicações infecciosas.

Questão 18

2026

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Pneumotórax Hipertensivo

Paciente, 10 anos de idade, com quadro de insuficiência respiratória aguda grave, é intubado com tubo orotraqueal número 6,0 com balonete e fixado em 16 cm. Alguns minutos após intubação, nota-se queda de saturação até 82%, hipotensão, expansibilidade assimétrica, ausculta pulmonar com ausência de murmúrio vesicular no hemitórax direito e desvio da traqueia para esquerda. Qual a conduta a ser adotada?

- A Tracionar o tubo devido intubação seletiva até que se ouça murmúrio vesicular bilateralmente
- B Realizar toracocentese de alívio em hemitórax direito devido pneumotórax hipertensivo
- C Retirar o tubo e ventilar com dispositivo BVM devido extubação acidental
- D Solicitar RX de tórax e avaliação da cirurgia pediátrica para drenagem de tórax

Essa questão possui comentário do professor no site 4000271573

Questão 19

2026

Privado

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Tamponamento Cardíaco

Adolescente de 14 anos é atendido após agressão com arma branca na região precordial. Chega à sala de emergência com rebaixamento do nível de consciência, taquicardia, hipotensão e extremidades frias. Ao exame físico, observa-se turgência jugular importante, bulhas cardíacas hipofonéticas e taquipneia. Não se identificam assimetrias evidentes de expansibilidade torácica. A percussão, o tórax apresenta som claro bilateralmente, com murmúrio vesicular preservado, sem timpanismo localizado. Qual hipótese diagnóstica está mais de acordo com o quadro descrito?

- A Choque hipovolêmico por hemotórax maciço unilateral
- B Pneumotórax hipertensivo direito
- C Tamponamento cardíaco traumático
- D Contusão pulmonar bilateral grave com insuficiência respiratória aguda

4000271582

Questão 20

2024

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Trauma Abdominal Fechado

Paciente homem de 35 anos, é admitido no pronto-socorro após sofrer um acidente de trânsito. Ele estava dirigindo seu carro quando colidiu frontalmente com outro veículo em alta velocidade. O paciente estava usando cinto de segurança no momento do acidente e apresenta uma equimose no andar superior do abdome. No momento com dor abdominal intensa, descompressão brusca positiva. Ao exame: regular estado geral, Glasgow de 15, hipocorado ++/4+, PA: 80x40 mmHg, FC: 132 bpm, FR: 27irpm. As vias aéreas se

encontravam p rvias, expansibilidade encontrava-se preservada e n o havia altera  es na palpa  o e percuss  o. Com base no quadro cl nico descrito, qual   a conduta imediata para o paciente?

- A Videolaparoscopia de urg ncia.
- B Laparotomia exploradora aberta.
- C Tomografia de abdome sem contraste.
- D Intuba  o orotraqueal com lavado peritoneal.

Essa quest  o possui coment rio do professor no site [4000214065](#)

Quest  o 21

2025 Resid ncia (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Trauma Abdominal Penetrante

Um paciente chega ao pronto-socorro ap s sofrer uma facada na regi o anterior do abdome. Ele apresenta-se hemodinamicamente est vel, sem sinais de choque, peritonite ou eviscera  o. Ap s explora  o local da ferida,  poneurose  ntegra e os achados s o negativos para poss vel les o intra-abdominal. Qual   a conduta mais adequada?

- A Sutura da ferida e alta domiciliar, pois o paciente est  est vel e sem sinais de peritonite.
- B Realizar uma laparotomia explorat ria imediata para avalia  o de les es internas.
- C Admitir o paciente para observa  o UTI com exames f sicos seriados e valor de hemoglobina a cada 8 horas.
- D Realizar uma tomografia computadorizada abdominal para excluir outras les es internas.

Essa quest  o possui coment rio do professor no site [4000241810](#)

Quest  o 22

2026 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Resid ncia (Acesso Direto)

Trauma Espl nico

Homem de 31 anos, v tima de ferimento por arma branca em epig strio h  90 minutos. Chega consciente, hemodinamicamente est vel. Press o arterial 124/82 mmHg, frequ ncia card aca 96 bpm, satura  o de oxig nio 98% em ar ambiente. Abdome com dor localizada em epig strio, sem rigidez e sem sinais de peritonite difusa. Ultrassonografia focada para trauma mostra pequena l mina l quida periespl nica. Hemoglobina 13,1 g/dL (VR: 13-17). Qual   o pr ximo passo mais adequado?

- A Observa  o seriada por 24 horas com alta programada se est vel
- B Laparoscopia diagn stica como primeira abordagem
- C Tomografia computadorizada de abdome com contraste
- D Laparotomia exploradora imediata

4000271587

Questão 23

2024

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Tratamento

O princípio mais importante das grandes ressecções hepáticas é o controle vascular do inflow e outflow, sendo a manobra de Pringle a mais conhecida. Quais estruturas estão envolvidas na manobra de Pringle?

- ☐ A Veia cava, veia porta e artéria hepática;
- ☐ B Colédoco, veia porta, artéria hepática;
- ☐ C Veia cava e artéria hepática;
- ☐ D Artéria cística, ducto cístico e veia cava.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214067](#)

Questão 24

2024

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Residência (Acesso Direto)

Síndrome do Esmagamento Rabdomiólise Traumática

Paciente de 13 anos vítima de soterramento dá entrada na emergência pediátrica consciente, com múltiplas escoriações e fratura exposta de perna direita. Além dos cuidados iniciais de atendimento ao paciente vítima de trauma, deve ser investigado o seguinte distúrbio hidroeletrólítico:

- ☐ A hiponatremia
- ☐ B hipercalemia
- ☐ C hipomagnesemia
- ☐ D hiperfosfatemia

4000214019

Questão 25

2025

Acesso Direto (R1)

Privado

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Mecanismo de Trauma

Escala de Coma de Glasgow

Escala de Coma de Glasgow

Menino de 8 anos é trazido ao pronto-atendimento pelo SAMU após atropelamento com arremesso de cerca de 10 metros. Perdeu a consciência imediatamente, mas mantinha respiração espontânea. No exame físico, apresenta: FC 140 bpm, FR 33 irpm, tempo de enchimento capilar (TEC) de 3 segundos. Cabeça com contusão em região frontal. No exame neurológico, balbucia sons incompreensíveis, localiza a dor, mas não abre os olhos aos estímulos dolorosos. Membros com deformidade na coxa direita. Qual a classificação do comprometimento neurológico e a conduta em relação à via aérea?

- A ECG 6; máscara laríngea
- B ECG 8; intubação traqueal
- C ECG 9; cateter de oxigênio a 5 L/min
- D ECG 11; máscara de oxigênio não reinalante

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241734](#)

Questão 26

2025 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)
Exames Complementares Classificação e Manifestações Clínicas

Lactente do sexo feminino, 10 meses, 9 kg, sofreu queda de aproximadamente 60 cm da cama enquanto dormia. Foi levado à emergência com relato de choro intenso após a queda e 1 episódio de vômito. Os pais negaram perda de consciência ou outras queixas. Ao exame, observa-se hematoma frontal. Diante desse cenário, a realização de tomografia de crânio:

- A É indicada devido ao hematoma frontal.
- B É indicada devido ao episódio de vômito.
- C É indicada devido à altura da cama ser superior a 60 cm.
- D Não é indicada conforme o protocolo pecarn.

4000241714

Questão 27

2024 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)
Estimativa da Superfície Corpórea Queimada e Circulação

Paciente 6 anos, 28 Kg, sofre acidente grave por queimadura de 2º e 3º. Grau em face, tórax e membros com estimativa de 55% de superfície corporal queimada. Assinale a alternativa com o volume de hidratação venosa a ser prescrito pela fórmula de parkland.

- A 6160 ml
- B 1540 ml
- C 1320 ml
- D 9240 ml

4000214005

Questão 28

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Apendicite Aguda Complicada

Homem de 29 anos, previamente hígido, procura pronto-socorro com dor em fossa ilíaca direita há 7 dias, febre diária e anorexia. Refere melhora parcial da dor nos últimos 2 dias. Exame: pressão arterial 122/78

mmHg, frequência cardíaca 94 bpm, temperatura 38,1 °C. Abdome com massa palpável dolorosa em fossa ilíaca direita, sem sinais de peritonite difusa. Laboratório: leucócitos 15.400/mm³ (VR: 4.000-11.000), proteína C reativa 12 mg/dL (VR: < 0,5). Tomografia computadorizada de abdome com contraste mostra coleção pericecal de 6,5 cm com gás no interior, compatível com abscesso. Qual é a conduta inicial mais apropriada?

- A Apendicectomia laparoscópica imediata com lavagem da cavidade
- B Ressecção ileocecal com anastomose primária pois se trata de apendicite complicada com abscesso.
- C Antibioticoterapia venosa associada à drenagem percutânea da coleção e apendicectomia de intervalo após resolução
- D Apendicectomia aberta convencional imediata com lavagem da cavidade.

4000271591

Questão 29

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Tratamento Cirúrgico Quando Indicar

Mulher de 44 anos, obesa, apresenta dor em hipocôndrio direito há 18 horas, contínua, irradiando para dorso, com febre e vômitos. Relata episódios prévios de cólica biliar. Exame: pressão arterial 114/70 mmHg, frequência cardíaca 102 bpm, temperatura 38,3 °C. Sinal de Murphy presente. Leucócitos 14.900/mm³ (VR: 4.000- 11.000). Ultrassonografia evidencia cálculo impactado em colo vesicular, espessamento parietal e líquido perivesicular. Qual é o melhor tratamento definitivo para esse quadro?

- A Antibioticoterapia venosa e colecistectomia eletiva em 6 a 8 semanas
- B Colecistectomia laparoscópica precoce durante a mesma internação, após antibioticoterapia inicial
- C Colecistostomia percutânea seguida de colecistectomia eletiva após melhora clínica
- D Drenagem endoscópica por CPRE seguida de colecistectomia eletiva

4000271590

Questão 30

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Manifestações Clínicas e Exame Físico Diagnóstico Diferencial Diagnóstico

Paciente feminina, 42 anos, obesa, hipertensa, iniciou quadro de dor abdominal em hipocôndrio direito, associado a náuseas, vômitos e há 01 dia, seu esposo passou a notar que ela estava ficando amarelada. Após 3 dias do início do quadro acima, passou a apresentar febre acima de 38,7°C, quando procurou atendimento de urgência. Realizou exames laboratoriais evidenciando hiperbilirrubinemia as custas de bilirrubina direita, elevação de enzimas canaliculares, elevação de marcadores inflamatórios, e realizou ultrassonografia de abdome que evidenciou colelitíase e coledocolitíase. Em relação ao diagnóstico e manejo da colangite aguda, assinale a alternativa correta:

- A O tratamento inicial da colangite inclui antibioticoterapia de amplo espectro, drenagem biliar e suporte hemodinâmico;
- B A colangite aguda geralmente não requer tratamento com antibióticos, sendo indicada apenas a drenagem biliar imediata.
- C A triade de Charcot (febre, dor abdominal e icterícia) está presente em todos os casos de colangite e é suficiente para confirmar o diagnóstico.
- D A ultrassonografia é sempre suficiente para confirmar o diagnóstico de colangite, dispensando a necessidade de exames complementares, como a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE).

4000241801

Questão 31

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Diagnóstico Manifestações Clínicas e Exame Físico Diagnóstico Diferencial

Um paciente de 55 anos, atendido em centro de referência com histórico de coledocolitíase, apresenta febre, dor no quadrante superior direito e icterícia leve. Os exames laboratoriais mostram leucocitose e elevação da fosfatase alcalina. A tomografia computadorizada revela uma lesão hipoatenuante no lobo direito do fígado. Considerando a etiologia provável e o manejo inicial, qual seria o próximo passo adequado para o tratamento neste serviço?

- A Iniciar antibióticos de amplo espectro e agendar drenagem cirúrgica aberta.
- B Realizar drenagem percutânea guiada por imagem e antibioticoterapia de amplo espectro.
- C Iniciar terapia com antifúngicos devido ao risco de infecção por *Candida* sp.
- D Manter antibióticos orais e observação clínica para monitorar a resolução espontânea.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241813](#)

Questão 32

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Tratamento da Diverticulite Complicada

Paciente do sexo masculino, 68 anos, obeso (IMC 33 kg/m²), diabético tipo 2 e hipertenso, da entrada no pronto-socorro com história de dor abdominal em fossa ilíaca esquerda (FIE) há 3 dias, de início insidioso e piora progressiva. Refere febre não aferida e calafrios. Nega sangramento retal. Relata dois episódios semelhantes nos últimos 3 anos, tratados com antibióticos via oral em regime ambulatorial, com melhora. Ao exame físico: Regular estado geral, fácies de dor, desidratado (+/4+). PA 100/60 mmHg, FC 118 bpm, FR 22 irpm, Tax 38,9°C. Abdome: Distendido, ruídos hidroaéreos diminuídos. Doloroso à palpação profunda difusamente, com nítida plora em FIE, onde se palpa uma massa de limites imprecisos. Há sinais de peritonite localizada em FIE (descompressão brusca positiva apenas neste quadrante), sem defesa ou contratura voluntária em outros quadrantes. Exames Laboratoriais: Leucócitos: 21.500/mm³ (com 18% de bastões); Creatinina: 1,8 mg/dl (Valor de referência: 0,7-1,2 mg/dL); PCR: 220 mg/L. Tomografia Computadorizada de Abdome e Pelve (com contraste): Espessamento da parede do cólon sigmóide com densificação da gordura

pericólica. Múltiplos divertículos no segmento. Presença de uma coleção líquida bem definida, com realce anelar periférico, medindo 8 cm x 7 cm, localizada na pelve, adjacente ao fundo de saco retovesical. Ausência de pneumoperitônio ou líquido livre em grande quantidade. Considerando o quadro acima, qual é a conduta imediata mais adequada para este paciente?

- A Laparotomia exploradora de urgência com procedimento de Hartmann (sigmoidectomia, colostomia terminal e fechamento do coto retal).
- B Internação hospitalar, hidratação venosa, antibioticoterapia de amplo espectro (IV) e drenagem percutânea da coleção guiada por tomografia.
- C Colonoscopia de urgência para descartar neoplasia obstrutiva e realizar descompressão colônica, seguida de antibioticoterapia.
- D Internação hospitalar para antibioticoterapia intravenosa e repouso intestinal, indicando sigmoidectomia eletiva após 6 semanas, independentemente da evolução do abscesso.

4000271584

Questão 33

2024 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Manifestações Clínicas e Exame Físico Tratamento

Um paciente, masculino de 65 anos, hipertenso, diabético não insulino dependente, com duas cirurgias prévias, por úlcera péptica perforada e apendicite complicada, passou a apresentar dor abdominal difusa, há 5 dias, com parada de eliminação de flatos e fezes, distensão abdominal e náuseas e vômitos escurecidos. Relata ainda hiporexia, redução do volume urinário, e que hoje apresentou saída de pequena quantidade de fezes, porém sem melhora dos sintomas. Está no setor de urgência do hospital realizando analgesia endovenosa e aguardando avaliação da cirurgia geral, que estava em cirurgia por um caso de politrauma grave. Sobre o tema abdome agudo obstrutivo, descrito acima, assinale a alternativa correta.

- A Deve-se aguardar avaliação da cirurgia geral para o exame físico completo, incluindo toque retal e para a decisão de iniciar antibioticoterapia, hidratação venosa ou outros sintomáticos.
- B Não se deve realizar qualquer analgesia antes de avaliação cirúrgica pelo risco de mascarar completamente o diagnóstico real.
- C Se o paciente em questão apresentar vômitos fecalóides, infere-se que apresenta uma obstrução intestinal alta, com válvula ileocecal competente.
- D Mesmo aguardando avaliação da cirurgia geral, a equipe médica que o atendeu deve realizar o exame físico geral, incluindo toque retal, realizar exames laboratoriais para afastar etiologia metabólica, realizar exame de imagem, de preferência a tomografia de abdome total, iniciar hidratação venosa, quantificar diurese, iniciar antibioticoterapia pelo risco de translocação bacteriana e passagem de sonda nasogástrica para sifonagem.

4000214055

Questão 34

2026 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Outras Causas de Obstrução Intestinal Alta

Paciente, 3 anos, procedente de uma área com más condições sanitárias, deu entrada no pronto-atendimento com quadro de distensão abdominal associada a anorexia, vômitos e desidratação. Ao exame físico, evidenciado abdome distendido e presença de massa na região periumbilical. Mãe conta que há cerca de 15 dias, percebeu saída de um "bichinho" (sic) pela boca e narina da filha. Assinale a melhor hipótese diagnóstica e abordagem terapêutica adequada para este momento?

- ☐ A Estrongiloidíase disseminada. Internação hospitalar, jejum, sonda nasogástrica aberta e ivermectina.
- ☐ B Ascaridíase. Coleta de hemograma, PCR e EPF (3 amostras). Albendazol via oral dose única.
- ☐ C Obstrução intestinal por bolo de áscaris. Internação hospitalar, jejum, hidratação venosa, sonda nasogástrica aberta, óleo mineral e avaliação da cirurgia pediátrica.
- ☐ D Abscesso hepático amebiano. Internação hospitalar, hidratação venosa e metronidazol endovenoso.

4000271580

Questão 35

2025 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)
Íleo Paralítico Manifestações Clínicas e Exame Físico Diagnóstico

Um homem de 45 anos foi submetido a uma laparotomia exploratória devido a uma suspeita de peritonite secundária à perfuração intestinal. No terceiro dia pós-operatório, ele apresenta distensão abdominal progressiva, náuseas, ausência de eliminação de gases e fezes, além de sons intestinais ausentes ao exame físico. Seu manejo pós-operatório incluiu analgesia com opiáceos e restrição de dieta oral. Os exames laboratoriais demonstram hemoglobina 12g/dl, leucócitos 13.800/mm³, sódio 132mEq/L (135-145 mEq/L) potássio sérico de 3,2 mEq/L (3,5-5,0 mEq/L) e procalcitonina de 0,048 ng/dl (<0,05ng/dl).

- ☐ A Obstrução intestinal mecânica causada por aderências cirúrgicas
- ☐ B Peritonite residual com comprometimento da motilidade intestinal
- ☐ C Pseudo-obstrução intestinal aguda (Síndrome de Ogilvie)
- ☐ D Íleo paralítico secundário a fatores pós-operatórios

4000241803

Questão 36

2024 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)
Bypass Gástrico em YdeRoux Indicações e Contraindicações

Homem de 45 anos, 160Kg, IMC 48, sem comorbidades; procura ajuda médica para ajuda no controle da obesidade. Refere que por conta própria vem tentando inúmeros tratamentos nos últimos 5 anos, porém sem resposta clínica. Para este paciente, associado a orientação nutricional, qual método de tratamento seria indicado para maior perda ponderal sustentada?

- A Semaglutida (Ozempic®);
- B Balão Intragástrico;
- C Cirurgia de bandagem gástrica;
- D Bypass Gástrico.

4000214056

Questão 37

2024 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT
História Natural da Doença Tratamento Cirúrgico

Paciente feminino, 55 anos, com histórico de há 02 meses dor abdominal no quadrante superior direito, náuseas e vômitos. Exame de ultrassonografia abdominal demonstra a presença de cálculos na vesícula biliar e espessamento de parede. Exames Laboratoriais: Hemograma: Hb 15,1 (13-16 g/dl); Ht: 44,8 (38 a 50%), sem leucocitose; TGO- 38 U/L (VR: 5-40 U/L), TGP- 52 U/L (7-56 U/L), INR- 0,9 (0,8 e 1), gama GT: 42 U/L (9 U/L e 36 U/L); fosfatase alcalina: 100 U/R (40 U/L e 150 U/L), proteínas totais: 6,30 g/dl (entre 6,0 e 8,0 g/dl); albumina sérica: 3,6 g/dl (entre 3,5 g/dL e 5,2 g/dL); bilirrubina total: 1,1 mg/dl (0,2 mg/dL e 1,20 mg/dL); Anti-HAV IgM - não reagente; HBsAg - reagente, VHB DNA < 2.000 cópias/mL (VR: < 2.000 cópias/ml); Anti-HBs - não reagente; Anti-HBc IgM - não reagente; Anti-HBc IgG - reagente; HBeAg não reagente; Anti-HBe -reagente; Anti-HCv - não reagente; HCV RNA - não reagente. Biópsia hepática: ausência de inflamação e ausência de sinais de fibrose. Com base no quadro clínico e laboratorial, qual é a conduta cirúrgica mais apropriada sobre a situação dessa paciente?

- A Acompanhamento clínico e retorno em 6 meses.
- B Está indicado procedimento de colecistectomia.
- C Iniciar tratamento clínico para a doença hepática.
- D A cirurgia de colecistectomia está contraindicada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214058](#)

Questão 38

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Apresentação Clínica e Classificação

Sobre a classificação das hemorroidas internas é correto afirmar que:

- A as hemorroidas grau IV prolapsam mas não são redutíveis.
- B as hemorroidas grau II não prolapsam;
- C as hemorroidas grau I prolapsam espontaneamente e requerem dedução manual;
- D a hemorroida grau III prolapsam com esforço ou defecação e reduzem espontaneamente.

4000214066

Questão 39

Lactente do sexo masculino, com 6 semanas de vida, é levado ao prontoatendimento com história de vômitos de repetição, não biliosos, há dois dias, acompanhados de distensão abdominal, mas sem febre. Ao exame físico, apresenta sinais de desidratação e uma tumoração palpável no quadrante superior direito do abdome. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A Neuroblastoma
- B Intussuscepção intestinal
- C Estenose hipertrófica do piloro
- D Doença do refluxo gastroesofágico

4000241733

Questão 40

Lactente, 8 meses de idade, é levado à emergência pediátrica com quadro de recusa alimentar associada a episódios de choro intenso, vômitos e redução na frequência das evacuações há 36 horas. Nega febre e alterações urinárias. Presença de fezes com muco e sangue. Ao exame físico, paciente irritado, pouco desidratado, abdome distendido, doloroso a palpação e com massa abdominal palpável em flanco direito. Qual a hipótese diagnóstica provável?

- A Invaginação intestinal
- B Divertículo de Meckel
- C Estenose hipertrófica do piloro
- D Hérnia inguinal encarcerada

4000271576

Questão 41

Mulher, 70 anos, em radioterapia para adenocarcinoma de pulmão, dá entrada no pronto-atendimento por dispneia súbita, dor torácica pleurítica e tosse seca. PA = 130x80 mmHg, FC = 100 bpm, FR = 27 irpm. saturação de O₂ = 84% em ar ambiente, ausculta pulmonar sem alterações. A radiografia de tórax mostra opacidade focal arredondada, bem delimitada, em lobo superior esquerdo, sem mudanças em relação aos exames prévios. Diante da suspeita de tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo.

- A angiotomografia de tórax, por ser um dos exames com maior acurácia para confirmar o diagnóstico
- B cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão, por ser o método mais indicado neste caso específico
- C ultrassonografia doppler venosa de membros inferiores, pelo menor custo e potencial de descartar TEP
- D D-dímero, em razão do seu alto valor preditivo positivo, baixo custo e por ser menos invasivo que os demais.

4000271636

Questão 42

2026

Privado

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Clínica Médica

Gestante, 20 anos, com 18 semanas, apresenta anti-HCV reagente, com posterior HCV-RNA detectável, genotipo 1A. Encontra-se assintomática. Bilirrubinas, albumina e TAP normais. TGO = 101 U/L (VR: 5-40 U/L) e TGP = 98 U/L (VR: 7-56 U/L). Hemograma com discreta anemia normocítica normocrômica. Assinale a alternativa que descreve a conduta mais adequada.

- A Realizar elbasvir/grazoprevir somente no intraparto.
- B Iniciar sofosbuvir + daclatasvir antes do 2º trimestre de gestação.
- C Iniciar sofosbuvir + daclatasvir + ribavirina antes do 2º trimestre de gestação.
- D Aguardar término da gestação, e aleitamento para iniciar tratamento específico.

4000271637

Questão 43

2026

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Clínica Médica

Mulher, 67 anos, diabética, no 12º dia de interação por erisipela em membro inferior esquerdo, evolui com dor abdominal, diarreia e febre. O teste fecal por PCR para o gene da toxina B (TcdB) de *Clostridioides difficile* é positivo. Suspende-se clindamicina, iniciando-se oxacilina EV, vancomicina VO 6/6h e probiótico (*Saccharomyces boulardii*) VO 12/12h. O quadro é refratário a dois ciclos de tratamento. Na terceira recidiva, é utilizado novamente vancomicina VO, em esquema prolongado com desmame lento e gradual. Três dias após o término desse último esquema, a paciente apresenta nova diarreia. Nessa situação, o próximo passo mais adequado é:

- A Colectomia parcial.
- B Transplante fecal.
- C Metronidazol VO.
- D Vancomicina EV.

4000271638

Questão 44

2026

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Clínica Médica

Homem, 21 anos, procura o pronto-atendimento com febre, dispneia e tosse há 2 dias. Ao exame físico, apresenta-se em regular estado geral, com FR = 30 irpm, FC = 120 bpm, PA = 100 × 60 mmHg e saturação de O₂ em ar ambiente de 91%. À ausculta, observam-se estertores até o terço médio do hemitórax direito. A radiografia de tórax revela condensações peribrônquicas à direita e a presença de três lesões císticas radiolúcidas, de paredes finas e bem detinidas no pulmão Ipsilateral. Já tendo sido estabelecido o diagnóstico, quais germes devem ser considerados na escolha do esquema antimicrobiano?

- A *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus pneumoniae*
- B *Mycoplasma pneumoniae* e *Acinetobacter baumannii*
- C *Klebsiella pneumoniae* e *Moraxella catarrhalis*
- D *Streptococcus pneumoniae* e *Chlamydia pneumoniae*

4000271639

Questão 45

2026

Privado

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Clínica Médica

Mulher de 32 anos, previamente hígida, procura avaliação por palpitações esporádicas e desconforto torácico atípico. Nega síncope. Não usa medicações. Ao exame físico, apresenta sopro sistólico médio-tardio em foco mitral, precedido por "click" mesossistólico audível em decúbito dorsal, que se antecipa com ortostatismo. Exames complementares: ECG: ritmo sinusal, sem alterações de repolarização; ecocardiograma transtorácico: prolapso do folheto posterior da valva mitral com refluxo mitral discreto, fração de ejeção do VE: 65%, atrio esquerdo normal. Holter 24h: 500 extrassístoles ventriculares isoladas. Qual a conduta mais apropriada para esta paciente?

- A Anticoagulação oral devido ao risco de eventos embólicos
- B Início de betabloqueador e encaminhamento para cirurgia valvar
- C Observação clínica, orientação e acompanhamento ambulatorial
- D Indicação de ablação por radiofrequência pelo risco de arritmia ventricular.

4000271640

Questão 46

2026

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Residência (Acesso Direto)

Clínica Médica

Mulher de 68 anos, hipertensa e dislipidêmica, em uso de losartana 50 mg/dia e sinvastatina 20 mg/noite, dá entrada no pronto-socorro por dor torácica em aperto, intensa, iniciada há 2 horas, irradiada para braço esquerdo, associada a sudorese fria e náuseas. Refere que, 1 dia antes, recebeu a notícia do falecimento súbito de um neto, com intenso abalo emocional. Nega episódios prévios semelhantes, nega tabagismo atual

(parou há 15 anos; 10 maços/ano). Ao exame físico: PA: 138 x 82 mmHg; FC: 104 bpm; FR: 20 irpm; SpO₂: 96% em ar ambiente; ausculta cardíaca: bulhas normofonéticas, sem sopros evidentes; ausculta pulmonar: crepitações finas bibasais discretas; sem edema periférico. ECG na admissão: Ritmo sinusal, 100 bpm, supra de ST de 1-2 mm em V2-V4, inversão de onda T em V5-V6. Exames laboratoriais (admissão): Troponina I: 0.24 ng/mL (VR: < 0,04 ng/mL). Diante do supra de ST, a paciente é submetida a coronariografia de urgência, que demonstra artérias coronárias sem estenoses significativas. Ecocardiograma transtorácico realizado nas primeiras 24 horas: fração de ejeção do VE(35% (VR: 55-70%) com acinesia de segmentos médios e apicais do VE, com hipercinesia de segmentos basais. Diante desse quadro, qual o diagnóstico MAIS provável?

- A Cardiomiocardiopatia de Takotsubo (síndrome do balonamento apical)
- B Miocardite viral aguda com padrão de acometimento predominante de parede anterior
- C Angina variante de Prinzmetal (angina vasoespástica) com resolução espontânea do vasoespasm
- D Infarto agudo do miocárdio com supra de ST por trombose de descendente anterior sem reperfusão adequada

4000271641

Questão 47

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Clínica Médica

Mulher de 54 anos, procura atendimento por fadiga progressiva, redução da tolerância aos esforços e "dormência" em pés e mãos há 4 meses. Refere episódios de desequilíbrio ao andar em locais escuros. Nega sangramentos aparentes, etilismo ou uso de medicações. Tem diagnóstico prévio de "gastrite" e hipotireoidismo autoimune (em uso de levotiroxina). Ao exame físico: PA: 124 x 76 mmHg; FC: 84 bpm; FR: 16 irpm; SpO₂: 99% em ar ambiente; Mucosas hipocoradas 2+/4+; Língua hiperemiada e lisa; Força preservada em MMSS e MMII; Hipoestesia em "luva e bota" em membros inferiores, redução da sensibilidade vibratória em maléolos e joelhos, Romberg positivo, Exames laboratoriais: Hemoglobina: 7,8 g/dL (VR: 12,0-16,0 g/dL); Hematócrito(24% (VR: 36-46%); VCM: 112 L /VR: 80- 100 fL); Leucócitos: 3.200/mm³ (VR: 4.000-11.000/mm³); Plaquetas: 110.000/mm³ (VR: 150,000-400.000/mm³); Reticulócitos: 0.3% (VR: 0,5-1,5%); DHL: 780 U/LVR: 120-246 U/L); Bilirrubina total: 2,1 mg/dL (VR: 0,3-1,2 mg/dL), Creatinina: 0,9 mg/dL (VR: 0,7-1,2 mg/dl); TSH: 2,1 µUI/ml (VR: 0,4-4,0 µUI/ML). Com base no caso clínico e nos exames disponíveis, qual a melhor conduta terapêutica inicial enquanto se aguardam exames complementares específicos?

- A Hemotransfusão
- B Reposição de ácido fólico por via oral
- C Reposição de vitamina B12 por via intramuscular
- D Reposição de ácido fólico e vitamina B12 por via oral

4000271642

Questão 48

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Homem de 64 anos, portador de doença renal crônica estágio 4 (eTFG CKD-EPI: 22 ml/min/1,73 m²), doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2. Refere há cerca de 3 meses fadiga aos esforços e redução da tolerância para caminhadas, sem outros sintomas associados. Medicações em uso: aspirina 100 mg/dia, losartana 100 mg/dia, amlodipino 10 mg/dia, furosemida 40 mg/dia, insulina e sinvastatina 20 mg/noite. Nega hematúria macroscópica, melena ou hematoquezia. Ao exame físico: PA: 132 × 76 mmHg; FC: 82 bpm; FR: 16 irpm; SpO₂: 98% em ar ambiente; mucosas hipocoradas 2+/4+; ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações; sem sinais de insuficiência cardíaca descompensada; sem edema periférico. Exames laboratoriais: creatinina: 2,8 mg/dL (VR: 0,7-1,2 mg/dL); ureia: 86 mg/dL (VR: 10- 50 mg/dL); hemoglobina: 9,0 g/dL (VR: 13,5-17,5 g/dL); hematócrito: 28% (VR: 40-50%); VCM: 89 fL (VR: 80-100 fL); leucócitos: 6.500/mm³ (VR: 4.000-11.000/mm³); plaquetas: 230.000/mm³ (VR: 150.000-400.000/mm³); ferritina sérica: 80 ng/mL (VR: 30-400 ng/mL); saturação de transferrina: 18% (VR: 20-50%); vitamina B12: 420 pg/mL (VR: 200- 900 pg/mL); ácido fólico: 7 ng/ml (VR: > 4 ng/ml); PCR: 6 mg/L (VR: < 5 mg/L); reticulócitos: 0,5% (VR: 0,5-1,5%). Diante do quadro apresentado, qual é a melhor conduta inicial em relação à anemia neste momento?

- ☐ A Hemotransfusão
- ☐ B Suspender aspirina
- ☐ C Carboximaltose férrica
- ☐ D Alfapoetina subcutânea

4000271643

Questão 49

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Clínica Médica

Homem de 76 anos, portador de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, em uso de carvedilol, furosemida e espironolactona, iniciou há cerca de 7 dias dapagliflozina e sacubitril/valsartana. Há 3 dias apresenta queda do estado geral e redução do débito urinário. Nega uso recente de AINES ou antibióticos. Ao exame físico: PA = 90×60 mmHg, FC = 96 bpm, ausculta cardíaca arritmica, sem sopros, sem estertores pulmonares e sem sinais periféricos de congestão. Exames laboratoriais: creatinina: 3,2 mg/dL (valor prévio há 1 mês: 1,0 mg/dL) [VR: 0.6-1,3 mg/dL]; ureia: 128 mg/dL [VR: 10-50 mg/dL]; K+: 5,2 mg/L (VR: 3,5-5,0 mEq/L); urina tipo I: densidade 1.020, pH 5, sem proteinúria e sem hematúria; sódio urinário: 8 mEq/L; fração de excreção de sódio (FeNa): 0,4%; ultrassonografia de rins e vias urinárias: rins de tamanho preservado, sem hidronefrose. Diante do quadro apresentado, qual é a causa mais provável da lesão renal aguda?

- ☐ A Lesão renal aguda pré-renal por hipoperfusão
- ☐ B Necrose tubular aguda isquêmica secundária a baixo débito
- ☐ C Nefrite intersticial aguda associada ao uso de dapagliflozina
- ☐ D Síndrome cardiorrenal tipo 2 relacionada à descompensação da IC

4000271644

Questão 50

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Hipertensão Resistente Esquemas terapêuticos Resinas de troca

Homem, 65 anos, com histórico de hipertensão refratária, atualmente com bom controle às custas de olmesartana 40 mg, clortalidona 25 mg, anlodipino 10 mg e espironolactona 50 mg. Vem para consulta de rotina, sem alterações ao exame físico, apresentando creatinina de 1,6 mg/dL (VR: 0,6-1,3 mg/dL) e potássio de 5,6 mEq/L (VR: 3,5-5,0 mEq/L), repetido e confirmado. ECG sem alterações. Qual a melhor conduta?

- ☐ A Trocar olmesartana por hidralazina
- ☐ B Iniciar poliestireno sulfonato de cálcio
- ☐ C Iniciar ciclossilicato de zircônio sódico
- ☐ D Suspender olmesartana e clortalidona

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241771](#)

Questão 51

2025 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)
Inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II Betabloqueadores
Antagonistas dos receptores mineralocorticóides

Homem, 50 anos, obeso e tabagista, foi diagnosticado recentemente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (FEVE = 36%). Qual alternativa abaixo contempla somente medicamentos com impacto comprovado na sobrevida para a condição apresentada pelo paciente?

- ☐ A Inibidor de neprilisina associado a bloqueador do receptor de angiotensina, betabloqueadores e diuréticos de alça
- ☐ B Inibidores da enzima conversora de angiotensina, inibidor de neprilisina associado a bloqueador do receptor de angiotensina, inibidores do cotransportador sódio-glicose tipo 2 antagonistas dos receptores de aldosterona
- ☐ C Inibidores do cotransportador sódio-glicose tipo 2, bloqueadores do receptor de angiotensina, betabloqueadores e diuréticos de alça
- ☐ D Inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores do receptor de angiotensina, betabloqueadores e diuréticos de alça

4000241751

Questão 52

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Classificação

Homem, 68 anos, portador de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e múltiplas internações prévias por descompensação, é admitido na UTI com dispneia progressiva, fadiga, extremidades frias e turgência jugular proeminente, apesar de uso otimizado de diuréticos ambulatoriais. Opta-se por monitorização hemodinâmica invasiva com cateter de artéria pulmonar (Swan-Ganz), que revela: pressão

venosa central (PVC) de 18 mmHg (VR: 2-6 mmHg), pressão de oclusão da artéria pulmonar (POAP) de 24 mmHg (VR: 6-12 mmHg), índice cardíaco (IC) de 1,8 L/min/m² (VR: 2,5-4,0 L/min/m²) e resistência vascular sistêmica (RVS) de 1800 dinass/cm⁵ (VR: 800- 1200 dinas-s/cm⁵). Com base na classificação de perfis hemodinâmicos de Forrester/Stevenson (quente/frio, seco/úmido), qual é o perfil hemodinâmico desse paciente?

- ☐ A A
- ☐ B B
- ☐ C C
- ☐ D L

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271633](#)

Questão 53

2025 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Estatinas Estratificação do risco cardiovascular em pacientes sem uso de estatinas

Análise do perfil lipídico e das apolipoproteínas

Paciente de 50 anos com diagnóstico de infarto do miocárdio há 2 anos com implante de 2 stents farmacológicos. Apresenta ao ecocardiograma fração de ejeção normal. Encontra-se em uso de ramipril 10 mg/dia, carvedilol 12,5 mg de 12/12h e aspirina 100 mg/dia. Apresenta PA de 140 x 90 mmHg, frequência cardíaca de 60 bpm e LDL de 130 mg/dL. Qual o próximo passo na abordagem terapêutica?

- ☐ A Associar atorvastatina e anlodipino
- ☐ B Associar sinvastatina e aumentar dose de ramipril
- ☐ C Associar rosuvastatina, clopidogrel e espironolactona
- ☐ D Trocar ramipril por valsartana/sacubitril e incluir espironolactona

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241769](#)

Questão 54

2024 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)

Escores de avaliação de risco tromboembólico e hemorrágico Antagonistas da vitamina K

Mulher, 67 anos, no quarto mês de pós-operatório de cirurgia cardíaca para troca de valva mitral biológica, evolui com fibrilação atrial estável. De acordo com a estratificação do risco cardioembólico:

- ☐ A é necessário iniciar anticoagulação com warfarina.
- ☐ B é necessário iniciar ácido acetilsalicílico e clopidogrel.
- ☐ C é necessário iniciar apixabana, ácido acetilsalicílico e clopidogrel.
- ☐ D não é necessário uso de Anticoagulação, devido ao baixo risco.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214026](#)

Questão 55

2025 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Tratamento da hipotensão ortostática e disautonomia

Homem de 72 anos, hipertenso, relata tonturas ao levantar-se. Está em uso de losartana e hidroclorotiazida. PA em decúbito de 120 x 80 mmHg e em ortostatismo de 90 x 60 mmHg. Qual a melhor conduta?

- ☐ A Suspender a hidroclorotiazida
- ☐ B Prescrever meias de compressão
- ☐ C Orientar a aumentar ingestão de líquidos
- ☐ D Trocar losartana por bloqueador de canal de cálcio

4000241765

Questão 56

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Fisiopatologia do Choque Etiologia do Choque Manifestações clínicas

Homem, 58 anos, diabético, obeso e com osteoartrose debilitante nos joelhos, foi internado na UTI por infecção grave de pele e partes moles no membro superior esquerdo. Apresentou febre (39,3°C), taquidispneia (28 irpm), taquicardia (120 bpm), PA de 65x55 mmHg, tempo de enchimento capilar >5s, obnubilação, acidose metabólica, lactato elevado e PaO₂/FiO₂ <300. Após intubação orotraqueal, reposição volêmica vigorosa e início de vancomicina, meropenem e clindamicina, evoluiu com piora hemodinâmica, necessitando noradrenalina e dobutamina. Apesar das intervenções, o tempo de enchimento capilar seguiu lentificado, o lactato aumentou, e a hipotensão persistiu. Qual é o diagnóstico final e a terapêutica correta neste momento?

- ☐ A Choque cardiogênico, punção pericárdica
- ☐ B Sepses, ampliar esquema antimicrobiano
- ☐ C Choque por sequestro, reposição com coloides
- ☐ D Choque séptico refratário, corticoide

4000241742

Questão 57

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Tratamento nas crianças e adolescentes Crianças e adolescentes Crianças e adolescentes

Escolar, previamente hígido, 6 anos, com história de cansaço progressivo com piora nos últimos 2 dias, foi admitido na unidade de pronto atendimento. Negou febre, mas com eventos esporádicos de vômitos. Ao exame físico: sonolento, emagrecido, hipocorado (2+/4+), desidratado, FR 35irpm, MV simétrico e sem ruídos adventícios, abdome pouco distendido, perfusão 4 seg. Assinale a alternativa que melhor define um possível diagnóstico, a investigação para confirmação e conduta inicial.

- A Pneumonia bacteriana, RX de tórax, iniciar amoxicilina.
- B Cetoacidose diabética, glicemia, EAS, gasometria, fazer expansão volêmica.
- C Cetoacidose diabética, glicemia, EAS, gasometria, insulinoterapia.
- D Pneumonia bacteriana, HMG e PCR, iniciar ampicilina.

4000214008

Questão 58

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Manifestações clínicas da hipercalcemia Tratamento Hipercalcemia associada à malignidade

Paciente de 65 anos, com histórico de mieloma múltiplo, chega ao pronto-socorro com fraqueza muscular e constipação. Exames laboratoriais mostram cálcio de 12,0 mg/dL (VR: 8,5-10,5 mg/dL) e creatinina de 2,0 mg/dL (VR: 0,6-1,3 mg/dL). Qual a melhor abordagem inicial?

- A Iniciar hidratação com solução salina
- B Administrar vitamina D e furosemida
- C Iniciar alendronato de sódio oral
- D Realização imediata de hemodiálise

4000241767

Questão 59

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Hipocalcemia com Paratormônio PTH reduzido Manifestações clínicas da hipocalcemia

Mulher, 51 anos em pos-operatorio tardio de tireoidectomia total por câncer de tireoide, é trazida à emergência após crise convulsiva generalizada autolimitada. Refere que, nos últimos meses, vem apresentando câibras recorrentes, tremores em extremidades e disartria. Ao exame físico, apresenta sinais de Trousseau e de Chvostek positivos. Identifique abaixo a alternativa que contenha a principal alteração laboratorial diretamente responsável pelos sinais e sintomas descritos e respectivamente, a principal hipótese diagnóstica.

- A Hipofosfatemia; hiperparatireoidismo primário devido à tireoidectomia.
- B Hiperfosfatemia; hipoparatireoidismo pós-cirúrgico devido à tireoidectomia.
- C Hipercalcemia total; hipoparatireoidismo pós-cirúrgico devido à tireoidectomia.
- D Hipocalcemia ionizada; hipoparatireoidismo pós-cirúrgico devido à tireoidectomia.

4000271635

Questão 60

2024 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Apresentação clínica Abordagem medicamentosa Cálcio

Mulher, 50 anos, vai à UBS com exames solicitados na última consulta médica. Encontra-se na pós-menopausa, sedentária, ingestão diária de aproximadamente 1200g de cálcio na dieta. Densitometria óssea: T-score de -2,5 na coluna e T-score de -3,0 quadril; Perfil bioquímico: cálcio, fósforo, albumina, proteína total, creatinina, enzimas hepáticas, e eletrólitos = sem alterações; 25-hidroxi vitamina D: 35 ng/ml; Em relação ao diagnóstico realizado após análise dos exames, marque a alternativa CORRETA.

- ☐ A É uma condição que não tem manifestações clínicas até que haja uma fratura.
- ☐ B Seu diagnóstico é feito exclusivamente com os resultados da densitometria óssea.
- ☐ C O tratamento para a paciente acima inclui suplementação de cálcio elementar (geralmente 500 a 1000 mg/dia), em doses fracionadas na hora das refeições.
- ☐ D Para aumento da densidade mineral óssea é recomendado exercícios com baixo impacto sendo contraindicado levantamento de peso.

4000214027

Questão 61

2026 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)
Ressuscitação Volêmica Controle Álgico

Homem de 52 anos chega ao pronto-socorro com dor epigástrica intensa há 8 horas, irradiando para dorso, com náuseas. Exame: pressão arterial 104/62 mmHg, frequência cardíaca 108 bpm, temperatura 37,7 °C. Abdome doloroso em epigástrio, sem sinais de peritonite. Laboratório: lipase 1.140 U/L (VR: 13-60), bilirrubina total 1,1 mg/dL (VR: 0,2-1,2), leucócitos 12.600/mm³ (VR: 4.000-11.000). Ultrassonografia mostra colelitíase sem dilatação de via biliar principal. Qual é a principal medida terapêutica nas primeiras 24 horas?

- ☐ A Colectomia laparoscópica com exploração de via biliar principal
- ☐ B Antibioticoterapia empírica de amplo espectro
- ☐ C Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica precoce
- ☐ D Hidratação venosa vigorosa com cristalóide e analgesia adequada

Essa questão possui comentário do professor no site 4000271589

Questão 62

2025 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)
Antibioticoterapia Dieta

Sobre o manejo da pancreatite aguda leve, qual das alternativas abaixo é correta?

- ☐ A A antibioticoterapia profilática está indicada em todos os casos.
- ☐ B Deve-se introduzir alimentação oral assim que a dor e náuseas permitirem.
- ☐ C A nutrição parenteral sempre é preferível à enteral para evitar complicações.
- ☐ D A colectomia nunca é indicada durante o mesmo internamento.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000241808

Questão 63

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Tratamento Cirúrgico Drenagem Biliar

Paciente feminina, 44 anos, previamente hígida, sem uso de medicações, nega etilismo. Dá entrada no pronto-socorro com dor epigástrica súbita e intensa, irradiada para o dorso, e vômitos. Admissão (Hora 0): Sinais Vitais: PA 110/70 mmHg, FC 95 bpm, FR 18 irpm, Tax 37,5°C. · Laboratório: Amilase 1.800 UI/L, Lipase 2.100 UI/L. Leucócitos 14.000 /mm³; Função hepática: TGO 210 UI/L, TGP 250 UI/L, Bilirrubina Total 4,1 mg/dl (Direta 3,0 mg/dL), Fosfatase Alcalina 310 U/L; Ultra-som de abdome: Múltiplos cálculos na vesícula biliar e dilatação do ducto colédoco (9 mm), com imagem de cálculo impactado em seu terço distal. Evolução (Próximas 24 horas): A paciente evolui com piora da dor, febre (38,8°C), calafrios e confusão mental. Mantém-se taquicárdica (FC 115 bpm) e torna-se hipotensa (PA 90/50 mmHg), apesar da hidratação venosa. De acordo com o quadro acima, qual diagnóstico e a conduta terapêutica de urgência mais apropriada?

- A Pancreatite biliar não-grave. Iniciar antibióticos e realizar CPRE pré-operatória, seguida de colecistectomia laparoscópica 12 a 24 horas após, para evitar recidiva.
- B Pancreatite biliar grave com colangite aguda. Indicar CPRE de urgência (dentro das próximas 48 horas) para papilotomia e desobstrução biliar, seguida de colecistectomia após resolução completa da pancreatite.
- C Pancreatite biliar grave. Indicar terapia de suporte intensivo (UTI) e antibioticoterapia. A CPRE está contraindicada na fase aguda pelo risco de piora da pancreatite.
- D Pancreatite biliar não-grave. Realizar colescistectomia laparoscópica de urgência com colangiografia intraoperatória. Se houver coledocolitíase, optar por exploração transoperatória.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271581](#)

Questão 64

2026 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)

Abordagem Inicial

Homem, 58 anos, histórico de AINE de uso crônico, apresenta hematêmese volumosa há 1 hora. Ao exame: pálido, sudorético. PA 90/60 mmHg, FC 118 bpm, FR 24 irpm, Temp 36,4 °C, SpO₂ 94%. Exames: Hb 7,0 g/dL (VR: 13-17), plaquetas 220.000/mm³ (VR: 150.000-400.000), creatinina 1,1 mg/dL (VR: 0,6-1,2), INR 1,1 (VR: 0,8-1,2). Qual a primeira medida inicial mais importante neste momento?

- A Iniciar infusão de inibidor de bomba de prótons em alta dose
- B Solicitar endoscopia digestiva alta imediatamente, sem estabilização
- C Garantir acesso venoso calibroso, reposição volêmica e suporte hemodinâmico
- D Administrar transfusão de plaquetas profilática

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271593](#)

Questão 65

2024 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Vasopressores Profilaxia Antibiótica Terlipressina

Homem, 63 anos, com diagnóstico prévio de cirrose hepática secundária ao vírus da hepatite B, com endoscopia prévia que evidenciava varizes esofageanas, deu entrada no pronto atendimento com quadro de hematemese. Ao exame encontra-se em regular estado geral, icterico +/4+. hipocorado +/4+, afebril, taquicardico (FC 110 bpm) e com PA de 100 x 60 mmHg. Ausculta cardíaca e respiratórias normais. Abdome ascítico. Além das medidas de estabilização clínica, quais fármacos são melhor recomendados enquanto aguarda a realização de endoscopia digestiva alta?

- A Octreotida e propranolol
- B Vasopressina e albumina
- C Noradrenalina e lactulose
- D Terlipressina e ceftriaxone

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214033](#)

Questão 66

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Princípios do Tratamento Cirúrgico

Homem, 62 anos, tabagista, com adenocarcinoma de cólon sigmoide T3N0M0 documentado por colonoscopia e tomografia de tórax e abdome, sem evidência de metástases. Ao exame: PA 130/80 mmHg, FC 78 bpm, FR 16 irpm, Temp 36,7 °C, SpO₂ 97%. Sem outras comorbidades relevantes. A equipe programa cirurgia de retosigmoidectomia laparoscópica eletiva. Considerando os princípios da cirurgia oncológica, qual é o objetivo principal em relação à ressecção do tumor?

- A Remover apenas o segmento tumoral com margem de 1 cm, em cunha, preservando o máximo de cólon
- B Ressecar o tumor com margens livres e ligadura vascular central adequada, incluindo linfadenectomia regional
- C Realizar ressecção local por via transanal para evitar complicações da anastomose
- D Realizar ressecção em cunha do segmento colônico com preservação dos vasos principais

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271596](#)

Questão 67

2025 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)

RDW red cell distribution width Diagnóstico diferencial das anemias microcíticas Introdução à anemia ferropriva

Um paciente masculino de 18 anos, sem comorbidades, apresenta anemia microcítica e hipocrômica ao hemograma. Qual parâmetro do mesmo exame pode ser utilizado para auxiliar na diferenciação entre anemia ferropriva e talassemia minor?

- A Amplitude de Distribuição dos Eritrócitos (RDW)
- B Volume Corpuscular Médio (VCM)
- C Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM)
- D Hemoglobina Corpuscular Média (HCM)

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241759](#)

Questão 68

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Pica Diagnóstico da anemia ferropriva Alterações mucosas Glossite atrófica e queilite angular

Um engenheiro aposentado de 70 anos, coronariopata, relata sintomas insidiosos de astenia, anorexia, insônia, palpitações, angina pectoris e visualização de "moscas volantes". O exame físico revela palidez cutaneomucosa, escleras azuladas, queilite angular, glossite, sopro sistólico 1+/4+ e coiloníquia. Familiares relatam que o paciente tem apresentado alotriofagia nos últimos meses. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A Escorbuto
- B Deficiência de ferro
- C Doença de Wilson
- D Hemocromatose

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241756](#)

Questão 69

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Síndrome torácica aguda

Adolescente de 12 anos, portadora de anemia falciforme, é atendida na emergência com febre elevada há 24 horas e sintomas gripais. Durante o período de observação, apresenta dor torácica e queda na saturação de oxigênio (90%). Ausculta pulmonar revela redução discreta do murmúrio vesicular à esquerda. FC normal. Qual a hipótese diagnóstica e a conduta mais provável?

- A Embolia pulmonar aguda / Internação, anticoagulação com dose plena de heparina.
- B Embolia pulmonar aguda / Internação, anticoagulação com dose profilática de heparina.
- C Síndrome torácica aguda / Observação por 24h, analgesia, evitar a transfusão de hemácias.
- D Síndrome torácica aguda / Internação, analgesia, antibioticoterapia e transfusão de hemácias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241712](#)

Questão 70

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Quadro clínico da síndrome hemolítico urêmica SHU

Pré-escolar, três anos, masculino, é trazido à emergência devido hipoatividade e palidez. Há 3 dias com febre, vômitos e diarreia com sangue. Segundo a mãe, o paciente era saudável. Exame físico: pálido, hipocorado 3+/4+, irritado, prostrado e com dor à palpação abdominal. FC: 150 bpm, FR: 38irpm, PA: 105 x 60 mmHg. Exames laboratoriais: Hb:6,5 g/dL, Ht:21 %, leucometria:14.800/mm³ (bastões15%, segmentados 65%); plaquetas: 85.000/ mm³, Na+: 134mEq/L, K+: 4,6 mEq/L, creatinina: 2,8 mg/dL, ureia: 125 mg/dL. Exame de urina: hematúria. A principal hipótese diagnóstica é:

- A insuficiência renal crônica
- B púrpura de Henoch-Schönlein
- C glomerulonefrite difusa aguda
- D síndrome hemolítico-urêmica

4000214006

Questão 71

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Classificação da leucemia linfóide aguda LLA morfológica citogenética e biologia molecular

Quadro clínico da leucemia linfóide aguda LLA Diagnóstico da leucemia linfóide aguda LLA

Um paciente de 11 anos apresenta febre sem causa aparente, dores ósseas e palidez cutânea há mais de duas semanas. O hemograma revelou: Hb de 6,7 g/dl; 43.000 leucócitos/ μ l com 35% de blastos; e 90.000 plaquetas/ μ L. O mielograma confirmou o diagnóstico de leucemia linfóide aguda (LLA). Assinale a alternativa correta.

- A A apresentação inicial das leucemias pode ser uma pancitopenia.
- B Dores ósseas não costumam fazer parte da apresentação clínica da doença.
- C O tratamento inicial de escolha das leucemias na infância é o transplante de medula óssea.
- D O paciente não deve ser submetido à punção líquórica para que não ocorra contaminação do líquido cefalorraquidiano por 'blastos'.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000241730

Questão 72

2024 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Quadro clínico da leucemia linfóide aguda LLA Diagnóstico da leucemia linfóide aguda LLA

Pais relatam que, há aproximadamente 20 dias, seu filho de cinco anos iniciou quadro de adinamia, fadiga, dores em membros inferiores e nas articulações dos joelhos, febre intermitente e equimoses pelo corpo, após traumas leves. Exame físico: palidez cutâneo mucosa ++/4+, linfonodomegalias em região cervical bilateralmente, baço palpável a 6,5cm do rebordo costal esquerdo, fígado palpável a 3,5cm do rebordo costal direito, equimoses difusas em membros inferiores e dorso. Há cerca de uma semana, foi iniciado pelo médico assistente corticoide via oral para criança, com melhora das dores em membros inferiores. Exames laboratoriais: hematimetria: 2.800.000/ mm³, hematócrito: 22,5%; hemoglobina: 7,4g/dL, VCM: 78,3fL, CHCM: 32,8g/dL; HCM: 25,7pg; leucócitos: 8.000/mm³ (linfócitos 88%, segmentados 12%), contagem de plaquetas 25.000/mm³. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- A Leishmaniose visceral
- B Artrite reumatoide
- C Leucemia linfóide aguda
- D Mononucleose infecciosa

4000214011

Questão 73

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Quadro Clínico do mieloma múltiplo MM

Homem, negro, 60 anos, sem patologias prévias, vem para consulta com quadro de dor óssea principalmente em região lombar, associado com fratura patológica evidenciada a radiografia de coluna lombossacra. Traz exames laboratoriais prévios com anemia, elevação de creatinina e hipercalcemia. O diagnóstico mais provável é:

- A mieloma múltiplo.
- B hipoparatiroidismo.
- C intoxicação por vitamina D.
- D hiperparatiroidismo terciário.

4000214034

Questão 74

2024 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)

Fase sintomática e fase AIDS Doenças definidoras de AIDS

Perito criminal, 50 anos, internado em enfermaria para investigação de síndrome consumptiva. Você é o residente responsável pelo caso, colhe a história da doença atual e o histórico médico que constam: perda de mais de 16kg nos últimos 3 meses, sem dieta, cansaço, astenia, hiporexia, febre intermitente e diarreia. Há duas semanas surgiram lesões em placas esbranquiçadas em toda mucosa oral, com odinofagia. Relata também lesões arredondadas e hiperemiadas em palma das mãos. Há 3 dias com tosse seca e dispneia. Vacinas em dia. É solteiro, sem filhos, faz sexo somente com homens, faz uso esporádico de preservativo e diz não consumir nenhum tipo de droga. Nega história de tuberculose na família. Nega alergias. Refere cirurgia por politrauma na infância onde precisou realizar várias transfusões sanguíneas. Os exames complementares apresentaram os seguintes resultados.

EXAME	RESULTADO	REFERÊNCIA
Hemoglobina	10,8	13 – 16
Leucócitos	2.000	4.000 – 11.000
Linfócitos	550	800 – 4.400
Plaquetas	128.000	150.000 a 450.000
1º teste-rápido HIV (lote 1)	Reagente	Não reagente
2º teste-rápido HIV (lote 2)	Reagente	Não reagente
HBsAg	Não reagente	Não reagente
Anti-HCV	Reagente	Não reagente
VDRL	Reagente 1/128	Não reagente
Prot. C-reativa	67	< 5
TGO	105	10 – 40
TGP	122	10 – 49
Creatinina	0,8	Até 1,3
Glicemia	74	70 – 99
Radiografia de tórax	Presença de infiltrado intersticial retículo-nodular difuso, bilateral, formando o sinal "asa de borboleta".	

Sobre o diagnóstico de retrovirose desse paciente, podemos afirmar corretamente que o:

- A diagnóstico não está confirmado.
- B paciente apresenta diagnóstico de HIV.
- C próximo passo é solicitar sorologia para HIV.
- D paciente apresenta diagnóstico de AIDS.

4000214021

Questão 75

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Fasciíte necrotizante

Homem de 56 anos, diabético mal controlado, chega ao pronto-socorro com dor intensa em períneo há 2 dias, febre e prostração. Exame: pressão arterial 98/60 mmHg, frequência cardíaca 128 bpm, temperatura 39,1 °C. Região perineal e escrotal com edema acentuado, áreas violáceas, bolhas e crepitação à palpação. Leucócitos 22.300/mm³ (VR: 4.000-11.000), lactato 5,0 mmol/L (VR: 0,5-2,2). Qual é a conduta inicial mais apropriada?

- A Antibioticoterapia venosa e reavaliação clínica após 6 horas
- B Incisão e drenagem local limitada, com cirurgia definitiva eletiva na mesma internação.
- C Tomografia computadorizada do períneo antes de intervenção para melhor avaliação local.
- D Debridamento cirúrgico amplo e imediato associado a antibioticoterapia de amplo espectro e suporte hemodinâmico.

4000271586

Questão 76

2024 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Homem, 34 anos, mecânico, natural e procedente de São Paulo/SP, esteve em viagem turística de pesca pelo sul do Amazonas há 20 dias. Foi internado em UTI por quadro de prostração intensa, rebaixamento do sensório, hemorragias, icterícia, oligúria e albuminúria, que havia iniciado com febre, cefaleia, mialgia, náuseas e vômitos. Faleceu no 7º dia de doença. Na autópsia chamou atenção, ao estudo anatomopatológico, as lesões hepáticas do tipo "necrose médio-zonal". Qual o diagnóstico?

- A Febre amarela.
- B Dengue.
- C Malária.
- D Febre maculosa.

4000214022

Questão 77

2025

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Definição

Quadro clínico

Tratamento

Homem, 50 anos, tabagista desde os 15 anos, retorna ao prontoatendimento por pneumonia em piora, apesar de 3 dias de tratamento com amoxicilina/clavulanato. Ele se encontra em estado grave. A nova radiografia de tórax revela cistos preenchidos por ar, com paredes finas e bem delimitadas. A esposa relata que o paciente foi internado há 45 dias para uma apendicectomia. Qual deve ser o novo esquema antibiótico?

- A Ceftriaxone com vancomicina
- B Levofloxacino com azitromicina
- C Amoxicilina/clavulanato com azitromicina
- D Piperacilina/tazobactam, azitromicina e vancomicina

4000241755

Questão 78

2024

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Manifestações clínicas

Adolescente de 12 anos é levada à emergência por cefaleia intensa, vômitos em jato há um dia e febre (38,5°C), sem melhora mesmo com o uso de antitérmico. Ao exame físico apresenta-se febril, com rigidez de nuca, sonolência, mucosas secas e hipocoradas. Resultado do líquido por Punção lombar: pleocitose, com 478 células/mm³, 25.000 hemácias/mm³, com predomínio de linfomononucleares; proteína: 49mg/dL; glicorraquia: 62 mg dL (glicemia: 88 mg/dL no momento da punção). Esse quadro clínico sugere:

- A meningite viral.
- B meningite bacteriana.
- C trauma de punção.
- D aneurisma cerebral roto

4000214017

Questão 79

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Etiologia Manifestações clínicas Diagnóstico

Escolar de 4 anos é levado à emergência com quadro de torpor, associado a sufusões hemorrágicas, febre alta e história de um dia de inapetência, vômitos e cefaleia intensa. No exame físico, apresenta-se desidratado, sudorético, pálido, febril, com sinais de irritação meníngea e escala de Glasgow de 12/15. A punção lombar revela: Pleocitose: 1480 células/mm³, com predomínio de polimorfonucleares neutrófilos. Proteína: 985 mg/dL (referência: < 40 mg/dL). Glicorraquia: 25 mg/dL (referência: > 2/3 da glicemia plasmática; glicemia do paciente: 71 mg/dL). Bacterioscopia: Presença de diplococos gram-negativos. Com base nos dados apresentados, o diagnóstico mais provável é de meningite bacteriana devido a:

- A Neisseria meningitidis
- B Streptococcus pneumoniae
- C Listeria monocytogenes
- D Streptococcus agalactiae

4000241723

Questão 80

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Quadro Clínico Influência Em Gestantes Tratamento antiviral

Mulher de 37 anos, G3 PN2 A0, IG 26 semanas, asmática, procura a UPA com queixa de febre, cefaleia, mal estar geral, coriza e tosse seca há 1 dia. Ela conta que na 2ª gestação precisou ser internada em função de um quadro gripal, pois evoluiu com critérios de gravidade. Na gravidez atual não teve nenhuma crise asmática, afirma que vem fazendo tratamento de manutenção regularmente, com Budesonida e Formoterol. Ao exame físico: Temperatura axilar 38,5°C, FC 98 bpm, FR 24 irpm, ausculta pulmonar com som claro, sem sibilos ou ruídos adventícios, ausculta cardíaca normal. Exame obstétrico normal. Qual das seguintes estratégias reduz o risco de evolução desfavorável?

- A Observar evolução nas próximas 24h, se houver persistência da febre internar.
- B Internar e iniciar inalação com soro fisiológico e corticóide (Beclometasona) de 12/12h.
- C Prescrever oseltamivir 75mg de 12/12 h por 5 dias e manter acompanhamento ambulatorial.
- D Iniciar uso de Loratadina 10 mg de 12/12h por 7 dias e manter acompanhamento ambulatorial

Questão 81

2025

Privado

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Manejo da Nefropatia diabética

Nefropatia diabética x Nefropatia não diabética

Paciente de 52 anos, hipertenso, diabético há 10 anos e portador de retinopatia diabética, em uso de insulinoterapia, metformina 850 mg 2x/dia e losartana 100 mg/dia, apresenta queixa de urina espumosa. Exames mostram: glicemia de jejum 130 mg/dL (VR: 70-99 mg/dL), hemoglobina glicada 7,2% (VR: < 5,7%), creatinina 1,5 mg/dL (VR: 0,6-1,3 mg/dL), ureia 48 mg/dL (VR: 10-50 mg/dL), albumina sérica 3,2 g/dL (VR: 3,5-5,5 g/dL) e potássio de 4,0 mEq/L (VR: 3,5-5,0 mEq/L). Urina de 24 horas revela albuminúria de 500 mg/24 h (VR: < 30 mg/24 h). Considerando os achados, qual seria a melhor conduta para este caso?

- ☐ A Iniciar dapagliflozina e finerenona
- ☐ B Indicar realização de biópsia renal
- ☐ C Substituir losartana por inibidor da ECA
- ☐ D Suspender metformina e iniciar empagliflozina

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241773](https://www.4000241773.com.br)**Questão 82**

2024

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Nefropatia induzida por contraste

Homem, 61 anos, renal crônico estágio IV por nefropatia diabética, já com fístula arterio-venosa com bom frêmito em região braqui-basílica, é internado em unidade coronariana para realização de angioplastia. Ao exame físico encontra-se euvolêmico e com exames laboratoriais com creatinina de 3,8 mg/dL; uréia de 103 mg/dL; sódio de 139 mEq/L e potássio de 4,9 mEq/L. A melhor conduta para evitar nefropatia induzida pelo contraste é:

- ☐ A n-acetilcisteína e bicarbonato oral
- ☐ B n-acetilcisteína e aumentar ingesta hídrica
- ☐ C hidratação pré e pós exposição ao contraste
- ☐ D hemodiálise imediatamente após uso do contraste

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214035](https://www.4000214035.com.br)**Questão 83**

2024

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

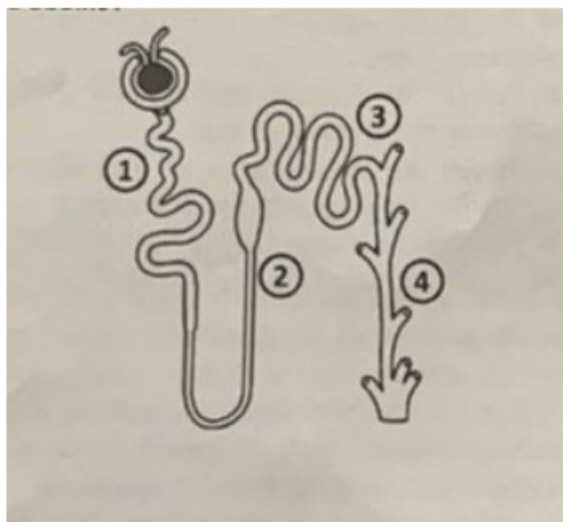
Acesso Direto (R1)

Privado

Alça de Henle

Mulher, 55 anos, diagnóstico de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, da entrada no pronto atendimento com quadro de dispneia. Ao exame físico apresenta-se com pressão arterial 180x110 mmHg, edema de membros inferiores e crepitação até terço médio de ambos hemitórax. Exame de urgência revelam uréia de 50 mg/dL (10-50 mg/dL), creatinina de 1,1 mg/dL (0,6-1,2 mg/dL), sódio de 130 mEq/L (135-145

mEq/L), potássio de 5 mEq/L (3,5_5,0 mEq/L), cálcio de 1,3 mg/dL (1,12-1,32 mg/dL). Em relação ao diurético que deve ser prescrito nesse momento, qual seu local de ação, considerando a figura abaixo?



- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214036](#)

Questão 84

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Bacteriúria assintomática

Mulher, 70 anos, internada em regime de homecare, com histórico de AVC há mais de 4 anos e em acompanhamento para mieloma múltiplo, encontra-se em bom estado geral e está sendo avaliada de rotina. Ao exame, está hipocorada (1+/4+), mas lúcida, orientada, afebril e sem queixas. Os exames laboratoriais solicitados há 20 dias mostram: hemoglobina 10,1 g/dL (VR: 13,8-17,2 g/dL), hematócrito 31% (VR: 40,7-50,3%), leucócitos 3.500/mm³ (VR: 4.000-10.000/mm³), plaquetas 140.000/mm³ (VR: 150.000-450.000/mm³), creatinina 1,4 mg/dL (VR: 0,6-1,3 mg/dL). O EAS revela hematúria microscópica, bactérias moderadas e nitrito positivo. A urocultura identificou *Klebsiella pneumoniae* sensível somente aos carbapenêmicos, amicacina e polimixina B. Qual é a conduta mais adequada?

- A Orientações
- B Transusão sanguínea
- C Iniciar ertapenem
- D Iniciar amicacina

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241744](#)

Questão 85

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Tratamento da Hipocalemia

Mulher, 65 anos, no 5º pós operatório de revascularização do miocárdio apresenta níveis séricos de potássio de 2,6 mmol/L (VR: 3,5 a 5,1 mmol/L). Como a paciente está assintomática, foi realizado coleta de material confirmando tal resultado. Qual a conduta para o caso?

- A Infusão de glicose (GH 50% 50ml) e insulina (R 10U);
- B Uso oral de resina de troca (Sorcal) 15g 3x ao dia;
- C Infusão de KCl EV a uma taxa de 10 MEq/h;
- D Suplementação oral com KCL a uma taxa de 40mEq/dia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214053](#)

Questão 86

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Entérica

Paciente masculino, 38 anos, diagnosticado com Doença de Crohn ileocolônica há 12 anos. Ele foi submetido a uma hemicolectomia direita e ressecção de 80 cm de íleo terminal há 4 anos devido a uma estenose fibrótica refratária. Desde então, evolui com diarreia crônica (5-6 evacuações/dia, esteatorreia) e está em uso de terapia biológica. Ele procura o pronto-atendimento com quadro agudo de dor em flanco esquerdo, de forte intensidade, com irradiação para região inguinal e hematúria macroscópica. A tomografia de abdome e pelve evidencia um cálculo de 6 mm na junção ureterovesical esquerda, causando hidronefrose. Considerando o quadro anterior, qual é o mecanismo metabólico mais provável para a formação do cálculo renal neste paciente?

- A Hipercalciúria induzida pelo uso crônico de corticosteroides, levando à formação de cálculos de fosfato de cálcio.
- B Desidratação crônica e perdas alcalinas pelo intestino, levando a uma urina persistentemente ácida e formação de cálculos de ácido úrico
- C Infecção do trato urinário de repetição por bactérias produtoras de urease, levando à formação de cálculos de estruvita
- D Hiperabsorção colônica de oxalato (hiperoxalúria entérica) devido à má absorção de sais biliares no íleo ressecado

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271583](#)

Questão 87

2024 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Alterações laboratoriais

Homem, 18 anos, vem para consulta devido quadro, de início há 5 dias, de mudança de coloração da urina, referindo urina com cor de chá, associado com redução da diurese, espuma na urina e dor lombar bilateral. Evoluiu no dia de hoje com náuseas, vômitos e diarreia. Ao exame físico, encontra-se hipertenso, com edema de membros inferiores bilateralmente e crepitação bibasal na ausculta pulmonar. Nega patologias prévias ou uso de medicações, referindo faringite há cerca de 3 semanas. Diante da principal hipótese diagnóstica, qual

achado no exame de urina seria mais específico de tal patologia?

- A Hematúria.
- B Eosinófilos.
- C Acantócitos.
- D Cilindros graxos

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214032](#)

Questão 88

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Doença por lesões mínimas

Um menino de 4 anos é levado ao pronto-atendimento com inchaço progressivo em face, evoluindo para anasarca há cerca de 7 dias. O acompanhante refere urina espumosa com redução do volume urinário. Ao exame físico, apresenta edema generalizado e intenso edema de bolsa escrotal. Exames laboratoriais revelam hipoalbuminemia de 1,6 g/dL, creatinina de 1,1 mg/dL e ureia de 70 mg/dL. Diante do diagnóstico mais provável, é correto afirmar que:

- A A hipercolesterolemia é um achado comum.
- B Há indicação de diálise peritoneal para o controle do edema.
- C Não há evidências claras de benefícios no uso de corticosteroide.
- D A etiologia mais provável é a glomeruloesclerose segmentar e focal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241727](#)

Questão 89

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Doença por lesões mínimas

Menino, 6 anos de idade, encaminhado ao ambulatório de pediatria devido queixa de edema progressivo em face, evoluindo com anasarca, há cerca de 7 dias. Mãe refere urina espumosa, com redução do volume há dois dias. Nega doenças prévias. Ao exame físico, presença de anasarca e com edema escrotal. Exames laboratoriais revelam hipoalbuminemia e discreto aumento de ureia e creatinina. Qual a principal hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica inicial recomendada?

- A Síndrome nefrítica. Antibioticoterapia
- B Síndrome nefrótica. Corticosteroide
- C Síndrome hemolítico-urêmica. Diálise
- D Lúpus eritematoso sistêmico. Imunossupresor

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271577](#)

Questão 90

Mulher, 75 anos dá entrada no pronto atendimento trazida por familiares com quadro de confusão mental e agitação psicomotora que iniciou há 3 dias. Portadora de osteoartrose de joelhos em uso de Biprofenid 150mg 12/12h além do Pantoprazol 20mg/dia para proteção gástrica. Filha relata ainda que há 1 mês mãe iniciou uso de Clonazepam 5 gotas devido insônia além da Sertralina 50mg/dia que já fazia uso para depressão. Exame físico e laboratoriais sem alterações. A hipótese diagnóstica e conduta são:

- A por se tratar de um quadro de demência, as medicações em uso devem ser mantidas e associar antipsicótico como Quetiapina para controle da confusão mental.
- B por se tratar de um quadro de delirium, o uso de benzodiazepínico em doses baixas está indicado para controle de agitação psicomotora.
- C por se tratar de um quadro de demência, deve-se suspender a Sertralina e iniciar anticolinesterásico como Donepezila para controle dos sintomas.
- D por se tratar de um quadro de delirium, deve-se corrigir fatores precipitantes como por exemplo suspensão do Clonazepam.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214031](#)

Questão 91

Paciente com 85 anos, totalmente dependente para as atividades básicas e instrumentais de vida diária devido demência de Alzheimer avançada vem apresentando dificuldades para se alimentar com perda ponderal importante no último ano, redução da massa muscular e aparecimento de lesão por pressão na região sacral. Assinale a conduta adequada:

- A deve-se passar sonda nasointestinal e iniciar dieta hipercalórica e hiper proteica com objetivo de se obter recuperação nutricional.
- B deve-se colocar gastrostomia via endoscópica para alimentação artificial visto que paciente necessitará de mais de 30 dias de dieta enteral para recuperação muscular.
- C deve-se solicitar seguimento com fonoaudiólogo para melhoria do padrão de deglutição, adequação alimentar de acordo com preferência do paciente respeitando o seu tempo e ritmo.
- D a dieta enteral deve ser iniciada o mais precocemente possível seja por sonda nasointestinal ou gastrostomia para auxílio da cicatrização da lesão por pressão na região sacral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214029](#)

Questão 92

Um homem de 62 anos, previamente saudável, é trazido pela esposa ao ambulatório por mudanças comportamentais progressivas há 18 meses. Tornou-se socialmente inadequado, com comentários

impróprios, perda de empatia e episódios de irritabilidade. Refere ainda aumento do apetite, principalmente por doces, e comportamentos repetitivos, como arrumar gavetas por horas. A esposa relata que o paciente "não parece mais o mesmo", apesar de ainda conseguir realizar tarefas simples e manter autonomia básica. Nega alucinações, tremores ou quedas. Não há queixa de perda de memória episódica marcante no início do quadro. Exames: · Mini Mental: 25/30 (prejuízo discreto principalmente em atenção e cálculo). · Ressonância magnética: atrofia predominante em lóbulos frontais, mais acentuada à direita. · TSH, B12, VDRL, HIV: normais. · Teste de fluência verbal (animais/min): 6 (reduzido). Qual é o diagnóstico mais provável?

- A Doença de Alzheimer de início precoce
- B Demência com corpos de Lewy
- C Doença de Parkinson com demência
- D Demência frontotemporal

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271629](#)

Questão 93

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Líquor

Menino, 8 anos de idade, com quadro de paralisia flácida e arreflexia simétrica e ascendente de membros inferiores há 3 dias. Assinale o resultado de líquido esperado para a principal hipótese diagnóstica:

- A Proteinorraquia de 200 mg/dl, glicorraquia de 5 mg/dl (com glicemia pareada de 80 mg/dl), celularidade de 400 células/mm³, sem hemácias.
- B Proteinorraquia de 60 mg/dl, glicorraquia de 50 mg/dl (com glicemia pareada de 80 mg/dL), celularidade de 150 células/mm³, sem hemácias.
- C Proteinorraquia de 120 mg/dl, glicorraquia de 60 mg/dl (com glicemia pareada de 80 mg/dl), celularidade de 5 células/mm³, sem hemácias.
- D Proteinorraquia de 40 mg/dl, glicorraquia de 60 mg/dl (com glicemia pareada de 80 mg/dL), celularidade de 25 células/mm³, hemácias de 1.500/mm³.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271572](#)

Questão 94

2026 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Sarcopenia do Envelhecimento As grandes síndromes geriátricas gigantes geriátricos

Mulher de 81 anos, hipertensa e com artrose de joelhos, procura o ambulatório por fraqueza progressiva, quedas recorrentes (duas nos últimos dois meses) e dificuldade para levantar-se da cadeira sem apoio. Refere ainda perda de peso de 4 kg nos últimos 6 meses. Avaliação funcional: · Velocidade de marcha: 0,7 m/s · Força de preensão palmar: 14 kgf (limite inferior para mulheres idosas: < 17 kgf · Teste "levantar-se da cadeira 5x": 18 segundos (lento) Bioimpedância (BIA): Massa Muscular Apendicular (ASMI): 5,2 kg/m² (VR mulheres ≥ 5,7 kg/m²). Qual é o diagnóstico e a conduta inicial mais adequada?

- A Fragilidade leve; recomendar apenas exercícios aeróbicos e repetir bioimpedância em 12 meses.
- B Osteopenia funcional; iniciar suplementação de cálcio e vitamina D como tratamento primário.
- C Sarcopenia provável; solicitar densitometria óssea para confirmar perda de massa muscular.
- D Sarcopenia confirmada; resistido supervisionado e otimizar ingestão proteica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271630](#)

Questão 95

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Quadro Clínico Tomografia Computadorizada

Homem, 65 anos, foi trazido ao pronto-atendimento por familiares devido quadro de cerca de 2 horas de hemiplegia à direita, com predomínio braquiofacial, disartria e afasia motora, com desvio da língua para direita e do olhar conjugado para a esquerda. O histórico médico consta hipertensão com baixa aderência ao acompanhamento médico e dislipidemia. Nega outras patologias. Ao exame, além do déficit neurológico, apresenta pressão 140x80 mmHg e FC 85 bpm. A primeira conduta do emergencista deverá ser:

- A prescrever alteplase.
- B prescrever heparina de baixo peso molecular.
- C solicitar tomografia de crânio sem contraste.
- D solicitar angioressonância magnética.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214025](#)

Questão 96

2024 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)
Etiologias e Fisiopatologia Fisiopatologia

A rotura de um vaso no território do polígono de Willis provoca sangramento PRIMEIRAMENTE no território:

- A Da cisterna da base e consequentemente espaço subaracnoide.
- B Dos ventrículos laterais e consequentemente espaço subaracnoide.
- C Da cisterna magna e consequentemente espaço subaracnoide.
- D Do terceiro ventrículo e consequentemente no aqueduto do mesencéfalo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214024](#)

Questão 97

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Manejo clínico e diagnóstico Toracocentese diagnóstica

Um paciente masculino de 32 anos, tabagista, trabalhador rural está com dispneia aos moderados esforços, tosse seca, perda de 2kg em 3 meses, e dor ventilatoridependente em base de hemitórax direito. Encontra-se hipocorado +/4+, com frequência respiratória de 24 incursões respiratórias por minuto, sem uso de

musculatura acessória, com saturação periférica de O₂ de 95% em ar ambiente. Tem murmúrio vesicular reduzido nos dois terços inferiores de hemitórax direito, redução da ressonância vocal e submacicez à percussão local. Realizou Radiografia de tórax evidenciando opacificação côncava dos dois terços inferiores do hemitórax direito e parábola de Demoiseau. Diante do quadro, foi solicitado avaliação da cirurgia geral para drenagem do derrame pleural sob selo d'água. Sobre o quadro derrame pleural, descrito no caso clínico acima, a conduta relatada está:

- A** correta, deve-se drenar imediatamente o derrame pleural devido ao risco de infecção e de insuficiência respiratória
- B** incorreta, pois deve-se realizar toracocentese diagnóstica com aplicação dos Critérios de Light para saber se trata de exsudato ou transudato e isto guiará se será necessário drenagem torácica em selo d'água
- C** incorreta, pois deve-se realizar mandatoriamente tomografia computadorizada de tórax antes da drenagem torácica sob selo d'água
- D** incorreta, pois deve-se realizar inicialmente toracocentese diagnóstica. A punção da toracocentese é feita rente a borda inferior da costela, para fugir do feixe vâsculo-nervoso e evitar complicações

4000214068

Questão 98

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Drenagem torácica fechada Derrame pleural parapneumônico complicado

Mulher, 56 anos, com pneumonia lobar direita em tratamento com ceftriaxona há 4 dias, evolui com piora da dispneia. Ao exame: PA 110/70 mmHg, FC 104 bpm, FR 26 irpm, Temp 38,3 °C, SpO₂ 93%. Redução do murmúrio vesicular e macicez à percussão em base direita. RX tórax: derrame pleural moderado à direita. Toracocentese diagnóstica: proteína pleural 4,2 g/dl (VR sérica: 6,5-8,1 g/dL), LDH pleural 400 U/L, LDH sérica 180 U/L, pH pleural 7,18 (VR: 7,60-7,64), glicose pleural 40 mg/dL (VR: 60-100). Qual a conduta mais adequada?

- A** Manter apenas antibiótico endovenoso, sem necessidade de drenagem
- B** Repetir toracocentese apenas para alívio sintomático, sem dreno
- C** Inserir dreno de tórax em selo d'água devido a derrame parapneumônico complicado
- D** Indicar pleurodese química imediata.

4000271594

Questão 99

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Capnografia Capnografia

Sobre a capnografia, é correto afirmar:

- A A medida do dióxido de carbono ao final da expiração EtCO₂ expressa, de forma aproximada, o nível da pressão parcial de monóxido de carbono no sangue arterial
- B A fase 1 da curva de capnografia representa o espaço morto, onde o nível de CO₂ é próximo de zero
- C A curva B, quando apresenta uma inclinação prolongada, pode indicar doença restritiva, como DPOC ou asma
- D A interpretação da morfologia da curva B, em conjunto com as outras fases do capnograma e o valor do EtCO₂, não configura um monitoramento confiável para pacientes em anestesia geral

4000271571

Questão 100

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Via aérea difícil Avaliação de Risco Classificação de Mallampati

Um paciente de 45 anos, com histórico de apneia do sono e hipertensão controlada, é submetido a avaliação pré anestésica antes de uma cirurgia eletiva de hérnia inguinal. Durante a avaliação da via aérea, o anestesiológista observa que o paciente apresenta uma abertura de boca de 5 cm, a distância tireoentoniana é de 7 cm, a mobilidade cervical é normal, e durante abertura bucal é visível apenas o palato mole e a base da úvula. Com base no exame físico, qual das seguintes informações é a mais relevante para prever possíveis dificuldades na intubação?

- A A distância tireoentoniana.
- B A abertura bucal.
- C A classificação de Mallampati.
- D O histórico de apneia do sono e hipertensão.

4000241802

Questão 101

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Espirometria Pico de fluxo expiratório

Sobre o diagnóstico da asma, podemos afirmar CORRETAMENTE que:

- A a assertividade do diagnóstico aumenta quanto maior for a variação do VEF1 ou PFE.
- B a assertividade do diagnóstico diminui quanto maior for a variação do VEF1 ou PFE.
- C infecções virais não afetam a reversibilidade do broncoespasmo, não gerando falsonegativos.
- D crises asmáticas graves não interferem nas provas diagnósticas.

4000214023

Questão 102

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Homem, 69 anos, internado na enfermaria do Hospital de Câncer para tratamento cirúrgico e quimioterápico de adenocarcinoma de cólon. No sexto dia de internação, apresenta dor em membro inferior direito, seguida de taquidispneia, taquicardia, dor pleurítica e hemoptise. Está normotenso. A gasometria mostra alcalose respiratória, e o ECG indica taquicardia sinusal com sinais de sobrecarga de ventrículo direito. Qual medida terapêutica apresenta impacto significativo na redução da mortalidade nesse caso?

- A Ácido acetilsalicílico mastigado
- B Inserção do filtro de veia cava
- C Anticoagulação plena com enoxaparina
- D Anticoagulação profilática com heparina

4000241746

Questão 103

2026

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Manifestações clínicas

Diagnostico

Homem de 64 anos, em boa evolução imediata, no segundo dia após gastrectomia subtotal, apresenta dispneia súbita e dor torácica pleurítica. Exame: PA 128/78 mmHg, FC 122 bpm, SpO₂ 88% em ar ambiente. Ausculta com redução do murmúrio vesicular em base direita, sem estertores, Gasometria: PaQ₂ 56 mmHg (VR: 80- 100), PaCO₂ 30 mmHg (VR: 35-45). Eletrocardiograma mostra taquicardia sinusal. Fez fisioterapia ventilatória sem melhora do quadro. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- A Tromboembolismo pulmonar
- B Atelectasia pós-operatória
- C Pneumonia aspirativa
- D Fístula de anastomose

4000271585

Questão 104

2024

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Residência (Acesso Direto)

Rastreamento populacional

Homem de 70 anos procura a UBS para realização de um "check-up". A princípio nega doenças prévias, mas também nunca foi a uma consulta médica de rotina. Somente vai ao Pronto Atendimento quando necessário. Durante a sua avaliação, está assintomático. É tabagista ativo (45 anos/maço), etilista social (3 latas de cerveja aos fins de semana) e nega uso de drogas ilícitas. Não pratica atividade física. Marque a alternativa que apresenta o exame de rastreamento como estratégia de prevenção secundária deste paciente que comprovadamente pode reduzir o risco de morte deste paciente.

- A Tomografia computadorizada de abdome.
- B Endoscopia digestiva alta.
- C Tomografia computadorizada de tórax de baixa dose.
- D Raio X de tórax.

4000214030

Questão 105

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Manifestações extraarticulares

Homem, 19 anos, com dor lombar e rigidez matinal de característica inflamatória. A dor piora após longos períodos de inatividade e melhora com movimentação ou após banhos quentes. No exame físico, o teste de Schöber apresenta elevação de 2 cm. Há história familiar de espondiloartrite e o HLA-B27 é positivo. A manifestação extra-articular mais comum associada a esse quadro é:

- A Nefropatia por IgA.
- B Insuficiência aórtica.
- C Uveíte anterior aguda.
- D Doença inflamatória intestinal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271634](#)

Questão 106

2025 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Fenômeno de Raynaud

Mulher, 25 anos, apresenta episódios intermitentes de alteração súbita na coloração das mãos, que num primeiro momento ficam pálidas, depois azuladas, e, após alguns minutos, hiperemiadas. Os episódios são mais frequentes em situações de estresse emocional ou frio. O exame físico não revela alterações. Os exames laboratoriais mostram FAN, anticentrômero e anti-Scl-70 negativos, VHS de 9 mm (VR: até 20 mm), e a capilaroscopia do leito ungueal é normal. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A Doença de Raynaud
- B Esclerose sistêmica
- C Esclerose cutânea limitada
- D Metahemoglobinemia

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241753](#)

Questão 107

2026 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Hipófise

Uma paciente de 26 anos comparece para avaliação ginecológica de rotina. Relata ter ciclos regulares, com intervalos de 28-30 dias. Ela conta que sua última menstruação começou há 7 dias, tendo duração de 4 dias, com fluxo de intensidade normal. Nega uso de contraceptivos. Qual perfil hormonal é compatível com a fase do ciclo menstrual desta paciente na data da consulta?

- A Secreção pulsátil de GnRH, com FSH e estradiol em ascensão.
- B Liberação contínua de GnRh, com LH e estrogênio em declínio.
- C Secreção pulsátil de GnRH, com LH e progesterona em ascensão.
- D Liberação contínua de GnRh, com FSH e progesterona em declínio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271620](#)

Questão 108

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Quadro clínico Exames complementares Pólipos uterinos

G3 P2 A1, 42 anos, com ciclos regulares, procura atendimento relatando aumento da intensidade do fluxo menstrual há 4 meses. Nega comorbidades ou uso de medicamentos, realizou laqueadura tubária há 5 anos e não apresenta anormalidades no exame físico geral e ginecológico. Seu exame de USG Transvaginal, realizado no 12º dia do ciclo, evidencia útero em anteversão, com volume de 90 cm³ e ecotextura homogênea. Endométrio homogêneo, com espessura de 7 mm e padrão proliferativo, apresentando imagem ecogênica em região fúndica contendo pedículo vascular único, medindo 6 mm. Ovários com textura heterogênea e contornos regulares, à direita com volume de 6 cm³ e à esquerda com 12 cm³, contendo imagem cística simples, anecoica que mede 20 x 19 mm. Qual a causa deste sangramento uterino anormal?

- A Cisto ovariano
- B Mioma submucoso
- C Pólipo endometrial
- D Câncer de endométrio

4000214049

Questão 109

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Quadro clínico Ultrassonografia Videolaparoscopia

Nuligesta, 27 anos, com queixa de dor pélvica há vários anos, relata aumento progressivo da intensidade da dor, dispareunia profunda e dificuldade para engravidar. Exame de USG Transvaginal evidencia imagem cística em ovário direito, hipocogênica em "vidro fosco", sem vascularização interna ao color Doppler. Na videolaparoscopia este cisto apresentou conteúdo denso e achocolatado; também foram visualizadas aderências em ambos os anexos, além de algumas lesões nodulares enegrecidas e azuladas no peritônio vesical e parietal. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- ☐ A Doença inflamatória pélvica crônica.
- ☐ B Endometriose com endometrioma ovariano.
- ☐ C Teratoma imaturo com implantes peritoneais.
- ☐ D Câncer de ovário com disseminação peritoneal.

4000214045

Questão 110

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Tratamento do endometrioma de ovário

Paciente de 35 anos, G1 PN1 A0, comparece ao consultório com queixa de dor pélvica de longa data e dismenorreia intensa (na escala de dor 7/10). Faz uso contínuo e regular de dienogeste 2 mg/dia há 12 meses. À ultrassonografia transvaginal, realizada antes do início do tratamento, mostrava um endometrioma ovariano esquerdo de 4.5 cm. O exame de USG TV atual revela que o endometrioma não regrediu e agora mede 6,5 cm; além disso foram detectados dois pequenos nódulos, sugestivos de endometriose, no ligamento uterossacro. A paciente não deseja engravidar novamente e busca a resolução definitiva, ou o máximo alívio possível, de seus sintomas. Qual a conduta mais apropriada neste caso?

- ☐ A Realizar embolização ovariana para redução do endometrioma e controle da dor.
- ☐ B Propor tratamento cirúrgico com histerectomia total para controle definitivo da dor.
- ☐ C Tratamento cirúrgico com videolaparoscopia para excisão das lesões e do endometrioma.
- ☐ D Manter o tratamento com dienogeste, pois o aumento do endometrioma não indica falha terapêutica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271619](#)

Questão 111

2025 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)

Definições Cisto Hemorrágico roto

Paciente de 17 anos, nuligesta, dá entrada no pronto atendimento com queixa de dor aguda, inicialmente localizada na pelve e que posteriormente se irradiou para o abdome, de intensidade crescente, acompanhada de tonturas. Nega atividade sexual, relata ciclos regulares com intervalo de 28 dias, com DUM há 18 dias. Ao exame físico: dor importante à palpação abdominal, especialmente em fossa ilíaca esquerda, com diminuição dos ruídos hidroaéreos. Exames complementares: bHCG negativo, hemograma com hematócrito diminuído, sem leucocitose. No USG de abdome, sinais compatíveis com hemoperitônio. Qual o diagnóstico?

- ☐ A Torção ovariana
- ☐ B Apendicite supurada
- ☐ C Migração de cálculo renal
- ☐ D Ruptura de cisto do corpo-lúteo

4000241783

Questão 112

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Leiomiomatose uterina Quadro Clínico

Mulher, 46 anos, relata ciclos menstruais regulares, com aumento importante do volume menstrual há 6 meses. Seus exames complementares revelam anemia ferropriva e no ultrassom transvaginal observa-se aumento do volume uterino, contendo imagens nodulares intramurais, hipoecogênicas, homogêneas e regulares; a maior em topografia intramural com componente submucoso > 50%. Qual o diagnóstico?

- A Hemorragia uterina de causa estrutural por hiperplasia endometrial
- B Sangramento uterino anormal de causa estrutural por miomatose uterina
- C Irregularidade menstrual de causa não estrutural associado à perimenopausa
- D Sangramento uterino de causa não estrutural por depleção dos fatores de coagulação

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271615](#)

Questão 113

2025 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)
Hiperprolactinemia Exames complementares Outros exames

Nuligesta, 28 anos, relata ciclos menstruais irregulares, com intervalo longo e dificuldade para engravidar. Está casada há vários anos, tem vida sexual ativa e há 5 anos não faz uso de nenhum método anticoncepcional. No momento está há 6 meses sem menstruar e passou a apresentar saída espontânea de leite pelos mamilos. Há 2 dias colheu exames laboratoriais que evidenciaram teste de gravidez negativo e dosagem TSH normal. Qual o melhor conjunto de exames para complementar a investigação inicial deste caso?

- A T4 livre e T3.
- B FSH e prolactina.
- C Prolactina e estradiol.
- D Estradiol e progesterona.

4000241781

Questão 114

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Doença tireoidiana

G1 PC1 A0, 33 anos, deseja mais um filho, porém vem enfrentando dificuldade para engravidar; relata manter relações sexuais regularmente, tendo suspenso o uso de contraceptivo oral combinado há 3 anos. Neste período notou que seus ciclos se tornaram irregulares, tendo menstruado pela última vez há 8 meses. Ao exame clínico observa-se sobrepeso, pele seca e saída de secreção láctea na expressão mamilar bilateralmente. Exames complementares evidenciam: FSH diminuído, TSH elevado, T4 diminuído e Prolactina aumentada. O exame de USG Transvaginal não evidencia alterações estruturais e a dosagem de BCHG é

negativa. Qual deve ser o foco da abordagem terapêutica inicial?

- A Hipotireoidismo
- B Hiperprolactinemia
- C Disfunção hipotalâmica
- D Falência ovariana prematura

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214047](#)

Questão 115

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMTT Acesso Direto (R1) Privado

Diagnósticos diferenciais de disfunção ovulatória Diagnósticos diferenciais de hiperandrogenismo Diagnóstico laboratorial

Nuligesta, 21 anos, mantém ciclos irregulares que ocorrem a cada 2-3 meses desde a menarca aos 12 anos. Nega atividade sexual nos últimos 2 anos e nunca fez uso de contraceptivos. É sedentária, nega comorbidades, tabagismo ou uso regular de medicamentos. Ao exame físico, presença de acne e seborreia, IMC = 27,65 kg/m², pontuação = 9 na escala de Ferriman-Gallwey; exames cardiopulmonar, abdominal e ginecológico sem anormalidades. Qual conduta propedêutica deve fazer parte da investigação deste quadro clínico?

- A Pesquisar os níveis da proteína ligadora de esteroides sexuais (SHBG) — se estiverem diminuídos, descartar o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos.
- B Dosar níveis séricos de testosterona total — se estiverem elevados, investigar com exame de imagem a presença de tumor adrenal produtor de androgênios.
- C Avaliar níveis de 17-alfa-hidroxiprogesterona na fase folicular do ciclo — se estiverem significativamente elevados suspeitar de hiperplasia adrenal congênita.
- D Realizar dosagem de sulfato de dehidroepiandrosterona (SDHEA) — se estiver diminuída, investigar a presença de tumor ovariano produtor de androgênio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214046](#)

Questão 116

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMTT Acesso Direto (R1) Privado

Diagnósticos diferenciais de hiperandrogenismo Critérios diagnósticos Quadro clínico

Paciente nuligesta, 23 anos, caucasiana, reclama de excesso de pelos corporais, sem outras queixas. Ciclos menstruais regulares, DUM há 10 dias, nega comorbidades, etilismo ou tabagismo. Ao exame físico apresenta pelos espessos, escuros e longos, distribuídos na região do buço, mentoniana, entre as mamas e em algumas outras regiões androgênio dependentes. Na escala de Ferriman-Gallwey a paciente atinge 10 pontos. Como classificar este quadro clínico?

- A Síndrome dos ovários policísticos
- B Falência ovariana prematura
- C Hipogonadismo
- D Hirsutismo

4000241779

Questão 117

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMTT Acesso Direto (R1) Privado

Tratamento das mulheres que não desejam engravidar

Nuligesta, 21 anos, relata menstruações irregulares e infrequentes que ocorrem cerca de 5 vezes por ano. Afirma que desde a menarca aos 11 anos, nunca teve ciclos regulares. Ao exame físico apresenta sobrepeso, acne e pele oleosa. Seu exame de ultrassonografia evidencia ovários com volume aumentado e padrão micropolicístico. Os exames laboratoriais descartam outras fontes produtoras de androgênios. Diante destes dados, o médico indica tratamento com um contraceptivo oral combinado. Qual o efeito benéfico esperado com o uso deste medicamento?

- A Inibição da proliferação endometrial, mediada pelo componente estrogênico.
- B Diminuição da síntese hepática de SHBG, sob influência do componente progestágeno.
- C Inibição da ovulação, com redução da secreção de LH, por atuação no eixo hipotálamo-hipófise.
- D Aumento dos níveis séricos de progesterona, diminuindo a produção de androgênios ovarianos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271616](#)

Questão 118

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMTT Acesso Direto (R1) Privado

Cardiovasculares

Mulher de 51 anos com queixa de fogachos, irritabilidade e insônia comparece para consulta ginecológica. Sua última menstruação ocorreu há 3 anos. Ao exame físico: PA 120/80 mmHg, IMC 27,5 kg/m² e circunferência abdominal 80 cm, sem outros achados relevantes. Quais alterações relacionadas a este quadro clínico contribuem diretamente para o aumento do risco de doenças cardiovasculares?

- A Intensa retenção renal de sódio e água, resultando em hipervolemia
- B Elevação do colesterol LDL e redução da capacidade de vasodilatação
- C Aumento da sensibilidade à insulina e consequente redução da glicemia de jejum
- D Aumento da produção de óxido nítrico, aumento da formação de placas ateroscleróticas

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271613](#)

Questão 119

2025 Processo Seletivo Unificado - PRMTT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Mulher de 50 anos, com queixa de irregularidade menstrual há 6 meses, relata que o intervalo entre suas menstruações se tornou mais longo. Informa que a DUM ocorreu há 4 meses, com sangramento prolongado, durante 10 dias. Simultaneamente vem sentindo irritabilidade, insônia e ondas de calor na face e no troco, seguidas de rubor local. Considerando a evolução natural deste processo, qual resultado laboratorial é esperado ao longo dos próximos anos?

- A Baixos níveis de progesterona.
- B Níveis de FSH reduzidos.
- C Altos níveis de inibina.
- D Níveis de LH normais.

4000241794

Questão 120

2024

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Indicações

Estrogênio

Mulher de 51 anos, com queixa de ondas de calor, irritabilidade e insônia, passou por consulta médica há 30 dias e hoje retorna trazendo os resultados dos exames solicitados. Mamografia: BIRADS 2, USG TV e CCO normais. Hemograma sem alterações, glicemia de jejum 93 mg/dL, colesterol total 189 mg/dL, LDL 100 mg/dL, HDL 45 mg/dL, triglicerídeos 221 mg/dL, TSH 1,67 mUI/L. Ela nega comorbidades, tabagismo ou etilismo. Realizou histerectomia total por miomatose aos 47 anos e nega casos de câncer em parentes de 1º grau. Qual a melhor opção terapêutica?

- A Adesivo de estrogênio isolado - via transdérmica.
- B Estrogênio e testosterona combinados - via oral.
- C Estrogênio e progesterona combinados - via oral.
- D Implante de progestágeno isolado - via subcutânea.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000214051

Questão 121

2024

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Cervicites

Abordagem da paciente com queixa de corrimento vaginal

Anamnese

G2 P2 A0, 24 anos, sem parceiro fixo, compareceu para consulta na UBS com queixa de corrimento vaginal amarelo esverdeado, pruriginoso. No exame especular, além da presença do corrimento, observa-se muco endocervical de aspecto purulento e colo friável. Após confirmar o diagnóstico de IST, a paciente foi tratada com Metronidazol 500 mg 12/12h por via oral, Azitromicina 1g em dose única por via oral e Ceftriaxone 500 mg dose única via intramuscular. Quais agentes etiológicos foram abordados com essa estratégia terapêutica?

- A Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae.
- B Candida albicans, Gardnerella vaginalis e Trichomonas vaginalis.
- C Neisseria gonorrhoeae, Herpes simples e Gardnerella vaginalis.
- D Mobiluncus sp., Chlamydia trachomatis e Candida albicans.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214052](#)

Questão 122

2026 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)
Diagnóstico Quadro clínico

Paciente de 24 anos procura atendimento médico com quadro de dor pélvica de intensidade progressiva há sete dias. Em seus antecedentes relata ter feito tratamento para sífilis há 6 meses e usa implante subdérmico como método contraceptivo. Nega uso de preservativos e mantém múltiplas parcerias sexuais. Ao exame especular observa-se corrimento muco-purulento. Qual dos seguintes critérios confirma a principal hipótese diagnóstica, mesmo da ausência de outros achados?

- A Temperatura axilar $\geq 37,5$ °C
- B Dor à mobilização de colo uterino
- C Leucocitose em sangue periférico
- D Presença de abscesso tubo-ovariano

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271617](#)

Questão 123

2025 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)
Exame físico Introdução Fisiopatologia

Durante o atendimento de uma paciente com queixa de corrimento recorrente, o médico coleta a secreção presente no fundo de saco vaginal para a análise. Ao microscópio ele observa diminuição de leucócitos e presença de "clue cells". O teste das aminas é positivo e análise do pH vaginal evidencia valor $> 4,5$. Que outras características são observadas nesta situação clínica?

- A Corrimento esbranquiçado, causado por um protozoário flagelado, com prurido de intensidade variável que piora no período pré-menstrual.
- B Desequilíbrio da flora vaginal causado pela proliferação de fungos, levando ao aparecimento de sintomas diversos (corrimento, prurido, disúria).
- C Corrimento geralmente profuso, amarelado ou amarelo-esverdeado, acompanhado de ardor genital, sensação de queimação, disúria e dispareunia.
- D Desequilíbrio da flora vaginal, com substituição da flora microbiana dominada por Lactobacillus por bactérias anaeróbias e facultativas, como a Gardnerella.

4000241790

Questão 124

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Colposcopia Tratamento excisional

Paciente de 27 anos é encaminhada para um centro de referência em colposcopia, após receber resultado de CCO compatível com lesão intraepitelial de alto grau. Na colposcopia a JEC é visível, observa-se uma lesão restrita ao colo, com epitélio acetobranco plano e área em mosaico, sem suspeita de invasão ou doença glandular. Considerando que a equipe que presta o atendimento é altamente especializada, qual o procedimento ideal?

- A Intervir - indicar conização.
- B ""Ver e Tratar"" - excisão tipo 1 ou 2.
- C Acompanhar - repetir citologia em 3 meses.
- D Investigar - prosseguir avaliação com biópsia da lesão

4000241785

Questão 125

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Colposcopia Reação em cadeia da polimerase PCR

Paciente de 31 anos realiza teste molecular para detecção de DNA-HPV Oncogenico na UBS. Posteriormente, o resultado deste exame revela a presença de HPV 16. Em seu prontuário médico, estão registrados 4 exames de colpocitologia oncótica, todos normais, o último realizado há 1 ano. De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer de Colo do Útero baseadas na utilização de testes moleculares para detecção de DNA-HPV, qual será a conduta subsequente no caso desta paciente?

- A Realizar cauterização da ectocérvice e da JEC
- B Coletar material para exame de colpocitologia oncótica reflexa
- C Encaminhar para colposcopia já que o HPV 16 tem papel de destaque na carcinogênese
- D Repetir o teste molecular DNA-HPV em 6 meses para identificar se infecção é persistente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271614](#)

Questão 126

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Exames complementares Colposcopia

Mulher de 41 anos, com prole definida e queixa de sinusorragia há 2 meses, procura UBS para entregar resultado de CCO que evidencia a presença de lesão intraepitelial de alto grau (LIEAG). Diante deste resultado, ela é encaminhada para a realização de colposcopia. Neste exame verifica-se a presença de achados anormais, porém a JEC não é completamente visível. De acordo com o Ministério da Saúde, qual a conduta recomendada?

- A Realizar biópsia e avaliação do canal endocervical.
- B Solicitar revisão da lâmina e confirmação do laudo emitido.
- C Propor histerectomia total, pois não há desejo de nova gestação.
- D Tratar processos infecciosos/inflamatórios e repetir CCO em 3 meses.

4000214048

Questão 127

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Fibroadenoma

Mulher hígida, 22 anos, notou a presença de um "caroço" na mama há 1 mês. Uma de suas tias teve diagnóstico de câncer de mama recentemente e está fazendo tratamento. Preocupada, ela passa por consulta da UBS e, ao exame físico, o médico percebe a presença de nodulação fibroelástica, regular, móvel e indolor no quadrante supero lateral da mama D. No USG visualiza-se imagem hipoecóica, homogênea, ovalada, com maior eixo paralelo à pele, localizada às 10h, medindo 1,8 x 1,0 x 1,3 cm. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- A Cisto simples
- B Fibroadenoma
- C Linfonodo intramamário
- D Alteração fibrocística benigna da mama

4000214050

Questão 128

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Fibroadenoma

Mulher jovem, 22 anos, nuligesta, relata ter percebido um tumor na mama esquerda enquanto tomava banho. Assustada, procurou ginecologista que identificou uma lesão no QSL da mama esquerda, medindo 2 cm no maior diâmetro, móvel, de contornos regulares e com consistência fibroelástica. Não foi detectada dor local, reação inflamatória, depressão da pele, nem retração da papila. O exame de USG das mamas evidenciou um tumor sólido, alongado, regular e bem definido, com margens nítidas. Qual o diagnóstico etiológico mais provável?

- A Cisto mamário
- B Tumor filóides
- C Fibroadenoma
- D Doença fibrocística

4000241787

Questão 129

Mulher de 56 anos vem para consulta de rotina. Informa que a menopausa ocorreu aos 50 anos e não fez uso de reposição hormonal por medo de câncer. É sedentária, mas relata que goza de boa saúde, nega tabagismo ou etilismo. Atualmente está incomodada com a ocorrência de perdas urinárias ao tossir ou espirrar. Afirma que os episódios vêm ocorrendo há cerca de 1 ano, com perda de urina em pequena quantidade. Qual a relação do hipoestrogenismo com a sintomatologia descrita?

- ☐ A Aumenta secreção de eletrólitos favorecendo a perda urinária.
- ☐ B Aumenta a espessura do uroepitélio estimulando a produção de urina.
- ☐ C Reduz a vascularização da mucosa uretral favorecendo a ocorrência de incontinência.
- ☐ D Reduz a espessura do epitélio e do tecido conectivo uretral reduzindo a produção de urina.

4000241775

Questão 130

G5 PN4 A1, 44 anos, relata perda de urina, de forma recorrente, sempre que espirra ou tosse. Nega sintomas de urgência miccional. A paciente tem ciclos menstruais regulares e fez laqueadura tubária aos 38 anos. Nega comorbidades e não faz uso de medicamentos. Qual das seguintes alterações tem maior correlação com o quadro clínico descrito?

- ☐ A Contrações não inibidas do músculo detrusor.
- ☐ B Processo fibroadenocarcinoma afetando o esvaziamento vesical.
- ☐ C Atrofia da mucosa vaginal comprometendo a coaptação uretral.
- ☐ D Junção uretrovesical em posição abaixo da borda inferior da sínfise púbica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271618](#)

Questão 131

Nas décadas de 1960, 70 e 80 o sistema de saúde brasileiro enfrentava graves problemas de acesso à saúde, com serviços fragmentados e que não atendiam a totalidade da população, ausência de participação popular e forte influência do setor privado, e este cenário foi um dos motivadores do movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Com base nesse processo histórico da reforma sanitária brasileira, assinale a alternativa correta:

- A A Reforma Sanitária inspirada pelos sistemas de saúde inglês e canadense teve como objetivo principal ampliar o mercado privado de saúde, fortalecendo planos e seguros
- B O movimento da Reforma Sanitária buscou garantir um sistema de saúde público, onde a saúde era tida como direito universal dos cidadãos e dever do Estado
- C A Reforma Sanitária propôs a criação de um sistema de saúde público, que culminou na criação do SUS, mas não propôs a inclusão participação e controle social na gestão do SUS.
- D O processo da Reforma Sanitária foi conduzido profissionais e estudantes das diversas áreas da saúde e pesquisadores. Demais setores da sociedade não foram envolvidos neste processo

4000271605

Questão 132

2025 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Princípios e Diretrizes do SUS na Constituição Federal Princípios e Diretrizes do SUS na Lei n 8080/1990

Yvon, 30 anos, haitiano residente em Cuiabá, após ser atendido na unidade de pronto atendimento (UPA) por conta de um pico hipertensivo procurou a unidade de saúde da família (USF) em seu bairro para consulta médica. Durante o atendimento, o médico avaliou e viu a necessidade de um atendimento especializado e encaminhou o mesmo para uma avaliação com o cardiologista. Após a consulta, Yvon procurou a recepção para solicitar o agendamento e foi informado pela recepcionista que devido o mesmo ser de outro país não teria acesso ao especialista. Diante do caso e considerando as diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta:

- A O princípio da universalidade garante meramente ao imigrante residente no Brasil os atendimentos de urgência, emergência e atenção básica, sem a necessidade deste comprovar residência no Brasil.
- B A informação dada pela recepcionista está correta, já que o acesso aos outros níveis de atenção dos serviços de saúde, ou seja, a integralidade do cuidado se destina meramente aos brasileiros natos.
- C A informação dada pela recepcionista está incorreta, uma vez que estrangeiros residentes possuem os mesmos direitos de acesso aos serviços de saúde fornecidos pelo SUS que os brasileiros natos.
- D O atendimento dado ao imigrante na UPA foi correto, já que o atendimento de urgência e emergência são universais. O atendimento realizado na USF foi irregular, pois os imigrantes não têm acesso a atenção básica.

4000241829

Questão 133

2026 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Princípios e Diretrizes do SUS a serem operacionalizados pela Atenção Básica

João, 60 anos começou a sentir falta de ar e cansaço excessivo. Preocupado, decidiu procurar atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ao chegar na UPA, João foi atendido pela recepcionista e encaminhado para a sala de triagem, onde a enfermeira ouviu atentamente suas queixas e definiu a prioridade para o seu atendimento. Posteriormente, João foi atendido pelo médico que realizou a avaliação completa, considerando não apenas a sua falta de ar e cansaço, mas seu histórico médico, condições de vida e aspectos emocionais. João realizou exames laboratoriais e de imagem e a partir dos resultados foi

diagnosticado com uma condição cardíaca que necessitava de acompanhamento com cardiologista, sendo então encaminhado para um cardiologista em um hospital de referência via central de vagas. Considerando o caso ilustrado e os princípios do SUS assinale a alternativa que corresponde aos princípios do SUS presentes na situação ilustrada.

- A Universalidade, Integralidade, Atenção humanizada
- B Universalidade, Hierarquização e Descentralização.
- C Integralidade, Regionalização e Hierarquização.
- D Atenção humanizada, Descentralização e Integralidade

4000271612

Questão 134

2024 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Atributos gerais da Atenção Primária à Saúde APS

A Atenção Primária à Saúde (APS) pode ser definida como "atenção de primeiro contato, contínua, global e coordenada que se proporciona à população sem distinção de gênero, doença ou sistema orgânico. Sobre os atributos da APS, é correto se afirmar que:

- A tido como o princípio soberano, a atenção ao primeiro contato/ acesso é essencial para o bom funcionamento e racionalidade do sistema de saúde e depende da acessibilidade aos serviços de saúde. a não garantia deste princípio fere um atributo essencial e faz o escore de avaliação da aps cair.
- B o atributo da longitudinalidade pode ser definido como a existência de uma fonte regular de atenção e seu uso ao decorrer do tempo. este cuidado deve ser dado pelo mesmo profissional que iniciou o cuidado, uma vez que o vínculo entre profissional e paciente está estabelecido.
- C já o atributo da coordenação envolve a continuidade da informação dentro do sistema. a referência e a contra-referência são ferramentas essenciais para a coordenação do cuidado. por se aplicar ao ambito administrativo, a coordenação do cuidado não exerce influência na concretização da longitudinalidade e integralidade.
- D no brasil, o atributo da integralidade pode ser entendido como a integração de assistência e prevenção no âmbito das políticas especiais. por se tratar de políticas especiais, neste contexto não há o diálogo das políticas públicas com os conceitos das ciências sociais, como da antropologia e os fatores culturais da população.

4000214081

Questão 135

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Atributos gerais da Atenção Primária à Saúde APS

Maria José, 65 anos, hipertensa e diabética é atendida há 15 anos na unidade de saúde da família (USF) do seu bairro, onde realiza as consultas de acompanhamento, retirada de medicamentos, vacinação e coleta de exames. Mensalmente, ele recebe a visita da ACS Joana, que é a responsável pela microárea onde reside. No

contexto da Estratégia Saúde da Família, os atributos que podem ser identificados na situação ilustrada são:

- ☐ A Adscrição da clientela e Universalidade;
- ☐ B Equidade e Territorialização;
- ☐ C Coordenação do cuidado e primeiro contato;
- ☐ D Longitudinalidade do cuidado e Integralidade.

4000241824

Questão 136

2025 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Lei n 81421990

A 17ª Conferência Nacional de Saúde, que teve como tema "Garantir Direitos, defender o SUS, a Vida e a Democracia - Amanhã vai ser outro dia!" aconteceu no período de 2 a 5 de julho de 2023 e reuniu aproximadamente seis mil pessoas delegadas, convidados e observadoras de todo o Brasil. A participação comunitária e o controle social são princípios fundamentais do SUS garantidos por meio da(o):

- ☐ A Lei Orgânica da Saúde 8080 de 1990
- ☐ B Lei Orgânica da Saúde 8142 de 1990
- ☐ C Decreto 7508 de 2011
- ☐ D Portaria nº 648/GM de 2006

4000241820

Questão 137

2025 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Pacto pela Saúde Outras normativas do SUS e da Saúde em geral

O Sistema Único de Saúde (SUS) completou 35 anos em 2023, consolidando-se como a maior e mais duradoura política social pública do Brasil. Considerando a trajetória do SUS, seu arcabouço legal, programas e políticas, analise a afirmativa a seguir: "São considerados como marcos para o desenvolvimento do SUS e seu eixo central para promover a extensão da cobertura de acesso aos serviços de saúde: a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1991, o Programa Saúde da Família (1994) posteriormente transformado em Estratégia Saúde da Família (ESF) (1ª parte). Os Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão foram resultado de um grande acordo entre o Ministério da Saúde CONASS e CONASEMS, que definiu as instâncias das comissões intergestores Tripartite e Bipartite como fórum privilegiado dos novos mecanismos de gestão para as competências concorrentes nas três esferas de governo e trouxeram vantagens burocráticas, que peritiu a inversão da lógica da histórica que privilegiava um planejamento descente para um planejamento que leva em conta as necessidades da população e do sistema de saúde (2ª parte)". A sentença está:

- A Totalmente correta;
- B Correta somente em sua 1ª parte;
- C Correta somente em sua 2ª parte;
- D Totalmente incorreta.

4000241825

Questão 138

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Financiamento na Constituição Federal CF1988

Um município de médio porte de Mato Grosso enfrenta dificuldades para manter o custeio da Atenção Básica à Saúde. Durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), os gestores discutem a aplicação das normas vigentes de financiamento do SUS. Considerando as portarias brasileiras atuais que regulamentam o financiamento federal, assinale a alternativa correta:

- A O financiamento da Atenção Básica é realizado por meio de repasses fixos, sem considerar desempenho das equipes de saúde ou cadastros de usuários na Estratégia Saúde da Família.
- B A Portaria nº 3.992/2017 extinguiu os blocos de financiamento e instituiu a transferência fundo a fundo em duas modalidades: custeio e investimento para reforma das unidades de saúde.
- C O financiamento federal da Atenção Básica em 2025 ocorre apenas por meio de incentivos específicos para programas como Saúde da Família, equipes e-Multi.
- D O Previnir Brasil redefiniu o modelo de financiamento da Atenção básica, incluindo captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

4000271599

Questão 139

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Conceitos gerais sobre as RAS

Em uma Unidade de Saúde da Família (USF) foi atendido um paciente com hipertensão arterial descontrolada, apesar de acompanhamento regular. O médico da equipe considera encaminhá-lo para avaliação especializada em cardiologia. Com base nos princípios da Rede de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa que corresponde ao processo correto de encaminhamento deste paciente.

- A O encaminhamento deve ser feito diretamente para o hospital de alta complexidade, sem necessidade de acionar a central de regulação de vagas do município
- B O residente deve solicitar que o paciente procure atendimento particular, já que a RAS não contempla especialidades no nível da atenção básica
- C O paciente deve ser encaminhado para o nível de média complexidade de atenção, por meio da regulação feita pela central de vagas, garantindo continuidade do cuidado
- D O encaminhamento para os níveis de especialidade é feito meramente em casos de urgência e emergência de doenças crônicas ou para situações de manifestação aguda de doenças

4000271606

Questão 140

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Program Saúde da Família PSF e Estratégia Saúde da Família ESF

A Atenção Domiciliar (AD) baseia-se na interação do profissional com a pessoa, com sua família, e se constitui um conjunto de atividades realizadas no domicílio de forma programada e continuada, conforme a necessidade. Considerando a AD no contexto da Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que:

- A a AD se organiza em três modalidades de cuidados. A modalidade AD3 se destina a atender as pessoas com problemas de saúde, com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até a unidade básica de saúde, com maior frequência de cuidado, recursos de saúde, acompanhamento contínuo, sem o uso de equipamentos tecnológicos.
- B o cuidado das pessoas que se inserem nas modalidades AD2 e AD3 passa a ser de responsabilidade das Equipes Multiprofissionais de Assistência Domiciliar (EMADs), e fica a cargo da ESF o cuidado das famílias que se inserem na AD1. Em áreas não cobertas pela EMAD, a ESF assume o cuidado das pessoas nas modalidades 2 e 3.
- C a Visita Domiciliar (VD) é uma atribuição específica do agente comunitário de saúde e da equipe de enfermagem (técnicos e enfermeiros). Para que seus objetivos sejam alcançados, é importante que o profissional revise o prontuário com os dados da pessoa ou família a ser visitada e agende com o morador o dia e horário para a VD.
- D a VD prioriza o diagnóstico da realidade do indivíduo e ações educativas. Apesar de ser amplamente realizada na ESF, dados institucionais apontam que a VD não tem impactado positivamente na abordagem de famílias de risco e multiproblemáticas, na redução da institucionalização de crianças e diminuição de situações de violência.

4000214069

Questão 141

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Program Saúde da Família PSF e Estratégia Saúde da Família ESF

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Em relação a ESF assinale alternativa correta.

- A** A ESF nas últimas décadas tem contribuído para o alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), principalmente nos indicadores relacionados a saúde materno-infantil. Estudos nacionais também indicam o impacto positivo da ESF na redução das iniquidades em saúde.
- B** A expansão da ESF a partir da década de 1990 proporcionou impactos positivos na saúde da população, sendo este impacto limitado ao público residente nos municípios menores e carentes e as regiões de maior vulnerabilidade, como os bolsões de pobreza dos grandes centros.
- C** A Política Nacional de Atenção Básica (PNAD) foi criada em 2006 e propôs a mudança de nomenclatura de PSF para ESF, além de que a estratégia para o fortalecimento da ESF seria a manutenção do modelo sanitaria campanhista atrelado ao modelo médico assistencial privatista e hospitalocêntrico.
- D** A ESF é definida como a porta de entrada ou como o primeiro nível de atenção na Rede de Assistência à Saúde (RAS). A RAS deve atuar de maneira centralizada e verticalizada com os demais níveis de assistência, visando o aprimoramento e aperfeiçoamento do princípio da regionalização.

4000214083

Questão 142

2025 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)

Program Saúde da Família PSF e Estratégia Saúde da Família ESF

Na Atenção Básica (AB), várias ações são realizadas no domicílio, como o cadastramento, busca ativa, ações de vigilância e de educação em saúde. Com base nas características da Atenção Domiciliar (AD) na AB básica, analise as afirmativas a seguir:

I - Na AD a equipe de saúde deve respeitar o espaço da família, ser capaz de preservar os laços afetivos das pessoas e fortalecer a autoestima, ajudando a construir ambientes mais favoráveis à recuperação da saúde.

II - A realização da AD favorece o estabelecimento de vínculos entre a equipe de saúde e a família, assim como a compreensão de aspectos importantes da dinâmica familiar das famílias que possuem o perfil para o atendimento familiar. Em relação as afirmativas acima, assinale a alternativa correta:

- A** A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.
- B** A afirmativa II está correta e a afirmativa I está incorreta.
- C** As afirmativas I e II estão corretas e se complementam.
- D** As afirmativas I e II estão corretas e não se complementam.

4000241818

Questão 143

2026 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Política Nacional de Humanização

Uma paciente em situação de rua procura atendimento na USF com queixa de dor abdominal inespecífica. Ela relata dificuldade de acesso a alimentação e higiene. A partir dos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa que apresenta a conduta correta a ser adotada pela equipe de

saúde.

- A** A equipe de SF deverá se concentrar em atender a queixa clínica, desconsiderando os determinantes sociais da saúde, como previsto no princípio da corresponsabilidade presente na PNH. A equipe e-Multi da unidade deverá dar continuidade ao atendimento e realizar os encaminhamentos necessários aos demais serviços
- B** Como a paciente não apresenta sinais de urgência e pela condição de moradia da paciente, a equipe da USF deverá encaminhar a paciente para o serviço de Consultório de rua. De acordo com o eixo de articulação da rede de serviços da PNH os atendimentos de moradores em situação de rua deverão ser realizados meramente por esta equipe.
- C** Considerando a clínica ampliada e a corresponsabilização presentes na PNH, a equipe de SF deverá realizar a escuta qualificada, prestar o atendimento necessário e encaminhar a paciente ao centro de referência de assistência social (CRAS) para que as demais necessidades sejam atendidas.
- D** A equipe de SF deverá realizar a escuta qualificada, identificar as necessidades da paciente e encaminhá-la aos serviços específicos para os moradores em situação de rua, como o consultório de rua e o CRAS, uma vez que pela sua especificidade esta paciente não é caracterizada como público-alvo da estratégia saúde da família.

4000271604

Questão 144

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Políticas de Saúde para Populações Específicas

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) foi lançada pelo Ministério da Saúde, em 2004, e ampliou o cuidado ofertado as mulheres, principalmente a grupos antes isolados das políticas públicas. Em relação ao cuidado da saúde da mulher, assinale a alternativa correta.

- A** A mulher deve ser estimulada a buscar os serviços de saúde para a promoção da saúde e a prevenção de doenças, sendo a unidade de saúde da família a porta de entrada específica no SUS, com o acionamento da Rede de Atenção à Saúde quando necessário para a garantia dos direitos do SUS como a integralidade, equidade e resolutividade.
- B** No Brasil, embora tenha ocorrido a ampliação do acesso ao exame preventivo de câncer de colo de útero, esta medida não tem sido suficiente para reduzir a tendência de mortalidade por câncer de colo uterino, uma vez que em muitas regiões, o diagnóstico ainda é realizado em estágios mais avançados da doença.
- C** Durante a consulta a mulher deverá ter suas queixas ouvidas e reconhecidas. Caso no momento da consulta esta não deseje procurar alívio para a seus sintomas, a equipe de saúde deverá respeitar esta opção. A mulher deverá ser esclarecida de que a responsabilidade do acompanhamento da saúde passa a ser meramente sua.
- D** Os programas adotados anteriormente pelo Ministério da Saúde atuavam de maneira restrita à saúde materna ou à ausência de agravos ligados à reprodução biológica. Com a criação do SUS na década de 1990, é que ações integrais voltadas a mulher desde a adolescência e todos os ciclos de vida da mulher passaram a ser realizadas.

Questão 145

2024

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Políticas de Saúde para Populações Específicas

Em 2009 foi lançada pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). Em relação a PNAISH e as características do público por ela contemplado, assinale a alternativa correta.

- A** A organização da PNAISH em eixos temáticos tem sido alvo de crítica de diversos autores, já que desta maneira a PNAISH coloca em risco toda a discussão sobre a complexidade do problema e se torna parcial, ao desconsiderar a importância dos fatores socioculturais relacionados a morbimortalidade por causas externas.
- B** Os determinantes sociais da saúde como raça/cor, renda e estágios do ciclo da vida individual e familiar deverão ser considerados no entendimento de condição de saúde do homem, bem como a sua relação com os serviços de saúde. A representatividade social da masculinidade não é considerada um fator de risco para a saúde deste público.
- C** No Brasil, ocorre um excesso de mortes entre os homens devido a causas potencialmente evitáveis, que em maior ou menor grau são atribuídas a estilo de vida e atividades arriscadas. Estes fatores se distribuem de maneira uniforme em todas as faixas etárias contempladas pela PNAISH.
- D** O câncer de próstata está entre as principais causas de morte em homens. Por isso, nas unidades básicas de saúde são realizadas ações de rastreio por meio da dosagem de antígeno prostático específico e toque retal. Estas ações tem contribuído na redução da mortalidade por neoplasias e na mortalidade geral dos homens que as realizam.

4000214074

Questão 146

2025

Acesso Direto (R1)

Privado

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Políticas de Saúde para Populações Específicas**Política Nacional de Atenção Básica PNAB**

Juliana (30 anos) é a mãe de Davi (1ano e 3 meses) e de Helena (8 anos). Ao buscar atendimento na Unidade de Saúde da Família (USF) do seu bairro para a realização do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos seus filhos, Juliana foi informada que seria realizado somente o acompanhamento de Davi, já que Helena está fora da idade prevista para este atendimento pela USF já que se encontra em idade escolar, não sendo mais considerada como público-alvo da equipe de Saúde da Família (eSF). Considerando a situação ilustrada e o que está proposto na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), a informação recebida por Juliana está:

- A Correta, uma vez que a realização do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na USF é destinado somente a crianças com idade até 02 anos de vida.
- B Incorreta visto que o atendimento na USF para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil abrange crianças com até 12 anos de idade.
- C Correta, já que Helena se encontra em idade escolar e este atendimento passa a ser responsabilidade do Programa de Saúde na Escola (PSE) e não mais da eSF.
- D Incorreta, uma vez que a realização do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento deve ser realizado até 9 anos de idade pela eSF.

4000241822

Questão 147

2026 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Políticas de Saúde para Populações Específicas

Durante uma reunião de equipe em uma Unidade Básica de Saúde um dos médicos destaca que muitas usuárias procuram atendimento apenas para questões relacionadas à gestação, enquanto outras demandas, como saúde mental, prevenção de doenças crônicas e violência doméstica, acabam sendo negligenciadas, e que desta maneira, a equipe de saúde deve realizar ações para a conscientização das mulheres para os outros aspectos relacionados a sua saúde. Com base nos princípios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), assinale a alternativa correta:

- A As ações relacionadas ao período gestacional estão entre as ações que mais impactam os indicadores epidemiológicos relacionados a saúde da mulher, por isso, a PNAISM recomenda que as equipes de saúde direcionem os atendimentos meramente para este tipo de ação.
- B A proposta realizada pelo médico está concordante com os eixos estratégicos da PNAISM, que prevê a realização de ações voltadas a prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, a integralidade e promoção da saúde, além de ações de inclusão e equidade.
- C As ações voltadas à saúde da mulher devem ser ampliadas, além da saúde reprodutiva como apontado pelo médico, com exceção da saúde mental, que não está contemplada na PNAISM, além do fato de ser prestada no nível assistencial de média complexidade.
- D Os eixos estratégicos da PNAISM direcionam a realização das ações voltadas as mulheres residentes nas áreas urbanas e rural, que estão livres ou privadas de liberdade ou em situação de rua, sendo estas ações realizadas meramente na atenção básica e de média complexidade.

4000271607

Questão 148

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Políticas de Saúde para Populações Específicas

Durante uma roda de conversa em uma comunidade rural, um médico percebe que os homens relatam dificuldade em acessar os serviços de saúde, principalmente por incompatibilidade de horários com o trabalho, e que por isso buscam o atendimento para o tratamento quando já apresentam sintomas. Com base na Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH), assinale a alternativa correta:

- A** A PNAISH incentiva estratégias para ampliar o acesso, como horários alternativos e ações fora da unidade. O que tem ocorrido nesta comunidade rural está em desacordo com o previsto no eixo de acesso e acolhimento da PNAISH.
- B** O eixo temático de doenças prevalentes na população masculina da PNAISH foca no tratamento de doenças crônicas que afetam predominantemente os homens, assim, o atendimento voltado meramente para a prática curativista está de acordo com esta política.
- C** O tipo e local de trabalho realizado pelo homem e as ações de saúde ocupacional não estão contemplados nos eixos da PNAISH, uma vez que esta temática já é considerada nas ações realizadas pela Vigilância em Saúde do trabalhador.
- D** As dificuldades de acesso relatadas pelos homens da comunidade rural na roda de conversa fogem ao escopo dos eixos temáticos da PNAISH, sendo que esta necessidade deve ser discutida nas reuniões do conselho gestor da unidade de saúde.

4000271608

Questão 149

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Abordagem Familiar

A situação de saúde das crianças brasileiras apresenta mudanças significativas, como a redução das doenças infecciosas e o surgimento de novas morbidades que requerem abordagens diferentes. Em relação a saúde da criança, é correto o que se afirma em:

- A** o processo saúde-doença da criança é influenciado pelo momento do seu processo de crescimento e de desenvolvimento, além da sua inserção social, sendo a vulnerabilidade biológica diretamente proporcional a idade da criança.
- B** a atenção à criança deve ser voltada ao atendimento curativo por conta da complexidade de se estruturar ações visando a modificação de ambientes e alternativas de vida mais saudáveis.
- C** em situações de violência doméstica vivenciadas pela criança, o médico de família e comunidade poderá identificar as queixas de saúde durante a consulta. situações observadas na visita domiciliar não poderão ser consideradas.
- D** no acompanhamento de crianças pré-escolares e escolares devem ser incluídas as crianças com ou sem patologia crônica ou em condição crônica de saúde que residem na área de abrangência da unidade de saúde da família.

4000214077

Questão 150

2025 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Genograma Ecomapa

A abordagem familiar deve estar presente transversalmente nas discussões na área da saúde. O genograma e o ecomapa são instrumentos importantes a serem utilizados no campo social e de saúde para identificar os fatores de risco na dinâmica familiar e compreender as redes de apoio social, familiar e de saúde. Observe na Figura 1 o genograma e o ecomapa da família de uma paciente: A Figura 1. Genograma e Ecomapa de uma

família. Fonte: Sá et al., 2022. Considerando as características do Genograma e Ecomapa, e as informações presentes na Figura 1, assinale a alternativa correta:

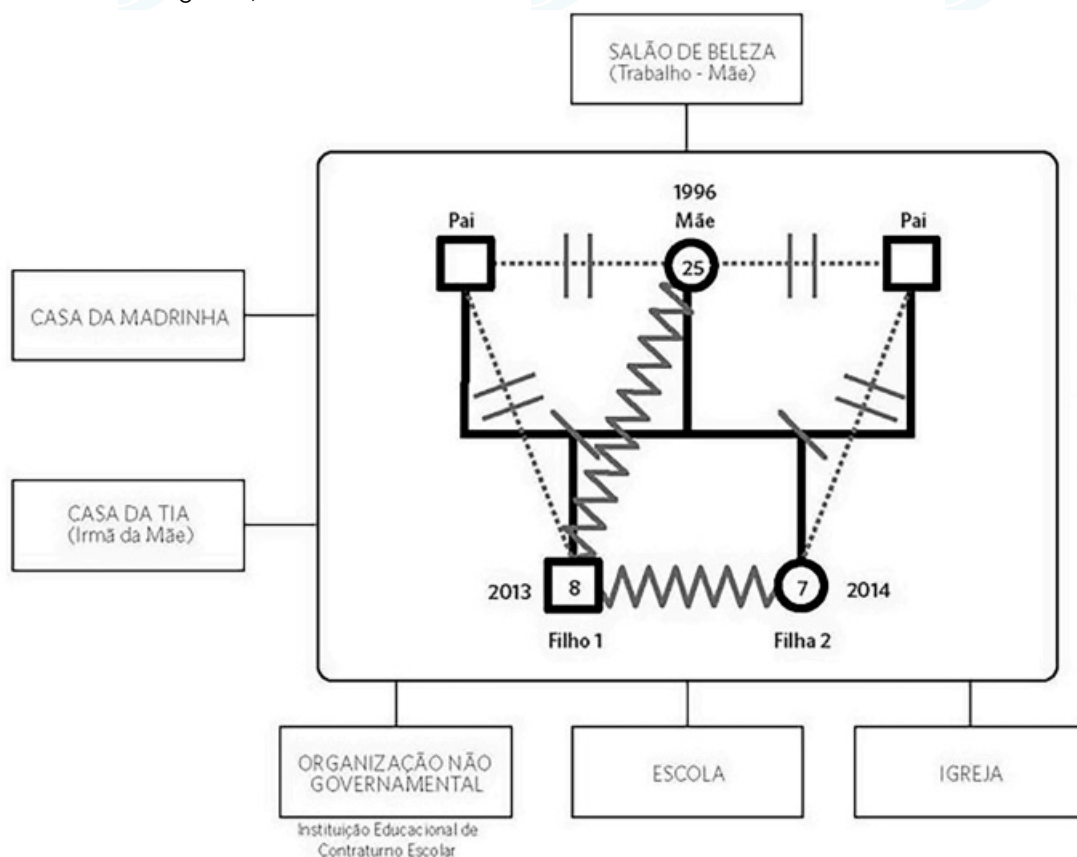


Figura 1. Genograma e Ecomapa de uma família.
Fonte: Sá et al., 2022

- A** No Genograma é possível verificar o relacionamento harmônico entre a mãe e os filhos e entre os irmãos. Porém, os filhos não possuem um relacionamento próximo com os seus genitores, sendo o comportamento distante também observado entre a mãe e seus antigos parceiros.
- B** O Genograma e o Ecomapa auxiliam no mapeamento das relações familiares e sua rede de apoio, como demonstrado na Figura 1, onde as casas da madrinha e tia e a organização não governamental representam as redes de apoio desta família.
- C** O Genograma e o Ecomapa devem ser usados meramente na atenção básica para usuários com resistência a adesão ao tratamento, poli queixosos e /ou em situação de vulnerabilidade social. A sua utilização não se aplica nos serviços de saúde dos demais níveis de atenção (média e alta complexidade).
- D** O Ecomapa permite o reconhecimento das relações da família ou usuário com a comunidade e deve indicar o equilíbrio entre as necessidades, as vulnerabilidades e os riscos. O Ecomapa apresentado representa adequadamente a intensidade das relações estabelecidas entre a família e a comunidade onde residem.

4000241815

Questão 151

2026 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT
Abordagem Comunitária

Uma UPA localizada em uma capital brasileira enfrenta aumento expressivo de casos de dengue durante o período chuvoso. A emergência está sobrecarregada, há escassez de insumos para hidratação venosa e o

tempo de espera para atendimento ultrapassa 4 horas. A equipe gestora da UPA decide elaborar um planejamento estratégico situacional (PES), com foco na resposta imediata ao surto e na reorganização do fluxo assistencial. Considerando os fundamentos do PES, assinale a alternativa que representa a primeira etapa correta a ser realizada nesse processo:

- A Definir metas quantitativas de redução do tempo de espera e propor indicadores de desempenho.
- B Identificar os problemas prioritários de forma participativa, analisando causas, atores envolvidos e governabilidade.
- C Elaborar um plano de ação com cronograma e responsáveis definidos para cada atividade, bem como os custos e materiais necessários para a execução.
- D Avaliar os resultados obtidos após a implementação das medidas, comparando-os com os indicadores estabelecidos.

4000271600

Questão 152

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Abordagem Comunitária

Durante o processo de territorialização de uma equipe da Estratégia Saúde da Família em uma comunidade urbana, os profissionais identificaram que os limites geográficos oficiais do bairro não correspondiam à dinâmica real de circulação das pessoas. Muitos moradores buscavam serviços em áreas vizinhas, havia sobreposição de famílias cadastradas em diferentes unidades e parte da população não estava vinculada a nenhuma equipe. Diante dessa situação, qual deve ser a ação correta da equipe de saúde para garantir a efetividade da territorialização?

- A Manter os limites oficiais do bairro como referência exclusiva, assegurando que o cadastro siga apenas os dados administrativos
- B Redefinir o território considerando fluxos populacionais, vínculos sociais e utilização real dos serviços, mesmo que ultrapasse os limites oficiais
- C Solicitar que os moradores se adequem ao território oficial, orientando-os a procurar apenas a unidade de saúde correspondente ao seu endereço
- D Suspender o processo de territorialização até que haja uma decisão da gestão municipal sobre os limites formais do bairro

4000271602

Questão 153

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Cuidados paliativos

Uma das habilidades necessárias em cuidados paliativos é a avaliação quanto ao prognóstico que possibilita cuidar e propor um plano terapêutico proporcional à fase da doença e tempo de vida do paciente. Marque a alternativa que contém as variáveis analisadas na escala Palliative Performance Index (PPI):

- A Ingesta oral, edema, dispneia, delirium, PPS
- B Metástases, edema, albumina, delirium, PPS
- C Número de internações, PPS, ingesta oral, pressão arterial, edema
- D Metástase à distância, ingesta oral, saturação, albumina

4000241761

Questão 154

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Cuidados paliativos

Mulher de 66 anos, com adenocarcinoma de ovário estágio IV, procura o pronto atendimento por vômitos persistentes, distensão abdominal e dor tipo cólica há 48 horas. Refere parada de eliminação de gases há 36 horas. Usa ondansetrona 4 mg VO 8/8h, sem melhora. Ao exame: PA 118/72 mmHg, FC 102 bpm, FR 20 irpm. Temperatura 36,7°C, SpO₂ 97%. Abdomo distendido, hiper timpânico, sem sinais irritação peritoneal. TC abdominal demonstra obstrução total do delgado por carcinomatose peritoneal, sem indicação cirúrgica. Considerando os mecanismos farmacológicos dos antieméticos, qual é a melhor opção para controle de náuseas e vômitos neste cenário?

- A Ondansetrona, antagonista 5-HT₃ de ação periférica e central, atuando principalmente em quimiorreceptores gastrointestinais.
- B Metoclopramida em altas doses, agonista 5-HT₄ e antagonista D₂, aumentando motilidade do trato gastrointestinal (procinético).
- C Haloperidol, antagonista dopaminérgico D₂ atuando na zona gatilho quimiorreceptora (ZGC) sem alterar motilidade gastrointestinal.
- D Lorazepam, modulador GABA-A com ação ansiolítica sobre o córtex límbico, reduzindo percepção emocional da náusea.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271631](#)

Questão 155

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Cuidados paliativos Dispneia refratária

Princípios bioéticos fundamentais ou principialistas ou principialismo Beauchamp e Childress

Homem de 78 anos, com fibrose pulmonar idiopática avançada, chega ao pronto atendimento com dispneia intensa em repouso. Usa oxigênio domiciliar 4 L/min há 1 ano. Refere que já discutiu previamente com sua equipe de cuidados paliativos e registrou em prontuário sua Diretiva Antecipada de Vontade (DAV), expressando que não deseja intubação orotraqueal nem tratamento em UTI caso ocorra piora respiratória. Chega ao pronto atendimento ansioso, taquipneico, com uso de musculatura acessória. Ao exame: PA 132/76 mmHg, FC 108 bpm, FR 32 irpm, Temp 36,4 °C, SpO₂ 88% em máscara de Venturi 50%. Ausculta: crepitações bibasais. A filha, advogada, está presente e exige que o paciente seja "levado imediatamente para a UTI e entubado, e que faça tudo para salvar a vida dele". Considerando os princípios éticos, legais e clínicos, qual a conduta mais indicada?

- A** Intubar o paciente e encaminhar para UTI, priorizando a decisão da família diante da gravidade do quadro e risco iminente de morte.
- B** Administrar opioide (Morfina) e ansiolítico (Midazolam) e solicitar parecer jurídico para definir se a DAV tem valor legal antes de qualquer conduta.
- C** Suspender todo manejo respiratório para não prolongar o sofrimento, segundo a DAV e oferecendo sedação profunda com Midazolam em bomba de infusão.
- D** Manter suporte ventilatório não invasivo e administrar opioides (morfina) em baixas doses para controle da dispneia, explicando à família que a DAV deve ser respeitada.

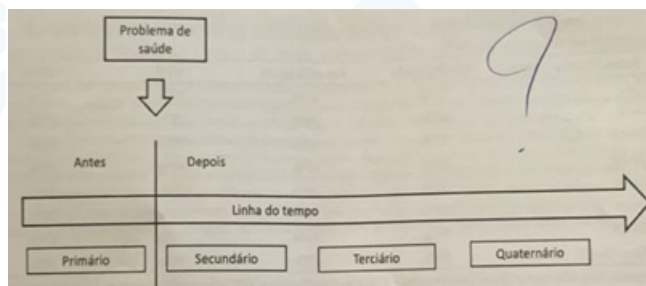
4000271632

Questão 156

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Níveis de Prevenção e outros conceitos associados Prevenção Quaternária

No ambiente clínico, as atividades de cuidado preventivo podem, frequentemente, ser incorporadas ao cuidado permanente dos pacientes. Dependendo do momento do curso da doença em que as intervenções são realizadas, as ações de prevenção serão classificadas, como sintetizado na imagem abaixo. Considerando as ações que podem ser realizadas como pacientes individuais e também com a comunidade e os conceitos relacionados aos níveis de prevenção, é correto afirmar que:



- A** entre as ações que se inserem no nível de prevenção primário estão a promoção da saúde e a proteção específica, com foco no indivíduo, uma vez que a implementação destas ações no nível comunitário enfrentam as limitações impostas pelos determinantes sociais em saúde.
- B** a prevenção secundária detecta a doença precocemente, quando se inicia a manifestação dos primeiros sinais clínicos e o tratamento pode impedir o seu avanço. Como exemplo pode ser mencionado a retirada de um adenoma pré-canceroso durante a realização de uma colonoscopia.
- C** as ações realizadas na prevenção terciária objetivam reverter a deteriorização causada pela doença, alcançando a cura do paciente e reduzindo o risco do óbito. As morbidades que apresentam longo percurso de duração, especialmente as que demandam ações de reabilitação não estão incluídas neste nível de prevenção.
- D** de acordo com a WONCA (1995), a prevenção quaternária pode ser compreendida como a ação feita para identificar um paciente ou população em risco de supermedicalização, protegê-los de uma intervenção médica invasiva e sugerir procedimentos científicos e eticamente aceitáveis.

4000214071

Questão 157

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Prevenção Primária Prevenção Secundária Prevenção Terciária

Durante a campanha do Novembro Azul, um município elaborou um plano de ação para reduzir a mortalidade por câncer de próstata. Entre as medidas propostas estavam: 1. Realização de palestras comunitárias sobre hábitos saudáveis e redução de fatores de risco (alimentação, atividade física, cessação do tabagismo). 2. Oferta de consultas médicas para homens acima de 50 anos, com solicitação de exames laboratoriais e de imagem conforme protocolos clínicos. 3. Acompanhamento de pacientes já diagnosticados com câncer de próstata, garantindo acesso a tratamento oncológico e suporte multiprofissional. 4. Avaliação periódica de indicadores de mortalidade e sobrevida, com ajustes nas estratégias de saúde. Considerando os níveis de prevenção em saúde (primária, secundária, terciária e quaternária), assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação das medidas descritas:

- A (1) Prevenção secundária; (2) Prevenção terciária; (3) Prevenção primária; (4) Prevenção quaternária.
- B (1) Prevenção primária; (2) Prevenção secundária; (3) Prevenção terciária; (4) Prevenção quaternária.
- C (1) Prevenção terciária; (2) Prevenção primária; (3) Prevenção secundária; (4) Prevenção quaternária.
- D (1) Prevenção quaternária; (2) Prevenção primária; (3) Prevenção secundária; (4) Prevenção terciária.

4000271597

Questão 158

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Prevenção Secundária

Em virtude do Outubro Rosa é comum as equipes de saúde da família realizarem ações denominadas de "Dia D", com o objetivo de realizar o rastreio nas mulheres residentes na área de abrangência, por meio da realização dos exames das mamas e o citopatológico. Considerando os níveis de prevenção à saúde, o exame citopatológico se enquadra no:

- A Nível de prevenção primária;
- B Nível de prevenção secundária;
- C Nível de prevenção terciária;
- D Nível de prevenção quaternária.

4000241823

Questão 159

2026 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Determinação Social da Saúde Determinantes Sociais da Saúde DSS

Durante atendimento em uma USF, um homem de 48 anos, trabalhador da construção civil, procura a equipe com queixa de dor lombar crônica. Ele relata morar em área periférica sem saneamento adequado, ter baixa escolaridade e dificuldade de acesso regular a serviços de saúde. Além disso, refere insegurança alimentar em sua família. Considerando os determinantes sociais da saúde (DSS) e sua influência no processo saúde-

doença e a situação ilustrada, assinale a alternativa correta.

- A** De acordo com o modelo explicativo dos DSS proposto por Dahlgren e Whitehead, os fatores que explicam a condição do paciente como tipo de trabalho, moradia e insegurança alimentar se inserem nos condicionantes estilo de vida dos indivíduos e redes sociais e comunitárias
- B** Segundo Solar e Irwin, as políticas macroeconômicas, como as relacionadas a habitação e qualidade do ambiente de trabalho, por se distanciar do indivíduo não seriam consideradas nos fatores relacionados aos DSS
- C** O problema de saúde do paciente pode ser resolvido com prescrição medicamentosa e afastamento temporário do trabalho, sem necessidade de considerar fatores sociais. O quadro de insegurança alimentar relatado exerce pouca influência sobre seu estado de saúde
- D** As condições de moradia, trabalho e disponibilidade de alimentos se inserem dentro dos determinantes intermediários da saúde, conforme o modelo explicativo proposto por Solar e Irwin, adotado pela Organização Mundial da Saúde em 2010.

4000271603

Questão 160

2024 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT
Incidência Prevalência Diferenças entre Incidência e Prevalência

Incidência e prevalência são termos usados para descrever a frequência de uma doença ou condição em uma população. Considerando os conceitos e características destas medidas, é correto afirmar que:

- A** a prevalência é medida através do levantamento de uma população definida constituída de pessoas com ou sem a condição de interesse. é a medida utilizada no estabelecimento entre causa e efeito em estudos longitudinais.
- B** a incidência reflete os novos casos da doença que ocorrem em uma população inicialmente livre da doença. assim, a incidência reflete a taxa de surgimento de novos casos com o passar do tempo em uma população definida.
- C** o aumento da duração da doença, a sua cura ou a ocorrência do óbito não interferem na determinação da prevalência de uma doença, pois uma vez que o indivíduo é identificado como caso, ele permanecerá sendo contabilizado como caso da doença.
- D** os estudos de incidência são utilizados para estimar a ocorrência de doenças crônicas. já os estudos de prevalência são recomendados para estimar a ocorrência de doenças de manifestação aguda na população

4000214080

Questão 161

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Incidência

De acordo com o coordenador de Atenção às Condições de Saúde do Estado, Vinícius de Oliveira, os casos de câncer de mama diminuíram de 368, de janeiro a junho de 2024, para 245, no mesmo período deste ano

em Mato Grosso. Já o de câncer do colo do útero reduziram de 328, nos primeiros seis meses de 2024, para 203, de janeiro a junho de 2025. (Fonte: [https:// www.secom.mt.gov.br/w/ses-promoveconscientiza%C3%A7%C3%A3o-sobre-a-sa%C3%BAde-da-mulher-no-outubro-rosa](https://www.secom.mt.gov.br/w/ses-promoveconscientiza%C3%A7%C3%A3o-sobre-a-sa%C3%BAde-da-mulher-no-outubro-rosa) Acessado em 12/11/2025). Considerando que a população feminina era de 1,843 milhão de mulheres residentes em MT segundo os da PNAD Contínua (2024), assinale a alternativa correta em relação as taxas de incidência de casos de câncer de mama e de colo de útero em MT para o ano de 2024.

- ☐ A A taxa de incidência de câncer de colo de útero foi de 11,01% em mulheres de MT, em 2024.
- ☐ B A taxa de incidência de câncer de mama foi de 19,97/100 mil mulheres em MT, no ano de 2024.
- ☐ C A taxa de incidência de colo de útero foi de 11,01/100 mil mulheres em MT, no ano de 2024.
- ☐ D A taxa de incidência de câncer de mama foi de 13,29% em mulheres de MT, no ano de 2024.

4000271611

Questão 162

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Mortalidade Geral Mortalidade Específica Mortalidade Proporcional

De acordo com as informações disponíveis no DATASUS, em Mato Grosso no ano de 2022 foram registradas 12.039 internações por neoplasias, sendo 4767 homens e 7272 mulheres. Destas internações 818 evoluíram para o óbito por neoplasias, sendo 414 no sexo masculino e 404 no sexo feminino. Em relação a mortalidade geral ocorreram 21.731 óbitos em MT no ano 2022 (13.368 homens e 8.356 mulheres). Com base nestes dados e nos conceitos de indicadores de saúde, assinale a alternativa correta:

- ☐ A O coeficiente de mortalidade por neoplasias no sexo masculino foi de 8,68/100 internações.
- ☐ B O Coeficiente de mortalidade por neoplasias no sexo feminino foi de 3,35/100 internações.
- ☐ C O Coeficiente de mortalidade geral por neoplasias no sexo masculino foi de 8,68/1000 óbitos.
- ☐ D O coeficiente de mortalidade geral no estado de Mato Grosso foi de 180,5/1000 óbitos.

4000241821

Questão 163

2025 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT
Situação Epidemiológica do Brasil Teorias de Transição Epidemiológica Transição Epidemiológica no Brasil

O sistema de saúde brasileiro tem lidado com problemas de saúde causados por agentes etiológicos emergentes e reemergentes. A partir dos conceitos relacionados com as doenças emergentes e reemergentes, assinale a alternativa correta:

- A** Considera-se como a reemergência de uma doença a reintrodução de doenças já eliminadas, ou com baixa incidência ou ainda aquelas endêmicas que passam a alcançar novas populações, ou seja, doenças antigas em novos lugares. Entre os fatores contribuintes para a sua ocorrência estão migrações, fluxo internacional de pessoas, baixa cobertura vacinal, urbanização sem planejamento e mudanças climáticas.
- B** As arboviroses tem causado epidemias no Brasil nas últimas décadas e são consideradas importantes doenças emergentes e reemergentes. A Zika é a arbovirose mais recente no país, porém, não é considerada ainda uma doença emergente, visto que para ser classificada desta maneira é necessário ter elevada incidência de casos e de letalidade, o que não tem ocorrido devido a diminuição dos casos de Zika no Brasil.
- C** A Malária e a Febre amarela têm apresentado aumento no número de casos ocorridos no Brasil nas últimas décadas. Ambas possuem potencial epidêmico, com destaque para a febre amarela devido a sua alta letalidade. Apesar disso, não são consideradas doenças reemergentes uma vez que a ocorrência de casos destas está limitada a região da amazônica.
- D** A COVID-19 foi considerada uma doença emergente por ter ocasionado a pandemia de maior impacto dos últimos 100 anos. A COVID-19 deixou de ser considerada uma doença emergente, uma vez que a sua transmissão é viral e não por vetores como nas demais doenças que são consideradas emergentes como a dengue, malária e febre amarela e pela redução da incidência e mortalidade da doença.

4000241826

Questão 164

2024 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Investigação de Surtos

A investigação epidemiológica de campo de casos, surtos, epidemias ou outras formas de emergência em saúde é uma atividade obrigatória de todo sistema de vigilância em saúde. Em relação ao processo de investigação epidemiológica, assinale a alternativa correta.

- A** A execução primária é atribuição privativa do governo federal. A execução da investigação epidemiológica deve ocorrer de forma integrada e simultânea as demais ações relacionadas a vigilância em saúde, promoção e assistência para a prevenção e controle de doenças (transmissíveis ou não) ou agravos (inusitados ou não).
- B** A gravidade do evento representa um fator que determina a urgência no curso da investigação epidemiológica e na implementação de medidas de controle. Em situações em que a fonte e o modo de transmissão já são evidentes, as ações de controle devem ser instituídas durante ou até mesmo antes da realização da investigação.
- C** A investigação epidemiológica deve ser realizada in loco, nos serviços de saúde e restritamente com dados primários (coleta direta nos pacientes ou serviços de saúde), para garantir a obtenção de maneira completa e correta das informações necessárias referentes ao contexto de ocorrência do surto ou epidemia.
- D** As investigações epidemiológicas de campo iniciam-se, com a hipótese de investigação já definida. Assim, o uso de estudos descritivos para a formulação de hipóteses que, posteriormente, deverão ser testadas por meio de estudos analíticos como, por exemplo, estudos de caso-controle não se faz necessário.

4000214078

Questão 165

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Vigilância em Saúde Vigilância Ambiental

A Vigilância em Saúde (VS) fundamenta-se na busca por respostas mais efetivas para as demandas e para os problemas de saúde. Em relação a VS, é correto afirmar que:

- A** a vigilância sanitária é um dos núcleos de atuação da VS. Os métodos de intervenção da vigilância sanitária se restringem a ações orientativas, dirigidas ao fortalecimento da sociedade e da cidadania, com o propósito da promoção da saúde e da prevenção de danos ou agravos.
- B** o envio mensal de informações epidemiológicas referentes às doenças/agravos na área de atuação da unidade básica de saúde, para posterior análise e proposições de possíveis intervenções não está entre as atribuições a serem realizadas pelo médico, nas ações de vigilância em saúde.
- C** a vigilância ambiental em saúde foi incorporada recentemente no âmbito das políticas públicas de saúde. no contexto da saúde da família, o processo de territorialização auxilia na identificação dos riscos ambientais a que a comunidade está exposta e a formulação de estratégias intersetoriais necessárias ao seu enfrentamento.
- D** o acompanhamento do perfil epidemiológico da população é essencial para que seja reconhecidas as intervenções a serem realizadas. por conta da transição epidemiológica vivenciada pelo país, as doenças infecto parasitárias deixaram de ser alvo do monitoramento da vigilância epidemiológica.

4000214082

Questão 166

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

A Portaria GM/MS nº 5.201, de 15 de agosto de 2024 incluiu na lista de doenças e agravos em saúde de notificação compulsória o câncer relacionado ao trabalho. Considerando as características das doenças e agravos que integram a lista de notificação compulsória no país e o processo de notificação, é correto afirmar que:

- A As doenças que integram a lista de notificação compulsória possuem como característica a alta transmissibilidade e elevada letalidade. Por necessitar de um diagnóstico confirmado, a notificação da doença a Vigilância Epidemiológica fica sob responsabilidade do médico.
- B O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) disponibiliza para os profissionais de saúde a fichas de notificação compulsória. É de responsabilidade dos profissionais que integram os serviços de saúde pública, independente do nível de atenção o preenchimento destas fichas após a confirmação do diagnóstico.
- C As doenças e agravos que constam na lista de notificação são consideradas como potenciais problemas de saúde pública. Por conta do risco associado a estas doenças, qualquer profissional de saúde pode fazer a notificação a partir da suspeita do caso, sendo a notificação realizada como caso suspeito.
- D Após a confirmação da doença e de sua notificação, o médico deverá realizar o encaminhamento do paciente diagnosticado para os serviços de saúde de média ou alta complexidade para o acompanhamento e tratamento pela equipe de saúde especializada em doenças de notificação compulsória.

4000241827

Questão 167

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Declaração de óbito DO Atestado de óbito

Homem, 52 anos, sofreu queda da própria altura dentro do banheiro de sua residência. Foi recolhido pelo serviço de resgate e encaminhado ao hospital, onde fez cirurgia em virtude de traumatismo cranioencefálico. Evoluiu na UTI após dois dias com parada total e irreversível da atividade do tronco e hemisférios cerebrais. Paciente portava um testamento vital relatando ser doador de órgãos. Qual a conduta que o médico plantonista deve fazer:

- A solicitar autorização da família para realização de necropsia e doação de órgãos.
- B emitir a declaração de óbito e encaminhar o corpo para doação dos órgãos.
- C realizar a doação após autorização da família e encaminhar o corpo para IML.
- D respeitar a vontade do paciente pelo testamento vital e, após encaminhar ao SVO

4000214059

Questão 168

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Estratégia de observação longitudinal x transversal

Foi realizado um estudo de base populacional com mulheres de 20 a 69 anos residentes na área urbana de um município do Rio Grande do Sul, com o objetivo de investigar a prevalência de não realização de Exame Clínico das Mamas (ECM) e os fatores associados. Foram consideradas como variáveis independentes as características demográficas e socioeconômicas e como desfecho o ECM não realizado nos últimos 12 meses. As participantes responderam a um questionário padronizado aplicado individualmente, por entrevistadores treinados. Foram calculadas a prevalência do desfecho, suas razões de prevalência e os respectivos intervalos de confiança. Em relação a metodologia empregada em sua realização, o estudo em questão pode ser classificado como:

- A caso-controle, uma vez que realiza a investigação de fatores associados ao câncer de mama, que é uma patologia de grande prevalência, sendo a metodologia recomendada para este tipo de investigação.
- B transversal, pois a investigação entre a causa e o desfecho foi realizada simultaneamente, e pelo uso das medidas de prevalência no estabelecimento da associação entre as variáveis.
- C ecológico, já que se trata de um estudo de base populacional, realizado na área urbana de um município brasileiro. além deste tipo de estudo ser usado para o estabelecimento de hipóteses, como foi o objetivo do estudo realizado.
- D coorte, já que o estudo foi realizado com as informações atuais do momento da entrevista, não sendo consideradas informações pregressas, e pelo estabelecimento das medidas de associação entre as variáveis independentes e o desfecho.

4000214084

Questão 169

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Estudos Seccionais Transversais

Estudo epidemiológico observacional realizado com docentes de uma instituição privada da região oeste do estado da Bahia com o objetivo de determinar a prevalência de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Foi aplicado um questionário para obtenção de dados sociodemográficos, informações sobre os hábitos de vida, condições de saúde, bem como a hereditariedade de doenças cardiovasculares. Além disso, nesta mesma entrevista realizou-se a avaliação de parâmetros antropométricos, níveis pressóricos e coleta de amostra biológica para determinação de parâmetros laboratoriais. Por fim aplicou-se um instrumento para avaliação dos níveis de estresse. Considerando o delineamento empregado na realização dos estudos epidemiológicos, o estudo mencionado pode ser classificado como:

- A Estudo de Coorte
- B Estudo de casos e controles
- C Estudo Transversal
- D Estudo Ecológico

4000271610

Questão 170

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Nos estudos epidemiológicos que buscam estabelecer a relação entre a causa e o efeito, a tabela 2x2 é uma importante ferramenta para a apresentação dos resultados. A interpretação das informações ali apresentadas é fundamental para a compreensão dos achados do estudo realizado. Observe os dados apresentados na Tabela 2: Tabela 2. Investigação sobre a associação entre consumo de tabaco na gestação e baixo peso do recém-nascido. A partir dos dados apresentados na tabela e da compreensão da tabela 2x2, assinale a alternativa correta:

Tabela 2. Investigação sobre a associação entre consumo de tabaco na gestação e baixo peso do recém-nascido.

	Com baixo peso	Sem baixo peso	Total
Tabagismo presente	100	30	130
Tabagismo ausente	400	470	870
Total	500	500	1000

- A Os indivíduos que não sofreram a exposição e nem apresentaram a ocorrência do efeito foram 870.
- B A ocorrência da relação entre a causa e o efeito foi observada em 100 indivíduos.
- C A exposição ao fator de risco contribuinte para a ocorrência do efeito foi observada em 500 indivíduos.
- D A ocorrência do efeito investigado a partir da exposição foi observado em 130 indivíduos.

4000241817

Questão 171

2025 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMTT

Estudos de CasoControle Odds Ratio ou Razão de Chances

Em estudos epidemiológicos que adotam a metodologia de Casos e controles, qual das seguintes medidas de associação deve ser utilizada para verificar a associação entre a causa e o efeito?

- A Razão de prevalência
- B Razão de taxas
- C Risco relativo
- D Razão de chances (odds ratio)

4000241819

Questão 172

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMTT Acesso Direto (R1) Privado

Filtro especial identificando o tipo de estudo epidemiológico pela descrição da metodologia Estudos de Coorte

Estudo realizado com o objetivo de identificar os fatores associados a interrupção precoce do aleitamento materno em dois municípios do Recôncavo da Bahia. A amostra foi constituída por 531 crianças nascidas entre março de 2005 a outubro de 2006 nas maternidades públicas, acompanhadas a partir do nascimento por um período de dois anos. Foram levantadas informações sobre aleitamento materno, variáveis independentes (sociodemográficas, biológicas e antropométricas da mãe e da criança etc.) e o desfecho

(tempo decorrido do nascimento até a finalização da duração do aleitamento materno). A associação entre as variáveis de exposição e a duração do aleitamento materno foi avaliada por meio da regressão semiparamétrica de Cox e interpretada pela razão de risco (hazard ratio - HR), com intervalo de 95% de confiança (IC95%). Em relação a metodologia empregada em sua realização, o estudo em questão pode ser classificado como:

- A Coorte, uma vez que a direção temporal observada é a longitudinal prospectiva, além do estabelecimento da causalidade partir dos indivíduos onde o efeito ainda não havia sido manifestado em relação ao desfecho.
- B Casos e controles prospectivo, uma vez que o seguimento ocorreu por dois anos e avalia dois momentos no tempo, o nascimento (que seria a exposição) e o tempo do aleitamento materno (desfecho).
- C Transversal, uma vez que o levantamento entre as causas (variáveis independentes) e o efeito (duração do aleitamento materno) estão sendo investigadas simultaneamente durante os anos de seguimento.
- D Ecológico, por se tratar de investigação de moradores de municípios e a investigação comparar os resultados obtidos conforme as características dos municípios de residência.

4000241828

Questão 173

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Risco Absoluto Risco Relativo RR Razão de Riscos Risco Atribuível

As medidas de efeito, também chamadas de medidas de associação, expressam a relação entre a exposição e o desfecho, sendo empregadas em diversas pesquisas na área da saúde. Sobre estas medidas, assinale a alternativa correta.

- A O risco absoluto é a probabilidade de um evento ocorrer em uma população sob estudo. É a medida mais simples para médicos e pacientes compreenderem como os fatores de risco podem afetar suas vidas.
- B O risco atribuível procura responder à pergunta "qual a incidência da doença atribuível a exposição?", ou seja, para a sua definição é realizada a soma da incidência da doença entre as pessoas expostas e não-expostas.
- C O Risco relativo responde a "quantas vezes mais provável é as pessoas expostas se tornarem doentes, em relação as não expostas?". É a medida mais empregada em estudos que buscam investigar a eficácia de novos tratamentos médicos.
- D O uso das medidas de efeito nas investigações em saúde sofre influência da pergunta que está sendo feita. Estudos que desejam apontar a força de uma relação causal deverão empregar a medida do risco atribuível.

4000214079

Questão 174

2026 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)

Um estudo de coorte acompanhou 1.000 idosos durante a temporada de influenza. Entre os vacinados, a incidência da doença foi de 5%, enquanto entre os não vacinados foi de 20%. O cálculo do risco relativo (RR) mostrou que os vacinados tiveram $RR = 0,25$ em relação aos não vacinados. Com base nesse resultado, assinale a alternativa que melhor interpreta o valor do RR obtido:

- A Os idosos vacinados tiveram quatro vezes mais risco de desenvolver influenza em comparação aos não vacinados.
- B A vacinação reduziu em 75% o risco de influenza nos idosos, em relação aos não vacinados avaliados.
- C O risco de influenza foi igual entre vacinados e não vacinados, indicando que a vacina não teve efeito.
- D A vacinação reduziu apenas 25% do risco de influenza, mostrando baixa efetividade da intervenção.

4000271598

Questão 175

2024 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)

Odds Ratio ou Razão de Chances

Estudo observacional do tipo caso-controle, com 63 gestantes com idades entre 25 a 43 anos, com o objetivo de conhecer os fatores de risco relacionados a ocorrência do câncer de mama gestacional (CMG) encontrou os resultados apresentados na tabela abaixo. Tabela 3. Associação entre a idade materna na primeira gravidez e a ocorrência de câncer de mama na gestante (análise pareada). A partir dos resultados apresentados na tabela e da interpretação da medida de efeito (Odds Ratio ajustado), é correto afirmar que:

Tabela 3. Associação entre a idade materna na primeira gravidez e a ocorrência de câncer de mama na gestante (análise pareada).

Característica da gestante ^a	OR bruto	IC 95%	p-valor	OR ajustado	IC 95%	p-valor
Idade da 1ª gravidez	1,12	1,01 - 1,24	0,04	1,27	1,05 - 1,54	0,02
História familiar	0,83	0,15 - 4,52	0,82	3,29	0,32 - 33,60	0,32
Menarca precoce	1,35	0,38 - 5,26	0,61	4,17	0,02 - 2,36	0,22
Paridade alta	1,04	0,29 - 3,64	0,96	2,25	0,26 - 19,09	0,45
Escolaridade baixa	5,06	1,34 - 19,03	0,02	8,49	1,55 - 46,51	0,02

- A a maior idade materna na primeira gestação foi considerada um fator de risco, já que a chance do desenvolvimento do CMG aumenta 27% para cada ano a mais da idade da primeira gravidez.
- B a baixa escolaridade materna não foi identificada como fator de risco para a ocorrência do CMG. Valores de OR ajustados superiores a 5,0 indicam que a variável/condição confere proteção ao participante da pesquisa.
- C a menarca precoce foi também identificada como um fator de risco para a ocorrência CMG. Já que esta variável contribuiu para aumentar a chance em 417%. Ou seja, quanto mais precoce a menarca, maior a chance de ocorrer CMG.
- D o histórico familiar autou no grupo avaliado como fator de proteção, uma vez que apresentou um OR de 0,83. Então, quando a gestante não possui antecedentes familiares de câncer de mama, menor será a chance da mulher desenvolver CMG.

4000214072

Questão 176

2026 Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Odds Ratio ou Razão de Chances

valor p e intervalo de confiança

Estudo avaliou os fatores de risco relacionados à hipertensão arterial em moradores residentes em comunidades quilombolas e encontrou-se os seguintes resultados: Em relação aos resultados apresentados na tabela e aos conceitos relativos aos testes estatísticos, assinale a alternativa correta:

Tabela. Dados sobre o uso de álcool e tabaco.						
Variável	Caso	Controle	Geral	x ²	p-valor	OR (IC)
	N (%)	N (%)	N (%)			
Uso de álcool						
Não bebe ou parou	15 (30,0)	17 (34,0)	32 (64,0)	0,34	0,556	1,41 (0,44 - 4,52)
Bebe	10 (20,0)	8 (16,0)	18 (36,0)			
Frequência do uso de álcool						
Não bebe/parou	15 (30,0)	17 (34,0)	32 (64,0)	0,52	0,769	-
Socialmente	4 (8,0)	4 (8,0)	8 (16,0)			
Frequentemente	6 (12,0)	4 (8,0)	10 (20,0)			
Uso de tabaco						
Não fuma ou parou	19 (38,0)	22 (44,0)	41 (82,0)	1,22	0,269	2,31 (0,50 - 10,54)
Fumante	6 (12,0)	3 (6,0)	9 (18,0)			
Frequência do uso de tabaco						
Não fuma/parou	19 (38,0)	22 (44,0)	41 (82,0)	0,02	0,364	-
Mais de 20/dia	4 (8,0)	1 (2,0)	5 (10,0)			
Menos de 20/dia	2 (4,0)	2 (4,0)	4 (8,0)			

- A Os dados indicam que o indivíduo fumante possui 2 vezes mais chance de desenvolver hipertensão arterial quando comparado ao não fumante ou parou, como confirmado pelos valores de OR p-valor obtidos nos testes estatísticos
- B Ao comparar-se o uso de álcool entre quem bebe/parou e não bebe, os resultados sugerem que a chance de desenvolver hipertensão arterial foi de 1,41 vezes maior entre os que bebem. Porém, esta associação não foi confirmada por conta do p-valor obtido (não significativo).
- C A frequência do consumo de tabaco foi superior entre os componentes do grupo de casos, o que elevou o risco de ocorrência de hipertensão arterial, como confirmado pelo valor do χ^2 do p-valor obtido para a categoria desta variável.
- D A frequência do consumo de álcool foi menor entre os participantes do grupo controle, o que atuou como fator de proteção, reduzindo a chance de ocorrência de hipertensão arterial nestes, sendo este resultado evidenciado pelos valores obtidos pelo OR e χ^2

Questão 177

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Sensibilidade Especificidade Valor Preditivo Positivo

O desempenho de um teste diagnóstico depende da ausência de viés e da precisão deste. Estudo realizado com crianças avaliou a validade da versão brasileira do Ages e Stages Questionnaires. A partir das medidas empregadas na avaliação dos testes de diagnósticos e das informações contidas na tabela abaixo, assinale a alternativa correta. Tabela 5. Resultados da sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo do Denver II. em relação ao ASQ-3BR.

Tabela 5. Resultados da sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo do Denver II em relação ao ASQ-3BR.

Faixas Etárias (meses)	Sensibilidade	Especificidade	VPP	VPN
1-6	73%	62%	55%	59%
7-12	88%	76%	78%	75%
13-18	82%	66%	70%	62%
19-24	99%	87%	81%	77%
25-36	83%	58%	72%	58%
37-48	99%	92%	89%	78%
49-60	86%	66%	74%	63%
Total (0-60)	89%	78%	79%	78%

Legenda: ASQ-3BR: Ages & Stages Questionnaires - 3ª Edição versão brasileira; VPP: Valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo.

- A Os valores referentes a especificidade variaram conforme a idade da criança. A avaliação da especificidade do instrumento tem o intuito de indicar a positividade do teste na ausência da doença.
- B A sensibilidade do teste alcançou maiores valores para as idades de 19 a 24 meses e 34 a 78 meses. Isso indica que a negatividade do teste na presença da doença foi maior neste grupo de crianças.
- C O valor preditivo negativo foi menor na faixa etária de 1 a 6 meses, com 59% das crianças avaliadas. Isso sugere que a probabilidade de o paciente não ter a doença, caso o teste resulte negativo foi observada em 41% das crianças avaliadas.
- D A faixa etária de 37 a 48 meses foi a que apresentou o melhor resultado para os testes avaliados. O valor preditivo positivo indicou que 89% das crianças desta faixa etária têm a probabilidade de ter a doença dado que o teste resulte positivo.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000214070

Questão 178

2025 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Probabilidade préteste e valor preditivo positivo Probabilidade préteste e valor preditivo negativo Valor Preditivo Positivo

Ao realizar a anamnese no paciente é importante que o médico utilize perguntas que realmente permitirão o levantamento de informações que contribuirão para o diagnóstico. Com base nisso, foi realizado um estudo com motoristas de ônibus para avaliar a sensibilidade, especificidade e o valor preditivo negativo e positivo para a pergunta "Você tem pressão alta/hipertensão? A partir das medidas empregadas na avaliação dos testes de diagnósticos e das informações contidas na Tabela 3, assinale a alternativa correta:

Tabela 3			
Sensibilidade, especificidade, acurácia, VPP e VPN em relação ao nível de escolaridade			
Variáveis	Grau de escolaridade		
	Até 5ª série (%)	De 6ª a 8ª série (%)	2º grau ou mais (%)
Sensibilidade	48,3	40	10
Especificidade	98,1	100	100
Acurácia	87,2	85,8	89,3
VPP	87,9	100	100
VPN	87,1	84,3	89,2

VPP= Valor preditivo positivo; VPN= Valor preditivo negativo

- A** Neste estudo foi possível observar que a VPP apontou que os entrevistados hipertensos responderam à questão positivamente, sendo o diagnóstico de hipertensão confirmado por meio do exame físico.
- B** A sensibilidade foi influenciada pelo grau de escolaridade, visto que foi crescente conforme o aumento da escolaridade, pois apenas 10% dos entrevistados não demonstraram sensibilidade ao responder à pergunta.
- C** O VPN apontou que a prevalência de hipertensão foi menor nos indivíduos com menor grau de escolaridade, o que contradiz a literatura científica, pois a hipertensão tem maior prevalência neste público.
- D** A acurácia no estudo realizado foi superior a 80%, o que caracteriza que esta pergunta deverá ser usada como o padrão ouro para o diagnóstico de hipertensão arterial.

4000241816

Questão 179

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMTT Acesso Direto (R1) Privado

Código de Ética Médica CEM Documentos médicos Disposições gerais do Código de Ética Médica

A ética profissional pode ser traduzida como o conjunto de normas morais pelas quais a pessoa deve orientar seu comportamento na profissão que exerce. Na área da saúde, a ética é usada na pesquisa clínica e nas relações com as pessoas. Em relação à ética na Atenção Primária à Saúde (APS), assinale a alternativa correta.

- A** Em relação ao prontuário médico, seja ele físico ou eletrônico, é dever do médico zelar para que as informações obtidas nas consultas sejam registradas adequadamente. As informações nele contidas estão sob sigilo e somente podem ser liberadas mediante a autorização da instituição que os detém.
- B** A inserção comunitária da APS auxilia na manutenção da privacidade dos atendimentos domiciliares. A definição dos limites do envolvimento do agente comunitário de saúde são estabelecidos com maior facilidade, uma vez que este conhece a dinâmica familiar do usuário, por ser um vizinho deste.
- C** Os aspectos éticos na APS diferem daqueles relacionados ao ambiente hospitalar ou de serviços altamente especializados. A proximidade dos profissionais com os usuários, promovida pelo cuidado contínuo, do cuidado da família a visita ao domicílio pode contribuir para a banalização dos aspectos éticos.
- D** Os problemas éticos que ocorrem na APS podem ser agrupados em categorias, como os problemas éticos na relação dos profissionais com as pessoas e com a família na APS. Problemas relacionadas à organização e ao sistema de saúde não se configurariam como questões éticas.

4000214075

Questão 180

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Ensino e pesquisa médica

O médico que atua em uma unidade de saúde da família está realizando uma pesquisa para a sua pós-graduação, com o objetivo de identificar os comportamentos de risco ou proteção na prática sexual de indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 15 e 60 anos. A coleta das informações relacionadas a pesquisa é realizada durante a consulta de rotina dos pacientes que se enquadram no público-alvo. Em relação a ética médica nas atividades relativas à pesquisa, assinale a alternativa correta.

- A** Em caso de participantes menor de idade, o médico poderá coletar as informações após a assinatura do termo de assentimento livre e esclarecido pelo adolescente, sendo dispensada a assinatura do termo de consentimento do seu representante legal.
- B** Ao realizar a pesquisa o médico deverá obrigatoriamente informar e esclarecer o paciente, independentemente de sua idade, sobre a natureza da investigação, coletar a assinatura do termo de consentimento e/ou assentimento, sem preterir o objetivo da consulta pela qual o usuário buscou o atendimento.
- C** Enquanto pesquisador, é permitido ao médico manter dependência profissional e científica em relação aos financiadores da pesquisa médica, desde que esta ocorra visando a satisfação e o interesse da investigação de situações relacionadas aos problemas de saúde pública.
- D** Ao publicar os resultados da pesquisa, o médico deverá zelar pela veracidade, clareza e imparcialidade das informações. Caso a pesquisa tenha sido realizada sem financiamento público ou privado, a necessidade da declaração de não conflito de interesses não precisará estar incluída na publicação do artigo.

4000214076

Questão 181

2025 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)

As alterações do sistema cardiocirculatório na gravidez se iniciam no 1º trimestre, atingem o ápice entre o 2º e o 3º trimestres e se mantêm até o período periparto. A sobrecarga hemodinâmica imposta por estas modificações, pode provocar descompensação clínica nas gestantes portadoras de doenças cardíacas. Neste cenário, quais alterações observadas nas primeiras 24h de puerpério contribuem para o agravamento das condições maternas?

- A Aumento do débito cardíaco e do volume plasmático.
- B Redução da frequência cardíaca e da resistência vascular.
- C Redução do débito cardíaco e aumento da resistência vascular.
- D Aumento da frequência cardíaca e redução do volume plasmático.

4000241792

Questão 182

2026

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Uso de medicações

Um grupo de pesquisa desenvolveu uma nova droga para controle do diabetes melito. Os resultados quanto à eficácia e segurança foram promissores e após uma série de estudos em animais, o medicamento não evidenciou risco para o feto, todavia ainda não existem estudos controlados em mulheres grávidas. Diante destas informações, em qual categoria do FDA (Food and Drug Administration) este medicamento será classificado quanto ao seu uso durante a gestação?

- A Categoria A - o medicamento deve ser prescrito.
- B Categoria B - o medicamento pode ser prescrito.
- C Categoria D - uso não recomendado durante a gestação.
- D Categoria C - uso justificado se o benefício para a mãe superar o risco para o feto.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271622](#)

Questão 183

2026

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Residência (Acesso Direto)

Imunização na gestação

A imunização é considerada um dos meios mais eficazes de combate às doenças infecciosas. Em relação à imunização do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é correto afirmar:

- A** A vacina deve ser aplicada em todas as gestantes independente da idade gestacional e o nirsevimabe, nos pacientes considerados de risco, independente da vacinação materna.
- B** Os recém-nascidos filhos de mães vacinadas até 14 dias antes do parto deverão receber o nirsevimabe ao nascer, durante a sazonalidade do VSR, daquela região.
- C** Os recém-nascidos filhos de mães vacinadas com menos de 14 dias antes do parto deverão receber o nirsevimabe ao nascer, independente da sazonalidade do VSR, daquela região.
- D** Os recém-nascidos filhos de mães vacinadas com mais de 14 dias do parto, deverão receber o nirsevimabe, durante a sazonalidade do VSR, daquela região.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271567](#)

Questão 184

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Rotação interna

G3 PN2 A0, IG 39s 6d é internada em franco trabalho de parto. Na admissão PA 120/85 mmHg, FC 92 bpm, altura uterina 37 cm, DU: 4/50"/10", BCF 148 bpm, colo dilatado 7 cm, centralizado, esvaecido 50%, bolsa rota, apresentação cefálica fletida, no plano 0 De Lee, em variedade OET. Neste parto, qual a evolução prevista para a rotação interna da cabeça?

- A** 45° em sentido horário.
- B** 180° em sentido horário.
- C** 90° em sentido anti-horário.
- D** 135° em sentido anti-horário

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214040](#)

Questão 185

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Métodos de indução do parto

G3 PN2 A0, 26 anos, sem comorbidades, comparece ao pronto atendimento com IG de 41 semanas, para indução do parto, conforme orientada pelo médico do pré-natal. Ela nega sangramentos ou perda de líquido, relata contrações irregulares e boa movimentação fetal. A cardiotocografia é tranquilizadora e o índice de Bishop é igual a 8 (colo amolecido, esvaecido 60% e dilatado 3 cm; apresentação fetal em plano -1 De Lee). Qual a estratégia mais adequada para indução do parto nestas condições clínicas?

- A** Sonda de Foley
- B** Ocitocina endovenosa
- C** Misoprostol via vaginal
- D** Methergim intramuscular

4000271627

Questão 186

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Tipos de fórceps Funções do fórcepe Aplicação do fórcepe

G4 PN3 A0, 41 anos, foi internada em franco trabalho de parto, com bolsa rota e 6 cm de dilatação. Há 1 hora observa-se parada de progressão no final do segundo estágio do parto. A paciente não recebeu analgesia, alega estafa e não consegue executar a prensa abdominal. O feto está em apresentação cefálica fletida, em variedade de posição occiptosacra, no plano +3 de De Lee. Não se observam sinais de desproporção cefalopélvica, mas as contrações são pouco eficientes. O obstetra consulta a paciente e seu acompanhante obtendo autorização para realização de episiotomia e aplicação de fórceps. Como será realizada a extração fetal nesta situação?

- A Tração da apresentação durante as contrações utilizando fórceps de Simpson.
- B Rotação da apresentação durante as contrações utilizando fórceps de Kielland.
- C Tração da apresentação no intervalo entre as contrações utilizando fórceps de Kielland.
- D Rotação da apresentação no intervalo entre as contrações utilizando fórceps de Simpson.

4000214037

Questão 187

2025 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)

Classificação Etiologia Diagnóstico de HPP

Mulher de 18 anos, primípara, sem comorbidades, é levada ao hospital na ambulância do SAMU. Ela chega à maternidade inconsciente, com pulso fino e Intensa palidez, PA 75/43 mmHg De acordo com o relato dos familiares, a paciente teve um parto por via vaginal, em ambiente domiciliar, sem assistência médica ou de enfermagem. O recém-nascido apresentou choro forte ao nascer, mas o serviço de ambulância foi acionado ao perceberem a ocorrência de sangramento intenso logo em seguida. Qual a causa mais provável para o quadro clínico descrito?

- A Eclâmpsia seguida de descolamento prematuro de placenta.
- B Hemorragia pós-parto grave por lesão de trajeto.
- C Sangramento por rotura uterina intraparto.
- D Choque hipovolêmico por coagulopatia.

4000241797

Questão 188

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Complicações

Gestante de 37 semanas, dá entrada no setor de emergência em ambulância do SAMU, após ter sido espancada pelo marido. Na admissão apresenta sinais de choque hipovolêmico, útero hipertônico e BCF 106 bpm. A paciente é encaminhada para parto cesariano imediatamente, sendo detectado volumoso coágulo retroplacentário. No pós-operatório ela evolui com sinais de coagulação intravascular disseminada, mas com

medidas de suporte intensivo, mãe e filho sobrevivem. No 5º dia após o parto, a equipe percebe outra complicação ao observar agalactia materna. Considerando a principal hipótese diagnóstica, que outras manifestações poderão ser encontradas?

- A Insuficiência adrenal, diabetes mellitus e hipertireoidismo.
- B Amenorreia, insuficiência da suprarrenal e hipotireoidismo.
- C Falência ovariana precoce, diabetes mellitus e hipoparatiroidismo.
- D Sangramento uterino anormal, insuficiência ovariana e Síndrome de Cushing.

4000214039

Questão 189

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMT Acesso Direto (R1) Privado

Fatores de risco

G3 PC2 A0, 28 anos, com idade gestacional de 8 semanas por DUM, queixa-se de dor pélvica em fossa ilíaca direita, de intensidade progressiva há 1 semana. Há 3 dias passou a apresentar sangramento leve. Seus sinais vitais estão normais e o colo está fechado. Resultado de exames: Beta-HCG quantitativo = 4.800 mUI/mL e USG TV = saco gestacional não visualizado no interior da cavidade endometrial. Observa-se em região anexial direita imagem complexa para-ovariana, medindo 2,5 cm em seu maior diâmetro. Qual das seguintes condições é reconhecida como fator de risco para a ocorrência deste quadro clínico?

- A Sedentarismo
- B Diabetes mellitus tipo 1
- C Doença inflamatória pélvica
- D Incompetência istmo cervical

4000271626

Questão 190

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMT Acesso Direto (R1) Privado

Quadro clínico Diagnóstico

Paciente de 22 anos, com atraso menstrual de 6 semanas e sensibilidade mamária, passa por consulta na UBS. Informa que há 4 dias realizou um teste de gravidez por conta própria, apresentando exame de beta-hCG = 4.560 mUI/ml. O médico da UBS pede um USG obstétrico endovaginal, mas durante este exame, realizado 2 dias após a consulta inicial, o ultrassonografista não identifica a presença de saco gestacional intra-uterino. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- A Gestação ectópica.
- B Óbito embrionário.
- C Gravidez incipiente.
- D Gestação anembrionada.

Questão 191

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMTT Acesso Direto (R1) Privado

Seguimento pós molar

G3 PN2 A1, 42 anos, com diagnóstico prévio de gestação molar, foi submetida ao procedimento de aspiração manual intra-utero (AMIU) e está realizando seguimento com dosagens semanais de BHCG há 3 meses. Antes do procedimento a dosagem de BHCG era de 175.000 mUI/mL e o diagnóstico histológico do material foi compatível com mola hidatiforme completa. As três últimas dosagens de BHCG, realizadas com intervalo de uma semana entre si, revelaram valores de 355, 361 e 360 mUI/mL respectivamente. Qual conduta deve ser adotada neste momento?

- ☐ A Diante dos níveis em ascensão entre a 1ª e 3ª dosagem, iniciar quimioterapia para mola invasora.
- ☐ B Repetir a dosagem de BHCG com intervalo de 1 semana para confirmar evolução em platô.
- ☐ C Indicar nova AMIU em função do estabelecimento de platô nas dosagens de BHCG.
- ☐ D Indicar histerectomia total caso a paciente não tenha desejo de nova gestação.

4000214038

Questão 192

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMTT Acesso Direto (R1) Privado

Seguimento pós molar Quadro clínico Dosagem beta hCG

Paciente G2 PN1 A0, IG de 9 semanas por DUM, com queixa de sangramento recorrente, realizou USG TV. O exame revelou cavidade endometrial preenchida por material ecogênico, contendo múltiplas vesículas anecoicas de diferentes tamanhos, sem fluxo do Doppler. O esvaziamento uterino foi realizado com aspiração a vácuo e ela está em acompanhamentos ambulatorial, realizando dosagens semanais de hCG. Depois de 2 semanas com valores em queda, apresentou níveis de hCG estáveis em 3 doses consecutivas (dias 1, 7 e 14 - contados a partir do início do platô). Qual a conduta adequada?

- ☐ A Manter seguimento com dosagem de hCG semanal por até 6 meses, desde que não ocorra elevação superior a 10%.
- ☐ B Repetir hCG em 1 semana (dia 21), se o platô persistir, existe critério para diagnóstico de neoplasia trofoblástica.
- ☐ C Solicitar novo USG TV, se for observado espessamento endometrial, indicar novo esvaziamento com curetagem.
- ☐ D Indicar aplicação de Metrotexate via intramuscular hoje e realizar nova dosagem de hCG depois de três dias.

4000241795

Questão 193

2026 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMTT

Tratamento

Gestante, com 37 semanas e 4 dias, apresenta sangramento vaginal indolor e vermelho vivo, de moderada intensidade, PA 80/50 mmHg, FC 112 bpm, FR 20 irpm. Não há sinais de trabalho de parto. Um exame de ultrassonografia, realizado na 30ª semana de gravidez, mostra placenta inserida sobre o orifício interno do colo uterino. Considerando a idade gestacional, qual a conduta mais adequada?

- A Fazer reserva de sangue e indicar cesariana.
- B Prescrição de tocolíticos e conduta expectante.
- C Induzir o parto com misoprostol para preparo do colo.
- D Hidratar e programar interrupção eletiva após 39 semanas.

4000271623

Questão 194

2026 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Conduta na RPM termo a partir de 37 semanas

Primigesta com IG: 40 semanas e 3 dias, em franco trabalho de parto, apresenta ruptura espontânea das membranas ovulares, sendo observada a saída de líquido amniótico com presença de mecônio 2+/4. O colo está centralizado, apagado 80% e dilatado 7 cm, com apresentação cefálica no plano -1 De Lee. A dinâmica uterina é de 4 contrações de 45 segundos em 10 minutos e o BCF 150 bpm. Considerando as recomendações da Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal (2022), qual a conduta mais adequada nesta situação?

- A Encaminhar para o centro cirúrgico para realização de parto cesariano, indicado por sofrimento fetal agudo.
- B Fazer ausculta fetal intermitente e qualificada, antes durante e após as contrações, para detectar sinais de hipóxia fetal.
- C Manter a parturiente em decúbito lateral esquerdo e ofertar máscara de oxigênio, 2 litros por minuto, para prevenir a hipóxia fetal.
- D Prescrever ocitocina endovenosa para acelerar o parto, 8 gotas/minuto; aumentar o gotejamento progressivamente a cada 30 minutos.

4000271628

Questão 195

2024 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Predição e prevenção

Como estratégia preventiva durante o pré-natal, a OMS recomenda a utilização do ácido acetilsalicílico em baixa dose, com início antes de 16 semanas, em pacientes portadoras de fatores de risco para o desenvolvimento de preeclampsia. Que outra recomendação deve ser adotada neste grupo de pacientes?

- A Suplementação com Cálcio 1,5-2,0 g/d, em áreas de baixa ingestão deste elemento.
- B Repouso no leito em pacientes com Doppler de uterina alterado no 1º trimestre.
- C Restrição de sódio, em portadoras de incisura bilateral das artérias uterinas.
- D Suplementação com Ômega 3, em pacientes com idade > 35 anos.

4000214041

Questão 196

2025 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)
Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade Tratamento farmacológico

Primigesta, 39 anos, IG 27 semanas por USG precoce, teve diagnóstico de pré-eclâmpsia firmado na 24ª semana de gravidez. Na consulta de hoje, relata intensificação do edema, sem outras queixas. Ao exame físico: PA 190 × 130 mmHg, edema 3+/4, AU 26 cm, BCF 142 bpm, tônus uterino normal. O médico indica internação para abordagem da crise hipertensiva. Neste momento, qual das seguintes opções é a melhor estratégia terapêutica?

- A Nifedipina 20 mg VO de 8/8h (dose máxima 60 mg)
- B Metildopa 500 mg VO de 6/6h (dose máxima 2.000 mg)
- C Nifedipina 10 mg VO a cada 20-30 minutos (dose máxima 30 mg)
- D Hidralazina 50 mg VO a cada 20-30 minutos (dose máxima 100 mg)

4000241796

Questão 197

2025 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)
Síndrome HELLP

Uma paciente com IG de 32 semanas e diagnóstico prévio de pré-eclâmpsia grave é encaminhada para parto cesariano. A indicação de interrupção pré-termo da gestação ocorreu após a instalação de síndrome HELLP completa. Além de plaquetopenia e aumento das enzimas hepáticas, o médico observou a presença de sinais laboratoriais de hemólise. Qual das seguintes alterações reforçam a presença deste último parâmetro?

- A TTPA alargado e TGP elevada
- B TAP alargado e creatinina elevada
- C TGO e Bilirrubina direta aumentada
- D LDH e Bilirrubina indireta aumentada

4000241777

Questão 198

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Síndrome HELLP

Uma gestante, com 34 semanas, apresenta convulsão tônico-clônica generalizada, precedida por quadro de cefaleia intensa. Sua pressão arterial é de 170/110 mmHg e há presença de proteinúria significativa. A família nega episódios anteriores de convulsão e os últimos exames, realizados há 2 dias, mostram aumento de bilirrubina indireta e do LDH. Que outros achados laboratoriais são frequentemente encontrados nessa condição clínica?

- ☐ A Potássio aumentado, sódio baixo e troponina elevada.
- ☐ B Plaquetas altas, ureia baixa e enzimas hepáticas diminuídas.
- ☐ C Hemoglobina aumentada, leucócitos baixos e glicemia baixa.
- ☐ D Plaquetas diminuídas, creatinina elevada e anemia hemolítica.

4000271625

Questão 199

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Medicamentoso

Cerca de 80 a 90% das mulheres portadoras de diabetes gestacional são tratadas apenas com a mudança de estilo de vida com dieta e exercícios (ADA, 2014). Todavia, 10 a 20% das gestantes diabéticas necessitarão fazer uso de insulina. Quais níveis glicêmicos indicariam a necessidade deste tipo de terapia?

- ☐ A Pré-prandiais > 83 mg/dL.
- ☐ B Pré-prandiais > 92 mg/dL.
- ☐ C Pós-prandiais de 1 h > 130 mg/dL.
- ☐ D Pós-prandiais de 2 h > 120 mg/dL.

4000214042

Questão 200

2026 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Diagnóstico da sífilis Tratamento da sífilis na gestação

Gestante de 24 semanas apresenta VDRL reagente (1:32) e teste treponêmico positivo. Ela relata nunca ter feito tratamento para a doença em questão e nega qualquer sintoma no momento. O exame físico geral e obstétrico é normal. Diante destes dados, qual a conduta mais adequada para essa paciente?

- A Prescrever penicilina benzatina 2,4 milhões UI IM, dose única e encaminhar para seguimento em pré-natal de alto risco.
- B Notificar o caso como sífilis secundária, prescrever azitromicina oral por 5 dias para tratamento da paciente e de seu parceiro.
- C Solicitar ultrassonografia morfológica para rastrear sinais de comprometimento fetal, iniciar tratamento com ceftriaxona IM por 3 dias.
- D Notificar o caso como sífilis latente de tempo indeterminado e prescrever Penicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, 1 dose semanal por 3 semanas.

4000271624

Questão 201

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Rastreamento de anomalias cromossômicas

Gestante de 42 anos, com idade gestacional de 12 semanas, realiza ultrassonografia obstétrica. O médico avalia a medida da translucência nuchal e a presença do osso nasal. Considerando a idade gestacional e os parâmetros avaliados, qual o principal objetivo do exame neste contexto específico?

- A Estimar o peso fetal para avaliação do crescimento intrauterino precoce
- B Avaliar a vitalidade fetal por meio da frequência cardíaca e movimentos espontâneos
- C Realizar o rastreamento de anomalias cromossômicas, como a trissomia do cromossomo 21
- D Detectar precocemente malformações cardíacas estruturais por meio de ecocardiografia fetal

4000271621

Questão 202

2025 Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto)

Diagnóstico Etiologia Prognóstico

Paciente de 26 anos, com IG de 23 semanas calculada por USG de 6 semanas, sem comorbidades, apresenta ao exame físico útero pequeno para a idade gestacional (AU 19 cm), PA 95 x 65 mmHg, BCF 148 bpm. Seus USG morfológico de 2º trimestre, realizado há 2 dias, evidencia maior bolsão de líquido amniótico com menos de 1 cm no seu diâmetro vertical, além de agenesia renal bilateral no concepto. Doppler de artérias uterinas, umbilical e cerebral média normais. Qual complicação é mais frequente nesta situação clínica?

- A Corioamnionite
- B Hipoplasia pulmonar fetal
- C Malformação cardíaca fetal
- D Pré-eclampsia de início precoce

4000241789

Questão 203

2025

Privado

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Prevenção na gestação

Rastreamento na gestação

Manifestações clínicas

Gestante de 10 semanas, assintomática, comparece para consulta de pré-natal trazendo os resultados dos exames de rotina iniciais, colhidos há 1 semana. A sorologia para toxoplasmose revela IgM reagente e IgG não reagente. Qual a conduta correta diante deste resultado?

- A Prescrever espiramicina e solicitar teste de avides de IgG.
- B Iniciar espiramicina e repetir a sorologia em 2 ou 3 semanas.
- C Solicitar teste de avides de IgM, se confirmada alta avides, iniciar espiramicina.
- D Pedir teste de avides de IgG, se confirmada baixa avides, iniciar esquema tríplice.

4000241791

Questão 204

2024

Acesso Direto (R1)

Privado

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Tratamento

G3 PC2 A0, 28 anos, IG: 35s 2d, foi internada após realização de cardiotocografia (CTG) que evidencia traçado com padrão sinusoidal. Logo após este exame, ela passa por avaliação ultrassonográfica com Doppler sendo observado que o feto apresenta estado hiperdinâmico, decorrente de diminuição da viscosidade sanguínea. O estudo Doppler revela pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média > 1,5 MoM. Qual a conduta adequada para o caso?

- A Indicar parto cesariano.
- B Hidratar e repetir a CTG em 24h.
- C Realizar transfusão intra-uterina.
- D Induzir parto normal com CTG intraparto.

4000214043

Questão 205

2025

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Residência (Acesso Direto)

Varicela

Indicações

Indicação

Em uma enfermaria de pediatria, um lactente de 9 meses internado há dois dias evolui com varicela. Na mesma enfermaria, está internado também um escolar de 7 anos, portador de síndrome nefrótica, em uso de corticoterapia há 4 semanas, sem história prévia de vacinação ou doença por varicela. Qual é a conduta correta em relação ao escolar?

- A Realização imediata da vacina, como forma eficaz de profilaxia pós-exposição, mesmo em pacientes imunossuprimidos.
- B Iniciar aciclovir venoso por 7 dias como forma terapêutica pós-exposição devido o paciente ser imunocomprometido e pelo alto risco de transmissão da varicela.
- C Isolamento e manter em observação, uma vez que a vacina é contraindicada e a imunoglobulina ineficaz para prevenção em imunossuprimidos.
- D Realizar imunoglobulina específica Varicela Zoster (VZIG) como forma de profilaxia pós-exposição devido o paciente ser imunocomprometido.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241716](#)

Questão 206

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Ingurgitamento mamário Bebê que não suga

Mãe e recém-nascido (RN) de sete dias de vida são atendidos em consulta de puericultura. Ao exame, o RN apresenta perda ponderal de 12% em relação ao peso de nascimento, está choroso, sem icterícia ou sinais de desconforto respiratório. O exame materno revela mamas ingurgitadas, doloridas e com fissuras em ambos os mamilos. Durante a amamentação, o RN está choroso, ativo e reativo, mas apresenta pega inadequada e sucção pouco eficiente. Qual a conduta mais adequada para o caso?

- A Internação da mãe e do filho, a fim de realizar propedêutica e uso de vitamina K sob suspeita de doença hemorrágica do recém-nascido.
- B Manter o aleitamento materno, com correção da pega e realizar coleta de exames do RN sob suspeita de doença hemorrágica do recém-nascido.
- C Prescrever complementação para o RN, com contraindicação de aleitamento materno por até 48 horas e realizar translactação com a técnica sonda-mamilo posteriormente.
- D Estimular o aleitamento materno, instruir a mãe a realizar a ordenha do leite, com correção da pega do RN e manter conduta expectante, com novo peso do RN em até sete dias de vida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241721](#)

Questão 207

2024 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Complicações Avaliação Laboratorial

Indígena de dois anos, internado há 15 dias por desnutrição proteico-calórica (marasmo) associada a erro alimentar grave, iniciou terapia de renutrição há três dias. Neste caso, deve ser monitorado, principalmente, o nível sérico de:

- A sódio
- B potássio
- C fósforo
- D cálcio

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214018](#)

Questão 208

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Aspectos Clínicos Quadro clínico Diagnóstico Tratamento Medicamentoso

Em relação ao tratamento das pneumonias na faixa etária pediátrica, de acordo com as recomendações da OMS, é correto afirmar que:

- A Pneumonia sem tiragem subcostal deve ser tratada com cefalosporina de terceira geração em esquema parenteral.
- B Na suspeita de pneumonia atípica recomenda-se azitromicina ou claritromicina.
- C A associação de amoxicilina com inibidores de beta-lactamase, como o clavulanato ou o sulbactam, ou a cefuroxima é a opção de escolha para as pneumonias hospitalares tardias complicadas com derrame parapneumônico.
- D A amoxicilina não configura tratamento seguro para pneumonia da comunidade sem evidência de sinais de gravidade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241725](#)

Questão 209

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Diagnóstico Aspectos Clínicos Quadro clínico Diagnósticos diferenciais

Lactente de 4 meses e 15 dias é trazido ao pronto-atendimento com quadro de tosse seca que impede a criança de mamar, associado a vômitos induzidos pela tosse. O quadro iniciou com coriza hialina e febre baixa, mas piorou há dois dias, mantendo febre e apresentando crises de tosse paroxística, acompanhadas de cianose e guincho inspiratório. Nascido a termo, parto normal, sem intercorrências, vacinação em dia. Hemograma revela 32.500 leucócitos, com 32% neutrófilos, 65% linfócitos, 1% eosinófilos, 2% basófilos, e 255.000 plaquetas. Qual é o diagnóstico mais provável e o tratamento indicado?

- A Coqueluche e azitromicina
- B Infecção por influenza e oseltamivir
- C Laringite e inalação com adrenalina
- D Bronquiolite e inalação com salbutamol

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241741](#)

Questão 210

Vigilância Epidemiológica

Em 2025, o Brasil registrou 37 casos de sarampo, todos classificados como importados ou relacionados à importação, distribuídos em sete estados, com maior concentração em Tocantins (25 casos) e Mato Grosso (6 casos). Apesar da perda do status de região livre de transmissão endêmica nas Américas, o Brasil manteve sua certificação nacional, graças às ações de vigilância epidemiológica, que incluíram rastreamento de contatos, bloqueio vacinal e intensificação da imunização em áreas de fronteira. Considerando esse cenário e os princípios da vigilância epidemiológica, assinale a alternativa que representa a conduta correta diante de surtos de sarampo importados em comunidades com baixa cobertura vacinal (91,5% para a primeira dose e 75,5% para a segunda dose da tríplice viral em 2025). (Fonte: Sarampo volta a circular nas Américas e Brasil confirma 37 casos importados | VEJA. Acessado em: 14/11/2025).

- A Realizar meramente o isolamento dos casos confirmados, com descontinuidade do rastreamento de contatos, já que o Brasil não apresenta circulação endêmica do vírus.
- B Priorizar meramente a vacinação de viajantes internacionais que retornam ao Brasil após visitar áreas endêmicas, pois os surtos de sarampo em 2025 foram relacionados à importação.
- C Implementar bloqueio vacinal imediato em contatos próximos aos casos identificados, intensificar a busca ativa de casos suspeitos e reforçar a vacinação em áreas de fronteira.
- D Manter a vigilância passiva, aguardando notificações espontâneas dos serviços de saúde, visto que a certificação nacional de eliminação do sarampo permanece válida.

4000271601

Questão 211

Mononucleose

Apresentação Clínica

Tratamento

Escolar de oito anos é levado a consulta de emergência devido a quadro de febre alta (39°C) e dor de garganta há quatro dias. Os pais informam que o paciente vem recebendo azitromicina há 48 horas sem melhora. Exame físico: exsudato purulento sobre as amígdalas, hiperemia de pilar anterior, petéquias em palato, linfadenomegalia generalizada e ponta de baço palpável. A principal hipótese diagnóstica e a conduta indicada nesse momento são, respectivamente:

- A mononucleose infecciosa - suspender azitromicina
- B Difteria - iniciar soro antidiftérico e manter azitromicina
- C amigdalite estreptocócica com evolução para glomerulonefrite difusa aguda - manter antibiótico
- D difteria - iniciar soro antidiftérico e substituir azitromicina por eritromicina

4000214012

Questão 212

Tratamento

Pré-escolar, 7 anos, sexo feminino, com queixa de dor de garganta e febre de 38,9°C há 3 dias, lesões na

pele há 1 dia e dor abdominal difusa hoje. Nega tosse, coriza e alteração do hábito intestinal. Apresenta, ao exame físico, exantema cutâneo micropapular áspero generalizado, com palidez perioral e hiperemia em dobras cutâneas. Linfonodos palpáveis menores do que 1 cm em cadeia cervical e submandibulares bilateralmente. Orofaringe hiperemiada com petéquias em palato e língua em framboesa. Ausculta cardiopulmonar sem alteração. Abdome flácido sem visceromegalias, com descompressão brusca negativa. Entre as seguintes propostas terapêuticas, a mais adequada para este paciente é:

- A dipirona e amoxicilina
- B paracetamol, ibuprofeno e hidroxizine
- C paracetamol e ibuprofeno
- D azitromicina, hidroxizine e dipirona

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214013](#)

Questão 213

2024 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)
Plano C Fase de expansão Fase de manutenção

Em relação à terapia de hidratação venosa em pediatria, assinale a alternativa correta.

- A O uso de soluções salinas isotônicas deve ser considerado para pacientes pediátricos que apresentam valores de sódio acima de 145 meq/L.
- B Crianças doentes apresentam predisposição para liberação de ADH, o uso de soluções hipotônicas nesses pacientes aumentam o risco de hiponatremia.
- C Soluções de hidratação venosa hipotônicas aumentam o risco de o paciente desenvolver acidose metabólica hiperclorêmica.
- D Quantificar a necessidade hídrica em pediatria com a fórmula de Holiday-Segar atende às necessidades de todos pacientes, sejam eletivos ou na emergência.

4000214007

Questão 214

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Plano C Fase de expansão

Lactente de nove meses, 8 kg, é levado ao pronto socorro por vômitos, febre e diarreia explosiva, com rajas de sangue há cerca de 48 h. Dá entrada em grave estado geral às custas de obnubilação, fontanela deprimida, choro sem lágrimas e pulso débil, com cianose de extremidades e enchimento capilar > 4 segundos. Em relação à reposição volêmica, deve ser iniciado:

- A soro fisiológico intravenoso 160 ml em 30 minutos.
- B soro glicofisiológico intravenoso, 160 ml ao longo de 1 hora.
- C gastróclise, com o uso de soro de reidratação oral.
- D ringer lactato intravenoso 480 ml ao longo de 2 horas

4000214015

Questão 215

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Tratamento Testes sorológicos Endoscopia intestinal com biópsia

Adolescente de 12 anos, sexo feminino, com diagnóstico de DM1 há 6 meses. Apresenta bom controle glicêmico, recebendo insulina 3 vezes ao dia. Apresenta bom crescimento e desenvolvimento, nega diarreia. Realizou exames que mostraram aumento dos auto-anticorpos antiendomísio IgA 1:1280 e anti transglutaminase IgA 144. Realizado EDA, com resultado normal, e biópsia duodenal apresentando hipotrofia de vilosidades e aumento do número dos linfócitos intra-epiteliais. Qual a recomendação correta para esta paciente?

- A Não deve ingerir alimentos que contenham trigo, cevada, aveia e centeio.
- B Além dos cuidados com a diabetes, não há necessidade de outras restrições alimentares.
- C Não deve ingerir alimentos que contenham soja, milho e lentilha.
- D Não deve ingerir produtos que contenham caseína

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214014](#)

Questão 216

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Diagnóstico Classificação das anemias Foco na ferropriva Hemoglobina Hematócrito e Contagem de Hemácias

Lactente de 1 ano e 8 meses, do sexo feminino, é levada à consulta de puericultura. A mãe relata irritabilidade e hábito de comer terra (geofagia). A criança tem má aceitação do almoço e do jantar, frequentemente substituindo as refeições por uma mamadeira de 200 mL de leite integral de vaca. Quais são os achados esperados no hemograma dessa criança, respectivamente, para RDW, VCM e CHCM?

- A Alto, alto e alto
- B Baixo, alto e normal
- C Baixo, baixo e baixo
- D Alto, baixo e baixo

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241710](#)

Questão 217

2024 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Paciente de quatro anos apresenta febre há 6 dias, persistente, associada à linfadenomegalia, exantema escarlatiniforme, edema de mãos e pés, além de língua em framboesa e hiperemia conjuntival bilateral sem secreção. Conforme relato, o diagnóstico mais provável e o seu respectivo tratamento são:

- A escarlatina e amoxicilina oral.
- B doença de Kawasaki e imunoglobulina humana associada ao uso de ácido acetilsalicílico.
- C artrite idiopática juvenil e anti-inflamatório não esteroidal.
- D mononucleose e sintomáticos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214020](#)

Questão 218

2025 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Aspectos Clínicos Quadro clínico e Diagnóstico Diagnóstico diferencial

Menino de 4 anos é levado à consulta pediátrica com febre há 6 dias (39,4 °C) e queda do estado geral. No dia da consulta, apresentou "vermelhidão pelo corpo" e olhos vermelhos. A vacinação está em dia, e não há histórico de alergias. Ao exame, observa-se linfonodomegalia cervical à direita (gânglios de até 2 cm, endurecidos), orofaringe hiperemiada sem pus, exantema generalizado (principalmente em períneo), hiperemia conjuntival e edema discreto de mãos e pés. Exames laboratoriais revelam: Hb = 10,5 g/dL, leucócitos = 16.500/mm³ (49% neutrófilos, 43% linfócitos), plaquetas = 230.000/mm³ e VHS = 75 mm. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- A Doença de Kawasaki
- B Exantema súbito
- C Escarlatina
- D Varicela

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241739](#)

Questão 219

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Aspectos Clínicos Quadro clínico e Diagnóstico Diagnóstico diferencial Tratamento

Lactente de 1 ano de idade com 8 dias de febre alta e persistente, evolui com taquicardia, conjuntivite asséptica, língua em framboesa, exantema escarlatiniforme predominante em tronco e fissuras labiais, além de edema e descamação das extremidades. Hemograma apresenta leucocitose e plaquetose, assim como Peptídeo natriurético tipo B terminal nitrogenado (NT-proBNP) bastante elevado. Baseado nestas informações, marque a afirmativa correta.

- A A principal hipótese diagnóstica é de adenovirose e o menor deverá receber sintomáticos.
- B Trata-se de um caso de escarlatina e o paciente deverá receber penicilina benzatina.
- C O lactente em questão apresenta Doença de Kawasaki e deve receber Imunoglobulina humana e ácido acetilsalicílico como primeira linha de tratamento.
- D O lactente apresenta urticária infecciosa e deve receber corticosteroide e antihistamínico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271566](#)

Questão 220

2026 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Tratamento da Crise Adrenal

Recém-nascido com 9 dias de vida, sexo masculino. apresenta, há 48 horas, episódios de vômitos e hipoatividade. Família nega febre. Pré-natal e gestação sem intercorrências. Nascido de parto normal, adequado para idade gestacional, alta da maternidade com 2 dias de vida. Está em aleitamento materno exclusivo. Ao exame físico, encontra-se pouco ativo, desidratado (++/4), corado, acianótico e anictérico. Ausculta respiratória e cardíaca sem alterações. Abdome flácido, indolor à palpação, sem visceromegalias. Genitália aparentemente masculina, criptorquidia bilateral e hipospádia. A dosagem de eletrólitos evidenciou: Na = 124mEq/L (VR: 135-145 mEq/L) e K = 6,5mEq/L (3,5 - 5 mEq/L). A principal hipótese diagnóstica e o tratamento indicado nesse momento, respectivamente, são:

- A Estenose hipertrófica de piloro. Dilatação endoscópica
- B Estenose hipertrófica de piloro. Tratamento cirúrgico
- C Hiperplasia adrenal congênita. Metilprednisolona
- D Hiperplasia adrenal congênita. Hidrocortisona

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271579](#)

Questão 221

2025 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)

Vias aéreas Causas de PCR Manejo da Via Aérea

Considerando a parada cardiorrespiratória (PCR) na criança, é correto afirmar que:

- A Após a intubação orotraqueal, deve-se realizar compressão/ventilação na razão 15:2.
- B A conduta na assistolia é a desfibrilação com dose de 2-4 J/kg, no primeiro choque, e de 4 J/kg, no segundo choque.
- C O acesso venoso periférico não deve ser utilizado para administração de drogas, devendo-se garantir acesso central ou intraósseo.
- D Pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco são considerados causas reversíveis e devem ser tratados durante a ressuscitação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241736](#)

Questão 222

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Taquiarritmias

Em relação aos distúrbios de ritmo cardíaco no período neonatal, é correto afirmar que:

- A O flutter atrial é o distúrbio mais frequente.
- B Taquicardia Supraventricular é a arritmia mais frequente do período neonatal.
- C O bloqueio átrio ventricular está relacionado à hipercalemia fetal secundária ao uso de medicações maternas.
- D Os distúrbios de ritmo cardíaco são condições agudas frequentes do período neonatal, sendo a bradicardia sinusal o distúrbio mais prevalente.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000271568

Questão 223

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Quadro Clínico do Choque Séptico Monitoração Tratamento Geral do Choque

Lactente de 7 meses de idade, com diagnóstico de choque séptico, está internado na UTI pediátrica. Encontra-se intubado e em ventilação mecânica. Foi expandido com cristaloides, totalizando 60 mL/kg. Dados clínicos atuais: FC= 165 bpm; FR = 30 irpm; PA = 72x45 mmHg; débito urinário de 1,0 mL/kg/h; pulsos periféricos finos; tempo de enchimento capilar de 4 segundos; extremidades frias. Qual a conduta mais adequada?

- A Fazer furosemida.
- B Expansão com coloide.
- C Iniciar adrenalina contínua.
- D Nova expansão de cristalóide, 20 mL/kg em vinte minutos.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000241728

Questão 224

2026 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)

Sepse Diagnóstico Exames Laboratoriais

Em relação à sepse, é CORRETO afirmar:

- A** Os Critérios de Sepse de Phoenix definem a sepse pediátrica como disfunção orgânica potencialmente fatal dos sistemas respiratório, cardiovascular, de coagulação e/ou neurológico, evidenciada por uma pontuação mínima no Phoenix Sepsis Score (PSS), em contexto de infecção confirmada ou suspeita.
- B** Durante a ressuscitação volêmica, dois acessos venosos periféricos e/ou devem ser utilizados, deixando a intraóssea como segunda opção, visto que não se pode administrar hemocomponentes, bem como aminas vasoativas.
- C** Os critérios de sepse pediátrica aplicam-se a crianças menores de 14 anos, envolvendo recém-nascidos ou neonatos cuja idade pós-concepcional seja inferior a inferior a 37 semanas.
- D** A ferritina não deve ser utilizada como marcador de inflamação, no caso de choque séptico de má evolução, uma vez que quando o valor se encontra acima de 500 ng/ml, pode determinar o uso de terapia específica como corticosteroides, imunoglobulina, plasmaférese ou mesmo imunossupressão.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271569](#)

Questão 225

2024 Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1)

Tratamento de Resgate

Recém-nascido do sexo masculino, nascido à termo, de parto vaginal a fórceps, por parada de progressão, foi intubado ainda na sala de parto por apneia e hipotonia. Após o nascimento, foi encaminhado à UTI Neonatal, onde foi assistido e após 72 h, foi extubado com sucesso. Permaneceu sem antibióticos, por infecção neonatal descartada. No quinto dia de vida, durante o atendimento de fisioterapia apresentou movimentos tônicoclônicos em dimidio direito, associados a movimentos mastigatórios, cianose e sialorreia.

Foi assistido pela equipe de plantão, com oferta de oxigênio a 100%, monitorização e glicemia capilar de 73 mg/dL. A próxima conduta deve ser:

- A** dose de ataque de fenobarbital.
- B** solução de glicose a 10% em bolus.
- C** glucanato de cálcio em bolus.
- D** benzodiazepínico em bolus.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214016](#)

Questão 226

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Tratamento de Resgate Tratamento Inicial

Paciente de 3 anos portador de Epilepsia mioclônica grave da infância (Doença de Dravet), evolui com estado de mal epilético, apesar do uso contínuo de esquema medicamentoso anticonvulsivante amplo, incluindo canabidiol. Após a admissão no Box de Emergência, o menor evoluiu com depressão respiratória e a equipe optou pela intubação orotraqueal. Com base neste enunciado, marque a afirmativa correta:

- A O paciente deve receber fentanil, visto a contraindicação do uso de cetamina, pelo estado de mal epilético.
- B O paciente deve ser intubado com etomidato, visto seu efeito sedativo quase imediato, sem causar instabilidade hemodinâmica.
- C O paciente não deve receber bloqueador neuromuscular, pelo risco de hipertermia maligna nos pacientes portadores de Doença de Dravet.
- D O midazolan está bem indicado dentro da sequência rápida de intubação, para este paciente.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000271565

Questão 227

2024 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Diagnóstico Cutâneo Subcutâneo e Mucosa Sistema Respiratório

Criança de 4 anos foi ferroadada por formigas nas pernas e pés. Após alguns minutos iniciou com urticária generalizada, tosse, rouquidão e desconforto respiratório. Previamente já tinha sido ferroadada por formigas, sem reação alguma. **Assinale a conduta terapêutica mais indicada para este caso.**

- A Broncodilatadores (beta-2 agonistas) em aerossol com O2 100%
- B Adrenalina IM
- C Corticoide e anti H1 e H2 EV
- D Anti-histamínico IM

Essa questão possui comentário do professor no site 4000214010

Questão 228

2026 Acesso Direto (R1) Privado Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Diagnóstico Quadro Clínico Diagnóstico Diferencial

Lactente com 1 ano de idade, é trazido ao pronto-atendimento, com relato de que brincava junto com o irmão de cinco anos num quarto de brinquedos em sua casa, sem supervisão contínua de um adulto, quando o pai - que é médico generalista - ouviu tosse persistente, seguida de estridor e broncoespasmo. Ao chegar no quarto, o pai também observou que a criança estava cianótica. Nega febre ou doenças prévias. Nesse caso, qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A Intoxicação exógena
- B Exacerbação de asma
- C Aspiração de corpo estranho
- D Laringite viral aguda

Essa questão possui comentário do professor no site 4000271575

Questão 229

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Sobre as novas recomendações da AHA (American Heart Association) para vítimas de engasgo, é correto afirmar:

- A Em adultos e crianças conscientes, por engasgo com alimento líquido, deve-se realizar a manobra de Heimlich
- B Para crianças a partir de seis meses deve-se realizar a manobra 5-5, que requer a manobra de Heimlich alternada com 5 golpes utilizando a região hipotenar da mão direita, nas costas do doente
- C Para bebês com menos de um ano, deve-se alternar 5 palmadas nas costas e cinco compressões no peito, usando dos dois dedos médios na região do esterno, até que o corpo estranho seja expulso
- D Nos menores de um ano de idade as compressões abdominais estão contraindicadas sob o risco de lesão de órgãos internos

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271570](#)

Questão 230

2026

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Diagnóstico

Sinais e sintomas

Tratamento

Recém-nascido, cinco dias de vida, apresenta quadro de palidez cutâneo-mucosa, exantema petequial, hepatoesplenomegalia, icterícia de 2+/4 até zona III de Kramer e microcefalia. Realizada coleta de sorologias (em andamento) e USG transfontanela que revelou dilatação ventricular e calcificações intracranianas periventriculares. A principal hipótese diagnóstica e o tratamento indicado são, respectivamente:

- A Infecção congênita pelo citomegalovírus. Ganciclovir
- B Neurosífilis congênita. Penicilina G cristalina
- C Toxoplasmose congênita. Sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico
- D Infecção congênita por herpes simples. Aciclovir

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271574](#)

Questão 231

2024

Residência (Acesso Direto)

Processo Seletivo Unificado - PRMMT

Acesso Direto (R1)

Privado

Quadro clínico

Antibioticoterapia

Exames laboratoriais

Lactente, 55 dias de vida, sexo feminino é levada à emergência por apresentar febre (38,9° C) há dois dias, irritabilidade e recusa alimentar, além de diarreia. Admitido em regular estado geral, sonolento e pálido ++/4+. FC: 155 bpm, ausculta cardiorrespiratória normal. Abdome: normotenso. Perfusão periférica: 4 seg. Exames laboratoriais: EAS (coletado por cateterismo vesical): densidade: 1.008, pH: 5,5 leucócitos: 100.000/ml; cilindros piocitários raros; hemácias: 15.000/ml; proteinúria ++. Raio X de tórax: normal. A principal hipótese diagnóstica e a melhor medicação escolhida para tratamento são, respectivamente:

- A meningite e penicilina cristalina
- B gastroenterite aguda e ceftriaxona
- C ITU e ampicilina + gentamicina
- D ITU e amoxicilina + clavulanato

4000214009

Questão 232

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Doenças da coluna vertebral Osteomielite Osteomielite

Mulher, 73 anos, internada na enfermaria da clínica médica há 21 dias, sendo que antes disso ficou 16 dias na UTI devido a pneumonia, tendo ficado 7 dias em ventilação mecânica e 13 dias com acesso venoso central. Durante a internação, desenvolveu sepse por infecção primária da corrente sanguínea com *Staphylococcus aureus*. Há 4 dias, relata lombalgia intensa com dor à palpação dos processos espinhosos L2-L3, sem sinais de flogose ou lesão local. A ressonância magnética mostra pequena coleção no músculo psoas e acometimento vertebral L2-L3, sugerindo processo infeccioso/inflamatório. Qual é o diagnóstico correto e sua respectiva patogenia?

- A Miosite por contiguidade
- B Osteomielite por inoculação
- C Espondilodiscite por via hematogênica
- D Espondilodiscite por inoculação

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241748](#)

Questão 233

2025 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado
Traços de Fraturas Fraturas do Antebraço

Um paciente de 10 anos foi atendido após cair enquanto brincava no parque. Ao exame clínico, ele apresenta dor intensa e deformidade visível no antebraço direito. A radiografia revela uma fratura em que a cortical do rádio está rompida em um lado, enquanto no outro lado do osso há uma curvatura, mas sem ruptura da cortical. Não há desvio significativo dos fragmentos ósseos. Com base na descrição clínica e radiológica, qual o tipo de fratura?

- A Fratura em galho verde.
- B Fratura transversa.
- C Fratura em fivela.
- D Fratura espiral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241806](#)

Questão 234

Síndrome Adrenérgica

Um estudante universitário de 25 anos é trazido ao prontoatendimento por amigos devido a tremores, inquietude, irritação, calafrios, vômitos e mialgia nas últimas horas. Ao exame, apresenta mau estado geral, hipertensão, taquicardia, sudorese e bulhas arrítmicas. Alterações nos exames complementares incluem: creatinina 3,1 mg/dL (VR: 0,6-1,3 mg/dL), CPK 56.000 U/L (VR: 30-200 U/L), potássio 6,5 mEq/L (VR: 3,5-5,5 mEq/L), fósforo 6,0 mg/dL (VR: 2,5-4,5 mg/dL), cálcio 6,4 mg/dL (VR: 8,8-10,4 mg/dL). Os amigos negam comorbidades e uso de drogas ilícitas, mas relatam consumo de medicamentos estimulantes e bebidas energéticas durante uma semana de provas, com doses progressivamente aumentadas. Qual substância é mais provável de justificar o quadro clínico?

- A Taurina
- B Anfetamina
- C Glucoronolactona
- D Benzodiazepínico

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241763](#)

Questão 235

Síndrome Colinérgica

Menino de 7 anos, procedente de área rural, é atendido na unidade de emergência com lacrimejamento, sialorreia, miose, sudorese, roncos e estertoração pulmonar, vômitos, diarreia, bradicardia e tremores. Os sintomas estão associados a uma intoxicação exógena cuja principal síndrome é:

- A Narcótica, geralmente secundária ao uso de benzodiazepínicos e opioides.
- B Colinérgica, possivelmente secundária a anti-histamínicos como a prometazina.
- C Anticolinérgica, possivelmente secundária a carbamatos, fosforados ou alguns cogumelos.
- D Colinérgica, possivelmente secundária a organoclorados e organofosforados, sendo também conhecida como síndrome molhada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000241718](#)

Questão 236

Síndrome Narcótica Intoxicação por Opioides

Você é chamado para ajudar o outro plantonista médico do plantão, o qual fez uso de Fentanil para analgesia de um paciente no pronto atendimento que chegou com dor intensa (nota 10/10 na Escala Numérica da Dor) e disse ter "alergia" a morfina. Após a administração do medicamento paciente apresentou rebaixamento do nível de consciência, bradipneia, bradicardia e miose. O efeito desta medicação pode ser revertido por meio de qual medicação?

- A Flumazenil
- B Naloxona
- C Glucagon
- D Adrenalina

Essa questão possui comentário do professor no site [4000214028](#)

Questão 237

2026 Residência (Acesso Direto) Processo Seletivo Unificado - PRMMT Acesso Direto (R1) Privado

Síndrome Narcótica Intoxicação por Opioides

Pré-escolar de 4 anos, 12 kg, foi submetido a cirurgia abdominal de baixa complexidade com anestesia geral, sem intercorrências. Ao final do procedimento, recebeu uma dose adicional endovenosa de fentanil e cetoprofeno para analgesia. Veio direto para enfermaria pediátrica, 1 hora após o final da cirurgia. Após 30 minutos, você é chamado para avaliar a criança, pois a mãe diz que ela não acorda. Ao exame físico: acianótica, anictérica e afebril. Frequência cardíaca 110 bpm, frequência respiratória 10 irpm, pressão arterial 95 x 55 mmHg, saturação periférica de oxigênio 90% em ar ambiente. Ausculta respiratória mostra murmúrio vesicular simétrico, sem ruídos adventícios. Ausculta cardíaca revela ritmo regular, duas bulhas normofonéticas, sem sopros, pulsos centrais e periféricos fortes, tempo de enchimento capilar 2 segundos. Abdome sem anormalidades. Pupilas mióticas e isocóricas. Com base no quadro clínico acima, qual o tratamento farmacológico imediato mais adequado para esta situação clínica?

- A Haloperidol
- B Naloxona
- C Flumazenil
- D Glicose

Essa questão possui comentário do professor no site [4000271578](#)

Respostas:

1	B	2	B	3	C	4	D	5	C	6	D	7	A	8	A
9	C	10	D	11	A	12	B	13	B	14	A	15	C	16	B
17	C	18	B	19	C	20	B	21	A	22	C	23	B	24	B
25	B	26	D	27	A	28	C	29	B	30	A	31	B	32	B
33	D	34	C	35	D	36	D	37	B	38	A	39	C	40	A
41	A	42	D	43	B	44	A	45	C	46	A	47	C	48	C
49	A	50	C	51	B	52	C	53	A	54	A	55	A	56	D
57	B	58	A	59	D	60	A	61	D	62	B	63	B	64	C
65	D	66	B	67	A	68	B	69	D	70	D	71	A	72	C
73	A	74	D	75	D	76	A	77	D	78	A	79	A	80	C
81	A	82	C	83	B	84	A	85	C	86	D	87	C	88	A
89	B	90	D	91	C	92	D	93	C	94	D	95	C	96	A
97	B	98	C	99	B	100	C	101	A	102	C	103	A	104	C
105	C	106	A	107	A	108	C	109	B	110	C	111	D	112	B
113	B	114	A	115	C	116	D	117	C	118	B	119	A	120	A
121	A	122	D	123	D	124	B	125	C	126	A	127	B	128	C
129	C	130	D	131	B	132	C	133	A	134	A	135	D	136	B
137	A	138	D	139	C	140	B	141	A	142	C	143	C	144	B
145	A	146	D	147	B	148	A	149	D	150	B	151	B	152	B
153	A	154	C	155	D	156	D	157	B	158	B	159	D	160	B
161	B	162	A	163	A	164	B	165	C	166	C	167	C	168	B
169	C	170	B	171	D	172	A	173	A	174	B	175	A	176	B
177	D	178	A	179	C	180	B	181	A	182	B	183	C	184	C
185	B	186	A	187	B	188	B	189	C	190	A	191	B	192	B
193	A	194	B	195	A	196	C	197	D	198	D	199	D	200	D
201	C	202	B	203	B	204	A	205	D	206	D	207	C	208	B
209	A	210	C	211	A	212	A	213	B	214	A	215	A	216	D
217	B	218	A	219	C	220	D	221	D	222	B	223	C	224	A
225	A	226	D	227	B	228	C	229	D	230	A	231	C	232	C
233	A	234	B	235	D	236	B	237	B						